

Christian Flèche

Descodificación biológica de los problemas digestivos

Síntomas, significados y sentimientos

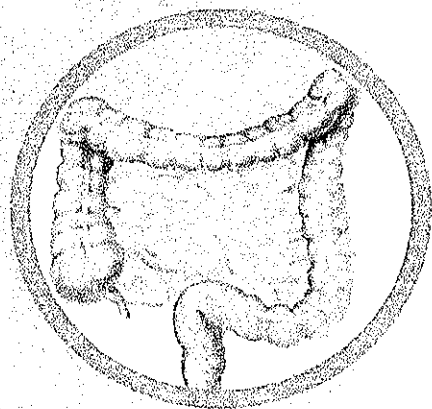


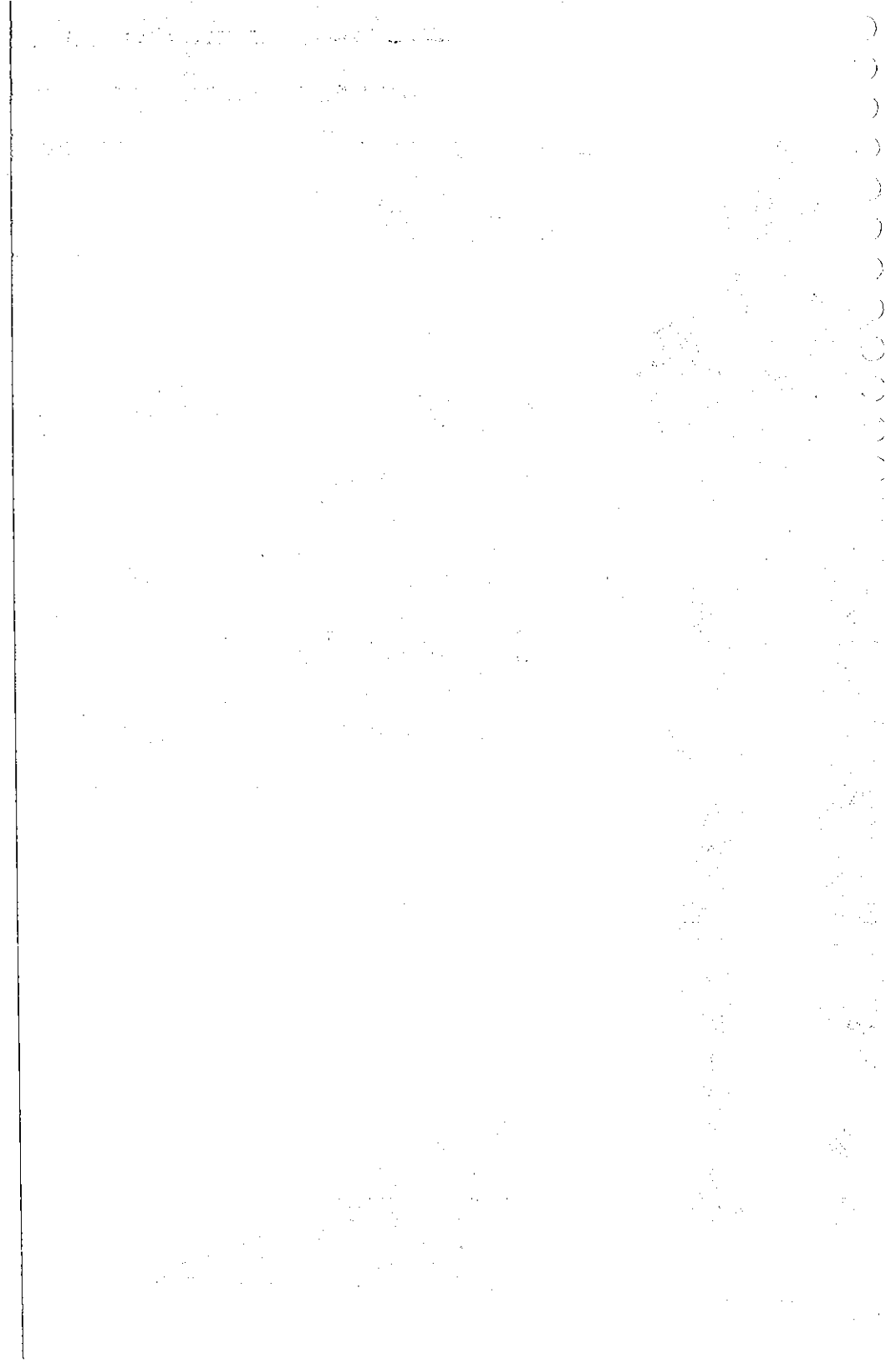
EDICIONES OBELISCO

Christian Flèche

Descodificación biológica de los problemas digestivos

Síntomas, significados y sentimientos





DESCODIFICACIÓN BIOLÓGICA DE LOS PROBLEMAS DIGESTIVOS

Síntomas, significados y sentimientos



EDICIONES OBELISCO

Si este libro le ha interesado y desea que le mantengamos informado de nuestras publicaciones, escríbanos indicándonos qué temas son de su interés (Astrología, Autoayuda, Ciencias Ocultas, Artes Marciales, Naturismo, Espiritualidad, Tradición...) y gustosamente le complaceremos.

Puede consultar nuestro catálogo en www.edicionesobelisco.com

Los editores no han comprobado la eficacia ni el resultado de las recetas, productos, fórmulas técnicas, ejercicios o similares contenidos en este libro. Instan a los lectores a consultar al médico o especialista de la salud ante cualquier duda que surja. No asumen, por lo tanto, responsabilidad alguna en cuanto a su utilización ni realizan asesoramiento al respecto.

Colección Salud y Vida natural

DESCODIFICACIÓN BIOLÓGICA DE LOS PROBLEMAS DIGESTIVOS

Christian Flèche

1.ª edición: mayo de 2015

Título original: *Décodage biologique des problèmes digestifs*

Traducción: *Paca Tomás*

Corrección: *Sara Moreno*

Diseño de cubierta: *Enrique Iborra*

© 2012 Le Souffle d'Or

(Reservados todos los derechos)

Derechos en francés vendidos por Abiali Afidi Ag.

© 2015, Ediciones Obelisco, S. L.

(Reservados los derechos para la presente edición)

Edita: Ediciones Obelisco, S. L.

Pere IV, 78 (Edif. Pedro IV) 3.ª planta, 5.ª puerta

08005 Barcelona - España

Tel. 93 309 85 25 - Fax 93 309 85 23

E-mail: info@edicionesobelisco.com

ISBN: 978-84-16192-65-6

Depósito Legal: B-10.211-2015

Printed in Spain

Impreso en España en los talleres gráficos de Romanyà/Valls S.A.
Verdaguer, 1 - 08786 Capellades (Barcelona)

Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de la cubierta, puede ser reproducida, almacenada, transmitida o utilizada en manera alguna por ningún medio, ya sea electrónico, químico, mecánico, óptico, de grabación o electrográfico, sin el previo consentimiento por escrito del editor.

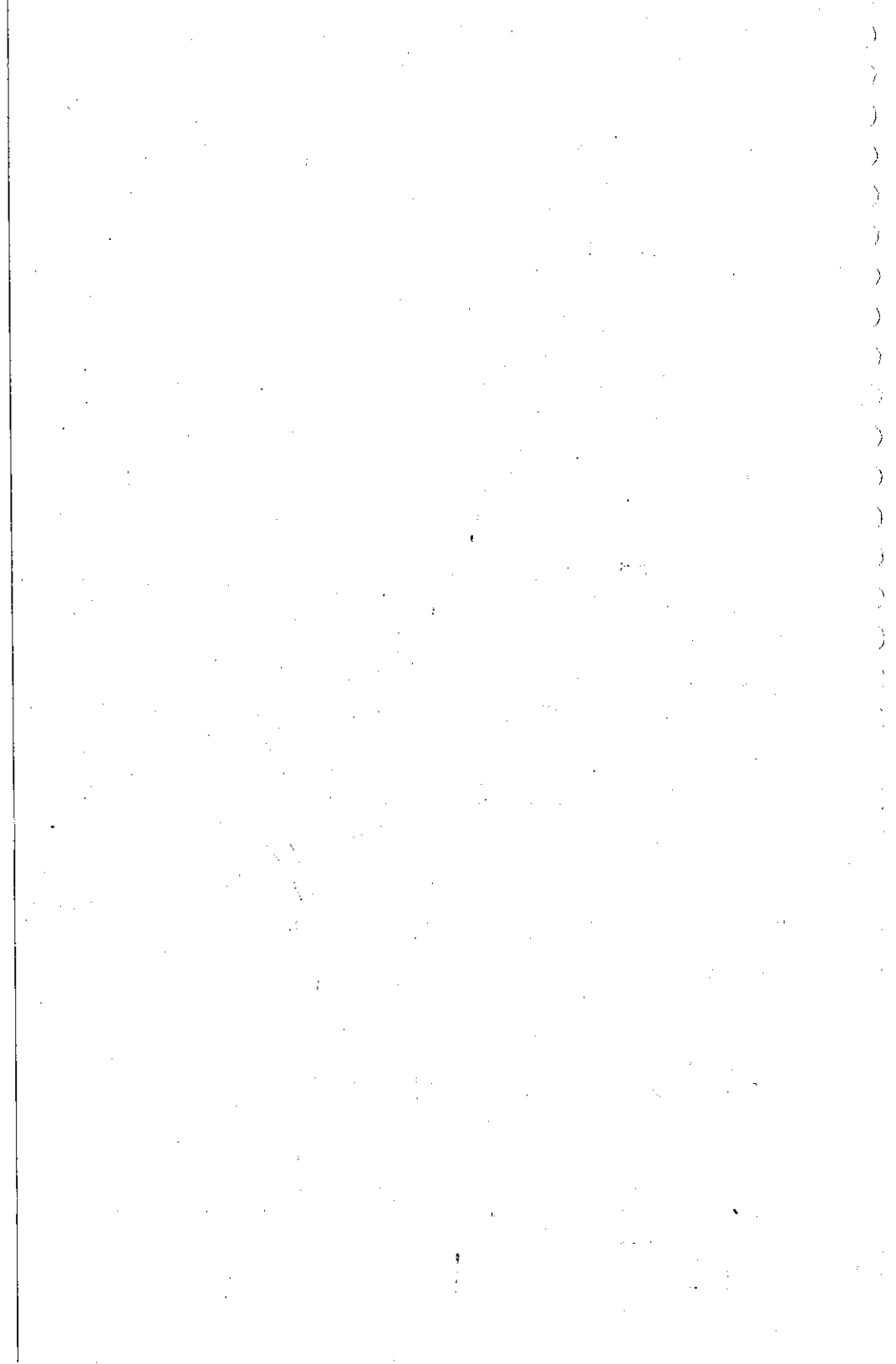
Dírigase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org)

si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

Dedico este libro
a todos mis pacientes
pasados,
presentes
y futuros
que fueron;
son
y serán,
sin saberlo,
mis Maestros.

Me habéis enseñado mi oficio
y me habéis dado tantas lecciones
de humanidad,
sobre la Vida
y sobre mí mismo
que os debo cada línea de este libro.

Gracias.



INTRODUCCIÓN

Descodificación biológica de los problemas digestivos

Síntomas, el sentido y las vivencias

De siempre como de nunca...

Este libro, que tienes entre las manos, es a la vez *antiguo y nuevo*. ¡Como nuestro cuerpo! Resultante de miles de años de adaptación al medio-ambiente, el cuerpo es el testigo de nuestra supervivencia en condiciones de estrés extremadamente variadas: frío, calor, guerra, hambruna, cambios de toda índole... Nuestra presencia viva es, hoy en día, el signo indiscutible del éxito de la última versión biológica, hasta la fecha, que es el cuerpo, este cuerpo inseparable del espíritu. Aquí está el tema de esta serie de obras: «**Descodificación biológica de los problemas de...**» o «*cuando la adaptación se traduce por un síntoma*». Esta colección es, a la vez, una reedición de la estructura y del espíritu del libro precedente, editado en 2001, *Descodificación biológica de las enfermedades – Manual práctico* y una obra totalmente nueva porque todo, de arriba abajo, ha sido revisado y completado. Ante el éxito de esta obra, me ha parecido indispensable ofrecer un manual más funcional, más completo, enriquecido con nuevos ejemplos y nuevas descodificaciones. Te aseguro que lo que se escribió sigue siendo válido, los ojos siempre sirven para ver;

los pulmones para respirar, el eczema está todavía unido a un conflicto de separación. No obstante, después del año de su aparición, mis colegas y yo mismo hemos seguido *¡a la escucha biológica!* Y a cosechar nuevos conocimientos de los vínculos *enfermedad – vivencia biológica conflictiva*, es decir, nuevas descodificaciones biológicas de las enfermedades. Todas esas experiencias han constituido un florilegio, un ramo de flores y unas espigas cargadas de semillas. Las encontrarás en las páginas de esta colección. Una colección dividida por aparatos al igual que nuestro cuerpo, que es un ensamblaje de aparatos: los aparatos digestivo, respiratorio, renal, cardíaco... Todos estos aparatos son solidarios para mantenernos en vida y, con ese objetivo, garantizan una función específica, única: digerir, respirar, eliminar... Así pues, cada obra presentará lo que fue un capítulo del libro precedente. Y la nueva edición del libro completo *Descodificación biológica de las enfermedades – Manual práctico* sigue existiendo.

Fuentes

En cuanto a las **fuentes** de estas descodificaciones biológicas de las enfermedades, encontrarás de vez en cuando en el texto, seguido de un enunciado del conflicto, el nombre de la persona a través de la cual me ha llegado esta descodificación. Por supuesto, esto no le pertenece de ninguna manera, no es el autor, sino el descubridor. Y, hecho curioso, pero no tan sorprendente como parece, a veces, la misma descodificación me ha llegado simultáneamente por dos personas que no se conocían pero que, sencillamente, tenían **la misma escucha**

biológica. De esta forma, la descodificación de las meninges me ha parecido evidente escuchando a una paciente que tenía miedo por su cerebro y quería protegerlo (una de las funciones de estas envolturas que son las meninges es la protección del cerebro). Sorpresa, cuando oí a un médico marsellés proponer la misma descodificación en una conferencia algunos días más tarde. Muy a menudo, observo esta sincronicidad de descubrimiento.

Por estas razones, he escogido no indicar el autor de manera sistemática tras cada descodificación. Según mi punto de vista, el paciente, aquejado de parálisis, de asma o de hemorroides y el terapeuta, teniendo que descodificarlo, sólo tendrán que indicar que se trata del señor Tal o la señora Cual quien ha sido el primero en poner esto en palabras. Lo único que importa es *entender, conocerse, cambiar*. Así, el texto no será recargado y los egos de los descubridores tampoco. Y a veces, de verdad, simplemente he olvidado cómo me ha llegado la información. ¿Fue durante la consulta, que me vino de repente una iluminación? ¿Fue la lectura de la obra de Robert Guinée? ¿De los seminarios ofrecidos por el doctor H. S. Marto, de una conversación con Jean-Jacques Lagardet, Philippe Lévy o Salomon Sellam?

Lo esencial, en el fondo, es que deseo compartir contigo todas nuestras experiencias; porque sé, por vuestros testimonios, el provecho que habéis sacado y el que podréis sacar.

Estas frases conflictivas serán las señales indicativas en tu camino. El objetivo de la búsqueda no es la señal, esta última indica una emoción, pero no solamente una. Por lo tanto, no te pares nunca en una señal, nunca antes de haber revivido o hecho revivir esas emociones, esas vivencias a fondo, es decir, hasta sus transformaciones. Ve hasta el final del camino. Por

eso, es preferible ser dos. *«Una desgracia compartida es la mitad de la pena»*, dice un proverbio sueco. El *shock* es un drama vivido solo. La solución es volver a vivir ese drama, pero a dos. *«Os presto mis orejas con el fin de que podáis oír mejor»* como muy bien dijo y puso en práctica Françoise Dolto.

Especificidades de la bio-descodificación

Por otro lado, si bien otras obras, muy interesantes, proponen vínculos psicológicos con las enfermedades, insisto en repetir **las especificidades de la bio-descodificación.**

No se trata de conflictos psicológicos, sino de **conflictos biológicos**. *¿Pero qué es lo que realmente quiere decir esto?* En efecto, muchos de los investigadores de hoy en día entienden que la enfermedad tiene un sentido preciso: psicológico, simbólico, metafísico... Hipótesis siempre apasionantes porque el enfermo se descubre a sí mismo. Hasta Hipócrates, él mismo, afirmaba: *«El cuerpo crea una enfermedad para curarse»*. ¿Pero curarse de qué?

- ¡De algo, forzosamente, **peor que la enfermedad!** Si no, esto sería de una perversidad cruel, ilógica.
- ¡De algo de lo que aún **no tenemos conciencia**, por supuesto, si no, todo el mundo estaría de acuerdo sobre el origen de las enfermedades!
- De algo de lo que la enfermedad sería como la solución, la salida de emergencia. Es esto mismo lo que propone la bio-descodificación: ¡la enfermedad es útil y, a veces, vital! Es lo que llamo **«el sentido biológico»** de las enfermedades. ¿De qué se trata?...

El sentido biológico

¿Tienes una conciencia clara de tu respiración? ¿Del volumen de aire que estás utilizando en este momento? ¿De la cantidad que pides a los pulmones en cada respiración? ¿Sabes qué porcentaje de tu capacidad respiratoria utilizas la mayor parte del tiempo? ¿80 por 100? No. ¿50 por 100? Tampoco. Alrededor del 9 por 100 ($\frac{1}{2}$ litro de los 6 litros de capacidad pulmonar).

¿Y el porcentaje de tus capacidades musculares? ¿Utilizas a fondo, *en cada momento*, todos tus músculos? No, claro. ¿Y tú capacidad cardíaca, digestiva, intelectual? Un porcentaje pequeño. Siempre. ¿Qué decir de vuestros espermatozoides, señores, de vuestros óvulos, señoras? En una vida, ¿cuántos han sido útiles? Contad vuestros hijos y tendréis la respuesta. Entonces, ¿por qué esta capacidad de más de los pulmones, ese añadido de músculos, ese derroche de espermatozoides, de estómago, de corazón? ¿Podrías vivir una vida normal con un solo riñón, un solo pulmón y el 60 por 100 de tus arterias coronarias tapadas! Sorprendente, ¿no?

Obviamente, ese suplemento de órganos, aparentemente inútil, tiene un sentido: son las situaciones de urgencia, de excepción. Subes las escaleras corriendo, te persigue un perro furioso, has perdido el autobús y corres por la calle... En estas ocasiones, utilizarás el 100 por 100 de tus pulmones, tus arterias, tus músculos... O sea, el cuerpo mantiene la inmensa mayoría de sus células sólo «*por si acaso!*».

Pero si la situación se vuelve todavía más excepcional, entonces la reserva de pulmones, de corazón, de cerebro, de intestinos, etc., no será suficiente. Inmediatamente, el cuerpo

fabrica lo necesario en mayor cantidad: frente al sol, broncea; la noche de fin de año, fabricará más cantidad de jugos gástricos; si vamos a un lugar de mayor altitud, el cuerpo fabricará más glóbulos rojos; y el cuerpo, siempre él, creará más cantidad de hueso después de una fractura, en previsión de nuevas agresiones sobre este hueso, como el trabajador manual tiene más callos en las manos que un intelectual.

En resumen, el cuerpo tiene tres funciones biológicas:

- **La función de base:** mis pulmones ventilan 16 veces $\frac{1}{2}$ litro de aire por minuto, mi corazón se contrae 74 veces por minuto, mi estómago segrega por día un litro de ácido clorhídrico, etc.
- **La función de reserva:** los pulmones pueden ventilar 22 veces 2 litros de aire por minuto, mi corazón puede contraerse 180 veces por minuto, mi estómago segregar 1,5 litros de ácido clorhídrico por día, etc.
- **La función de excepción:** ante una situación poco frecuente, de urgencia, una reacción poco frecuente, de urgencia. Mis pulmones fabrican más células de pulmón (un tumor) para absorber más aire; mi ritmo cardíaco tiene un ritmo desenfrenado (taquicardia, fibrilación, extrasístole); mi estómago, esta vez, en lugar de pedir a sus células que segreguen más ácido clorhídrico creará nuevas células (un pólipo) que producirán más ácido; el cuerpo crea una cantidad impresionante de glóbulos rojos nuevos, es la poliglobulia, etc.

El funcionamiento de excepción es, o bien por exceso, como acabamos de describirlo, o bien por defecto: menos glóbu-

los rojos, menos ácido clorhídrico, menos desarrollo pulmonar, de estómago, de riñones, de hueso... si esto es necesario para adaptarse o para sobrevivir (úlceras, necrosis...). Por ejemplo, en Escandinavia, mi piel necesita menos bronceado para que el cuerpo capte la luz solar (como en la enfermedad de vitiligo); esto será al revés en África. En el espacio, mis huesos se descalcifican, pierden su sustancia, me son menos necesarios debido a la ingravidez. En una situación de miedo, algunos bloquean sus pulmones, dejan de respirar, contienen su respiración.

En resumen, tenemos cinco comportamientos biológicos en función de la necesidad, del acontecimiento exterior:

+++ : fabrico más alvéolos, más estómago...

+ : respiro profundamente, las células de mi estómago se multiplican...

Estado habitual, de base: respiro inconscientemente, la mucosa de mi estómago produce poco ácido...

- : bloqueo mi respiración, bloqueo mi digestión...

--- : destruyo el parénquima respiratorio,
provoco una úlcera de estómago...

La emoción tiene un fundamento biológico

Surge en un **instante de inconsciencia**, de divorcio consigo mismo, aparece de súbito a nuestras espaldas. Efectivamente, no tardamos ni un año en ponernos enfermos o en caer nos de una escalera o, incluso, en quedarnos encinta! Este cambio se produce en una fracción de segundo. Esto sucede en un lugar

y en un tiempo preciso que se tratará siempre de reencontrar. ¿Por qué? Porque ésta es la única manera de retornar a nuestra consciencia lo que se ha personificado en el síntoma. Si no revivimos ese instante, ese **«bio-shock»**, nunca podremos volver a contactar con el sentido biológico de la enfermedad. Se trata, en nuestra experimentación, de una vivencia que hemos sentido una primera vez inconscientemente, sin saberlo.

El bio-shock es un momento de encuentro entre el mundo exterior y nuestro mundo interior. Y este encuentro produce ya sea una satisfacción, ya sea una insatisfacción. Estas dos reacciones son perceptibles gracias a las emociones. La emoción es la huella consciente de una actividad interna, es el indicio de una función biológica satisfecha o no. Hemos comido, nos sentimos saciados, llenos. Si no es el caso, nos sentimos frustrados, enfurecidos, con carencias. Hemos dormido bien, nos sentimos relajados, frescos. Todo a nuestro alrededor garantiza nuestra seguridad, nos sentimos apacibles y nuestro comportamiento se perpetúa; nos relajamos. Pero si el entorno es hostil, entonces el miedo surge de lo más profundo de nosotros con el fin de ponernos al acecho para que después esto nos permita reencontrar la seguridad.

La emoción aparece siempre en un instante, de manera involuntaria, incontrolada y adaptada a la perfección a una situación exterior. Está instalada en nuestro cuerpo de manera precisa (calor en el vientre, tensión en la garganta, hombros pesados, piernas cansadas, hormigueo en las manos, etc.).

Entonces, ¿la emoción es nuestra amiga?... Para responder, déjame preguntarte: ¿cuál es la energía más poderosa?

A mi juicio, es la emoción. La emoción es nuestro carburante, la esencia misma de nuestra vida, nuestro combustible

los rojos, menos ácido clorhídrico, menos desarrollo pulmonar, de estómago, de riñones, de hueso... si esto es necesario para adaptarse o para sobrevivir (úlceras, necrosis...). Por ejemplo, en Escandinavia, mi piel necesita menos bronceado para que el cuerpo capte la luz solar (como en la enfermedad de vitiligo); esto será al revés en África. En el espacio, mis huesos se descalcifican, pierden su sustancia, me son menos necesarios debido a la ingravidez. En una situación de miedo, algunos bloquean sus pulmones, dejan de respirar, contienen su respiración.

En resumen, tenemos cinco comportamientos biológicos en función de la necesidad, del acontecimiento exterior:

+++ : fabrico más alvéolos, más estómago...

+ : respiro profundamente, las células de mi estómago se multiplican...

Estado habitual, de base: respiro inconscientemente, la mucosa de mi estómago produce poco ácido...

— : bloqueo mi respiración, bloqueo mi digestión...

— — — : destruyo el parénquima respiratorio,
provoco una úlcera de estómago...

La emoción tiene un fundamento biológico

Surge en un **instante de inconsciencia**, de divorcio consigo mismo, aparece de súbito a nuestras espaldas. Efectivamente, ¡no tardamos ni un año en ponernos enfermos o en caernos de una escalera o, incluso, en quedarnos encinta! Este cambio se produce en una fracción de segundo. Esto sucede en un lugar

y en un tiempo preciso que se tratará siempre de reencontrar. ¿Por qué? Porque ésta es la única manera de retornar a nuestra consciencia lo que se ha personificado en el síntoma. Si no revivimos ese instante, ese «**bio-shock**», nunca podremos volver a contactar con el sentido biológico de la enfermedad. Se trata, en nuestra experimentación, de una vivencia que hemos sentido una primera vez inconscientemente, sin saberlo.

El bio-shock es un momento de encuentro entre el mundo exterior y nuestro mundo interior. Y este encuentro produce ya sea una satisfacción, ya sea una insatisfacción. Estas dos reacciones son perceptibles gracias a las emociones. La emoción es la huella consciente de una actividad interna, es el indicio de una función biológica satisfecha o no. Hemos comido, nos sentimos saciados, llenos. Si no es el caso, nos sentimos frustrados, enfurecidos, con carencias. Hemos dormido bien, nos sentimos relajados, frescos. Todo a nuestro alrededor garantiza nuestra seguridad, nos sentimos apacibles y nuestro comportamiento se perpetúa; nos relajamos. Pero si el entorno es hostil, entonces el miedo surge de lo más profundo de nosotros con el fin de ponernos al acecho para que después esto nos permita reencontrar la seguridad.

La emoción aparece siempre en un instante, de manera involuntaria, incontrolada y adaptada a la perfección a una situación exterior. Está instalada en nuestro cuerpo de manera precisa (calor en el vientre, tensión en la garganta, hombros pesados, piernas cansadas, hormigueo en las manos, etc.).

Entonces, ¿la emoción es nuestra amiga?... Para responder, déjame preguntarte: ¿cuál es la energía más poderosa?

A mi juicio, es la emoción. La emoción es nuestro carburante, la esencia misma de nuestra vida, nuestro combustible

de base. Sólo la emoción nos permite avanzar, nos da ganas de levantarnos por la mañana, de actuar, nos permite cuestionar y seleccionar para ir en la dirección que nos conviene. La emoción provoca encuentros o aislamiento, está en el origen de todas nuestras decisiones impulsivas.

¿Dime, qué sería tu vida sin emociones? Es la emoción del placer la que nos empuja a escoger un plato en un restaurante. ¿Obsérvate! Sin emociones, ¿por qué ir a tal velada, hacia tal colega? La idea de una lectura o de un encuentro crea —anticipadamente— en tus entrañas alegría o repulsión. ¿En función de qué comprarás o no el libro, irás hacia el otro o no? A veces, no ir a una reunión crea malestar, culpabilidad. Para evitarlo, por ejemplo, aceptas ir a la reunión porque la emoción de aburrimiento será menor que la de culpabilidad.

O sea, hay dos motores:

- ir hacia (o mantener) una emoción positiva;
- alejarse de (o eliminar) una emoción negativa.

Sí, ¿qué harías sin el motor emocional? Que seas consciente o no, no cambia nada el asunto. Dime: ¿qué acto de tu vida, o qué actitud, se ha engendrado fuera de la emoción? ¿Verdaderamente, podemos actuar a sangre fría?

Es sencillo prestar a nuestros *primos*, los animales, el mismo movimiento interno, una vida emocional. Deseo de alimentarse, de encontrar morada y, cuando la impregnación hormonal está satisfecha, ¿qué decir de ese impulso que empuja a los machos a vigilar el rebaño de las hembras o a desearlo ardientemente o, también, a pelearse? Una vez más, ese miedo, cuando surge el depredador. Algunos, más audaces,

llegarán incluso a prestar una forma de emoción al reino vegetal. Basta con ponerse de acuerdo sobre lo que expresa el término «emoción».

Las emociones traducen a nivel consciente lo que se vive a nivel biológico celular, porque la función de la emoción es transmitir al consciente una función biológica satisfecha (*colmado, saciado, aliviado...*), o insatisfecha (*agredido, frustrado, hambriento...*). En este sentido, pienso que **«la emoción es la esencia que hace funcionar el motor»**. ¡Mira a tu alrededor! ¡Mira en ti mismo! Sin emoción, no hay vida. Sin vida, no hay emoción. Es, a la vez, el bien máspreciado y el más descuidado, renegado, rechazado, minimizado, satanizado. Sinónimo de debilidad, está reservado a los profesionales de la emoción, a los artistas de todos los pelajes, a los románticos, a los trovadores, a los cineastas, a los músicos... Porque, para los adultos serios, no es razonable emocionarse en sociedad; en caso de hacerlo, entonces, se hace por poderes. Vamos a un espectáculo y, allí, vemos sollozar al artista, asistimos al drama, a su cólera, le dejamos expresar lo que nos atormenta en las entrañas, le confiamos lo que ya no sabemos decir, decirnos.

Es penoso, una desgracia y una lástima. Un verdadero desastre. Tengo el corazón que se me parte en dos y la baba que, de rabia, me sube a los labios y, en el alma, una melancolía se espesa como una bruma de otoño en el puerto de Londres.

Porque es lo que nos hace vivir, lo que nos mata por defecto. Sí, decir que lo que nos da placer es lo que, por defecto, nos hace sufrir.

Si la espiritualidad, la cocina o el deporte te hacen vibrar y, en sí mismos, dan sentido a tu vida, el día que te los quiten,

de lo más profundo de ti llegará la emocional pregunta: ¿por qué seguir viviendo? Si lo que está en el origen de todos tus placeres (como, por ejemplo, el sexo, la cultura, la vida en familia) falta, ¿cuánto sufrirás por haber tenido ese vínculo como fuente de placer?

Inconsciente y biología

«El individuo, en su medio, es a la vez cuerpo y espíritu. El éxito de la adaptación a este entorno depende de la sinergia armoniosa entre estos dos aspectos de una entidad existencial única. No se puede alcanzar el uno sin el otro, sino por la ilusión de una mirada que privilegia a uno a costa del otro».

Robert Dantzer en *La ilusión psicósomática*

Entonces, ¿responderá la bio-descodificación a la profecía de Sigmund Freud: «Vuestra generación será aquella que verá hacerse la síntesis entre la psicología y la biología»? ¿Su amigo C. G. Jung no afirmaba que: «La enfermedad contiene el oro que no encontrarás en ninguna otra parte»? Porque las enfermedades, los síntomas, contienen en sí mismos todas las emociones que no te dijiste. ¿Por qué? Pues bien:

— **Nuestro cuerpo es el conjunto de nuestros órganos que garantizan su actividad de forma inconsciente: digerir, latir, coordinar, filtrar, almacenar, segregar...**

- Una sensación negativa, luego una emoción, sobrevienen cuando una función biológica ya no está satisfecha: alimentarse, dormir, sentirse seguro, reproducirse, moverse... Entonces nos sentimos hambrientos, frustrados, furiosos, irritados, en peligro...
- El inconsciente es biológico, está en el cuerpo, en cada una de nuestras células. La vida es biológica por naturaleza, por esencia, y psicológica por accidente, es decir, en el momento de un conflicto, de un imprevisto.

¿Y qué es un imprevisto, un accidente, un «bio-shock»? El bio-shock nace en un instante preciso y se vive en un lugar preciso. Aparece cuando un acontecimiento es vivido como:

- conflictivo e imprevisto,
- dramático (sin solución satisfactoria),
- vivido solo (no podemos compartir lo que sentimos en nosotros mismos, no tenemos las palabras para traducir esto, para expresar lo que se queda impregnado).

Se produce cuando un acontecimiento exterior nos encuentra desprovistos, cuando ya no podemos adaptarnos a lo que pasa, no tenemos nada en la recámara, en la memoria, en nosotros, en nuestros aprendizajes, que nos permita salir de la situación: ninguna solución *consciente*. Entonces, sólo nos quedan, como salida, las soluciones *inconscientes*, aquellas que se sitúan en nuestro cuerpo.

Pero, ¿dónde están esas soluciones inconscientes? ¡En nuestras células!, memorias de la evolución, ¡mutaciones exitosas para sobrevivir aún más! Sí, siempre es cuando se produce

este imprevisto que es el bio-shock, cuando aparece la vivencia. Es el Oro de la terapia: **dejad llegar a la consciencia la «vivencia biológica conflictiva»**, piedra de Rosetta y piedra de fundación de la bio-descodificación.

En efecto, el sentido de este libro se sitúa en el enunciado de cada vivencia para cada enfermedad, porque cada síntoma físico es una encarnación, una puesta a punto en nuestra carne de un instante preciso, instante conflictivo, es decir, vivido con emoción. ¿Y dónde se encuentran nuestras emociones, cuál es el escenario de expresión? ¡El cuerpo, por supuesto! Siempre él.

Presentación del libro y de su estructura

Seamos claros: el ser humano está enfermo de una falta de vocabulario. Así pues, este libro no es más que un libro de vocabulario, para enseñarte a expresarte. Podrás aprender, para cada enfermedad, las palabras de su **vivencia biológica conflictiva**.

A veces, encontrarás igualmente pistas para continuar tu escucha de comprensión emocional del síntoma; esto será señalado como **«pista(s) para explorar prudentemente»**, prudentemente porque no tenemos la certeza de lo que hay que imponer al prójimo.

Encontrarás otras novedades en esta colección, en particular, **«Los puntos pedagógicos»** como puntos de información sobre tu camino de papel, ¡como un segundo libro en el libro! Su función es permitirte comprender los principios que rigen el proceso de la enfermedad, tales como *preconflicto, ciclos biológicos, etc.*

Para cada órgano y cada síntoma, la mayoría de las veces encontrarás:

- una descripción anatómica y fisiológica;
- los órganos afectados;
- una definición de la patología;
- las vivencias biológicas conflictivas;
- pistas para explorar prudentemente;
- el sentido biológico de la enfermedad;
- ejemplos;
- observaciones, en particular sobre el acompañamiento terapéutico;
- los síntomas propios de las fases de la enfermedad;
- una metáfora de animales: la piel es el conflicto del bebé gato que necesita a su madre, su contacto...
- el estrato biológico afectado por la patología y la vivencia:
 - 1.º estrato de la biología: vivencia arcaica de supervivencia;
 - 2.º estrato: vivencia de agresión, buscamos protegernos;
 - 3.º estrato: vivencia de desvalorización;
 - 4.º estrato: vivencia del conflicto relacional, social.

Y esto cada vez que tengas la información. Porque, a veces, no encontrarás el sentido biológico sencillamente porque, de momento, lo ignoro; a veces, tampoco habrá ningún ejemplo porque no he tenido un caso que alumbrase suficientemente la tonalidad conflictiva. Pero siempre podrás leer por lo menos una proposición de vivencia conflictiva, porque ahí está el sentido de este libro.



Antes de dejarte en compañía de este libro, es decir, contigo mismo, ¡que sepas el bien precioso que va a ser **una relación, una amistad, una familia y un ámbito social, en el seno del cual, podrás compartir emocionalmente** tu vida interior!

Expresar en cada instante lo que sientes te dará, por añadidura, el derecho a sentir lo que sientes, a pensar lo que piensas, a hacer lo que haces, en una palabra, a ser quien eres.

¡Estar a **la vez consigo mismo y con los demás** garantiza nuestra salud mucho más que lo que comemos, que el lugar donde vivimos y que lo que bebemos! «Lo que purifica, cuida y cura al hombre no es lo que entra en él, sino lo que sale de él»...



Que este libro te permita contactar con la consciencia y poder expresar lo que vives en ti de conmovedor, ése es mi máspreciado deseo.

Punto pedagógico: «Bajo prescripción médica»

En numerosas ocasiones en esta colección, podrás leer una advertencia de este tipo: *«Todo esto requiere una presencia médica. Desde luego, sólo un médico está habilitado para diagnosticar, tratar y seguir la evolución de estos síntomas».*

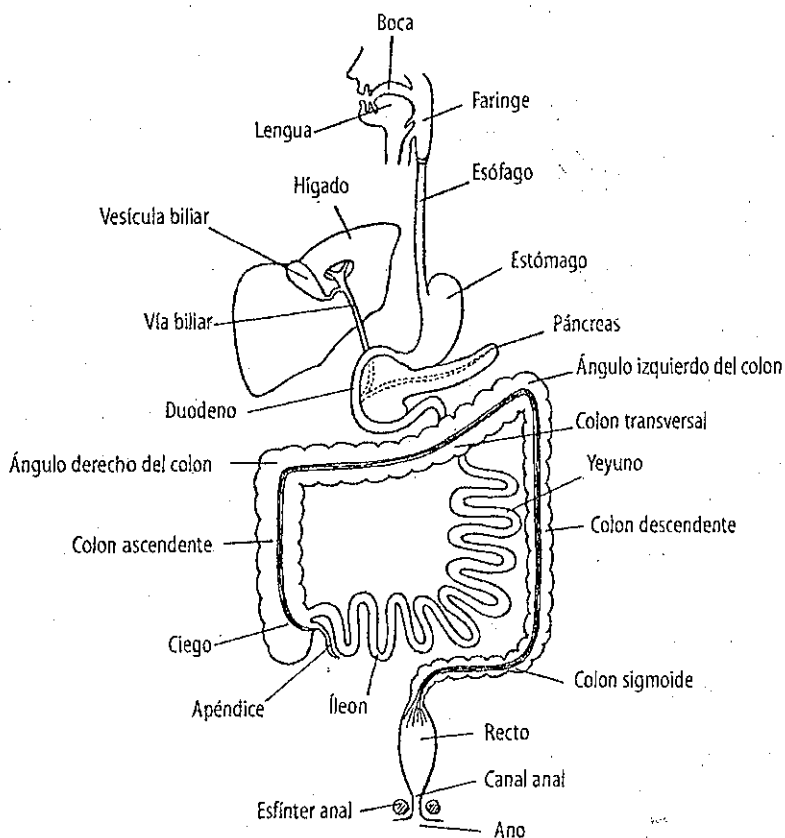
No se trata de una fórmula educada e hipócrita por mi parte, sino de una verdadera recomendación. Actualmente, demasiados terapeutas juegan a aprendices de brujos, y regulan, inconscientemente, esa relación a la autoridad, al padre... Todos estos rebeldes ponen a sus pacientes en peligro. Creyéndose bien intencionados, olvidan que

la medicina, aunque tiene sus límites, también tiene sus competencias, de las que no hay que privar a nadie. Una de las trampas del terapeuta es creer en la omnipotencia: la suya, la del paciente, la del inconsciente... Sin embargo, los hechos demuestran que ningún enfoque terapéutico en el mundo cura a todo el mundo de todo y todo el tiempo. La complementariedad, la apertura, la inteligencia puestas en común, ofrecen más posibilidades de curación que cualquier movimiento aislado.

Lo que importa durante la terapia de descodificación es el síntoma. Nos apoyamos en el síntoma para proponer una descodificación. Pero si «esto no lo siente» la persona, insistir no servirá de nada. El terapeuta se encuentra siempre frente a la complejidad del ser humano. Le corresponde ser infinitamente prudente en el momento en el que propone una descodificación. Debe estar siempre vigilante a las reacciones del paciente, reacciones emocionales.

GENERALIDADES

ANATOMÍA



El aparato digestivo

El aparato digestivo está constituido por un conjunto de órganos que aseguran la digestión. Comprende:

- órganos huecos (cavidad bucal, una parte de la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso —también llamado colon— y el recto);
- órganos *macizos* anexados al tubo digestivo: las glándulas digestivas, entre ellas, las glándulas salivales, el hígado, el páncreas.

FISIOLOGÍA

El objetivo de la digestión es la transformación de los alimentos puros en nutrientes, es decir, en sustancias absorbibles y utilizables por todas las células del cuerpo, *o sea, la transformación de un bistec con patatas fritas en glúcidos, lípidos, prótidos*, la transformación del mundo exterior en mundo interior, de todo lo que proviene de fuera en todo yo.

Porque, para vivir el ser humano necesita:

- materiales (que aportan los prótidos),
- reservas (garantizadas esencialmente por los lípidos),
- energía (procurada por los glúcidos).

Los **prótidos** o proteínas ($C H O N^1 + R$) son el compuesto más importante en los animales. El elemento de base es el aminoácido. Existen veinte clases diferentes e indispensables de aminoácidos, de los cuales diez no son sintetizados por el cuerpo humano. Los aminoácidos se agrupan en péptidos,

1. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno.

que a su vez se agrupan en proteínas. Existen los prótidos de estructura y los prótidos enzimáticos.

Los **lípidos** son una asociación de ácidos grasos y alcohol.

Los **glúcidos** son el elemento energético (C H O).

El cuerpo **utiliza esos materiales** para asegurar:

- la reparación (cicatrización);
- la compensación de las pérdidas naturales (descamación de la piel, transformación ósea, menstruaciones...);
- el crecimiento;
- y todos los funcionamientos del organismo.

La actividad natural de las células se llama **metabolismo**.

Se divide en dos tiempos:

- **el anabolismo**: es la fase de construcción, se efectúa a partir de los materiales ingeridos;
- **el catabolismo**: es la operación de destrucción, su papel es el de extraer la energía y eliminar las células que envejecen.

La **transformación de los alimentos** ingeridos en nutrientes es posible gracias a dos fenómenos:

- **mecánico**, por una acción de trituración (dientes) y de mezcla (estómago, intestinos);
- **química**, por la acción de las enzimas digestivas (proteasa, lipasa, amilasa).

La digestión empieza en el instante en el que los alimentos penetran en la cavidad bucal.

El cuerpo está compuesto de:

- **C. H. O. N.** (carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno): 30 por 100 de su peso.
- **Sales minerales:** 5 por 100, fósforo, sodio, potasio, cloro, calcio, magnesio, azufre.
- **Oligoelementos:** hierro, zinc, yodo, cobalto, flúor...
- **Agua:** 65 por 100 a 70 por 100 del peso, según la edad.
 - 50 por 100 se encuentra en las células,
 - 5 por 100 en la sangre,
 - 15 por 100 en la linfa,
 - 30 por 100 se sitúa entre las células; es el líquido intersticial. Algunos edemas se producen cuando este medio intersticial está sobrecargado de agua. Pero existen numerosas formas y causas en los edemas (remitirse a un médico).



El aparato digestivo acoge y, además, contiene el mundo exterior.

El cuerpo debe apropiarse del mundo exterior, es decir, transformarlo para hacerlo **propio**, suyo, y eso gracias a las enzimas. Las **enzimas** son biocatalizadores (sustancias que aceleran las reacciones químicas). Son específicas y potentes en concentraciones bajas; su acción está influenciada, entre otros, por el pH del medio. La mezcla de alimentos y de jugos gástricos realiza el medio digestivo necesario para el cumplimiento de las reacciones enzimáticas; éstas se suceden, se encadenan y se sincronizan incluso a lo largo de todo el tubo digestivo.

Por su parte, los elementos minerales se disuelven en el agua y después son absorbidos por la mucosa del intestino.



LAS VÍAS DIGESTIVAS SUPERIORES

Se trata de la boca, los dientes, las glándulas salivales, la lengua, la faringe y el esófago.

La boca

Se abre, hacia adelante, por el orificio bucal limitado por los labios superior e inferior.

En el interior, está limitada en la parte superior por la bóveda del paladar, en la inferior por el suelo bucal y lateralmente por las dos mejillas. Comunica por detrás con la faringe. Está totalmente tapizada por una mucosa. Contiene la lengua y los dientes.

Los dientes

Tenemos treinta y dos dientes implantados en el hueso alveolar de los maxilares y de la mandíbula. Una parte es visible, eficaz: la corona; la otra, escondida: la raíz.

El diente es un órgano completo con su rol específico: transformar los alimentos mecánicamente. Los dientes son el

reflejo vivo y en tiempo real del estado de salud del organismo, igual que el iris, por ejemplo.

Las glándulas salivales

Permiten envolver el bolo alimenticio gracias a la saliva. Ésta tiene cuatro funciones:

- hidrata;
- hace resbalar el bocado de alimentos hacia el interior (esófago) o el exterior (escupitajo);
- contiene las enzimas predigestivas;
- tiene una acción antiséptica.

La lengua

Es un órgano carnoso y móvil que incluye los músculos implicados en la **masticación**. Aprecia el **sabor** y el **contacto térmico** del alimento exterior que **propulsa** hacia la faringe. La lengua desempeña un rol en la **deglución**.

Para impedir los **falsos caminos** hacia la laringe, la **epiglottis** se apoya (se arrodilla) sobre la glotis. La orden cerebral automática está en el tronco cerebral; la orden voluntaria se encuentra en el córtex frontal.

La faringe

Ya la hemos presentado en el libro *Décodage biologique des problèmes respiratoires et ORL*.²

Es una confluencia en la que se cruzan las vías aéreas y las digestivas.

Mide alrededor de 13 centímetros e incluye tres partes:

- una parte superior, que comunica con las fosas nasales: la nasofaringe;
- una parte intermedia, bucal: la orofaringe;
- una parte inferior, que se prolonga por la laringe: la laringofaringe.

El esófago

Es un conducto que une la faringe (arriba) con el estómago (abajo).

Mide alrededor de 25 centímetros de largo y tiene un diámetro de 2 a 3 centímetros.

Describimos cuatro partes:

- cervical, en la base del cuello y detrás de la tráquea;
- torácica, en contacto con la aorta y el canal torácico, el corazón, los nervios neumogástricos y los pedículos pulmonares;
- diafragmática (el esófago pasa a través del diafragma);
- abdominal (se precipita al estómago por el **cardias**).

2. Editions Le Souffle d'Or.

El bolo alimenticio progresa en el esófago gracias al **peristaltismo** de los músculos estriados en su **tercio superior**, **lisos** en el **tercio inferior**, **mixtos** en el **tercio medio**.



LAS VÍAS DIGESTIVAS INFERIORES

Se trata del estómago, del intestino delgado, del colon y del recto. Todo está rodeado por el peritoneo.

El estómago

El estómago es una **bolsa** esencialmente **musculosa**, cerrada por dos músculos esfinterianos: el **cardias** y el **píloro**. Cuando el estómago está vacío, el píloro está abierto. **Las emociones cierran el píloro.**

La acidez, al igual que las grasas, alarga el tiempo de digestión. Los líquidos permanecen en el estómago una hora, los sólidos cinco. Los alimentos entran en el estómago durante **la expiración**.

La mucosa del estómago absorbe el agua, ciertos medicamentos y el alcohol.

Anatómicamente, distinguimos una curvatura pequeña y una curvatura grande.

Se compone de diferentes capas llamadas «**túnicas**»:

- una mucosa espesa y glandular;
- una musculosa potente;

- una serosa: es un pliegue del peritoneo (palabra tomada del latín *peritoneum*, del griego antiguo περιτονιον (*péritoniaion*), literalmente «recubierto de [piel] tensa» y que se descompone en περι (*péri*) «alrededor» y τονος (*tonos*) «tensión».

El **nervio** vago es motor y el simpático, ralentizador.

Las **secreciones** gástricas reaccionan a los sistemas nerviosos (vista, olfato, etc.) y hormonal (desde que los alimentos entran en el estómago, éste libera una **hormona**, la gastrina).

Las **glándulas** del estómago están especializadas; segregan diferentes sustancias:

- ácido clorhídrico,
- pepsina,
- mucina,
- factor intrínseco (antianémico),
- gastrina,
- agua,
- sales minerales.

Diariamente, se segregan de **dos a tres litros** del conjunto de las sustancias enumeradas (en cantidad y calidad variables, según los alimentos) y llegan al estómago cinco minutos después del principio de la comida.

El intestino delgado

Es un segmento del tubo digestivo que une el estómago con el intestino grueso. Mide alrededor de siete metros.

Comprende dos partes:

- **el duodeno**, que es una porción fija con tres tunicas (mucosa, muscular y serosa),
- **el yeyuno-íleon**. El yeyuno tiene asas horizontales; el íleon tiene asas verticales.

Están compuestos de tres **túnicas**:

- mucosa (epitelio glandular),
- muscular (músculos oblicuos, circulares, longitudinales),
- serosa peritoneal (envoltura conjuntiva).

La mucosa y la muscular permiten la **mezcla de los alimentos**, su progresión, su **digestión**. El tránsito dura de seis a nueve horas. La mucosa está adaptada a la **absorción**.

El intestino es el lugar más importante de la absorción digestiva. Está constituido por pliegues con millones de vellosidades. Está compuesto de glándulas secretoras y de **acúmulos linfoides**. Las glándulas segregan jugos, agua, mucosidad (alrededor de un litro por día). Los pliegues de las asas amplifican la capacidad de absorción. ¡Su superficie es superior a 300 m²!

En el intestino delgado se realiza una sinergia de acción de jugos pancreáticos, intestinales y de la bilis.

Los movimientos del intestino delgado

Tienen como objetivo, por medio de movimientos, permitir y mejorar la absorción de los alimentos. Existe una motri-

cidad propia en las vellosidades. Las contracciones rítmicas de la musculatura circular, las ondas peristálticas (de 12 a 16 movimientos por minuto) garantizan la progresión del quimo hacia el intestino grueso.

El peristaltismo es sensible a las hormonas, de las cuales algunas son inhibitoras (adrenalina, etc.) y otras estimulantes (gastrina, histamina, serotonina, etc.).

Todos estos movimientos dependen del **sistema nervioso autónomo**. A la altura de la musculosa llegan terminaciones del nervio vago y, en la submucosa, las del nervio simpático. El nervio vago, parasimpático, aumenta los movimientos y la secreción. Es dominante sobre el simpático; el simpático ralentiza. El nervio vago aumenta el tono de la base y la potencia de las contracciones; el simpático hace lo contrario.

Punto pedagógico: «No digas... sino di lo siguiente...»

No digas **con rabia**: «Voy a ir a hacer la comida», sino di lo siguiente: «Ir a hacer la comida **me da rabia**».

En el primer caso, el enfrentamiento directo hace reaccionar conscientemente a lo que dices y emocionalmente a tu manera de decirlo. Sigue un diálogo a dos niveles, con la ilusión de debatir sobre la comida, mientras que todo el problema está en otra parte, es emocional. Porque, de hecho, hablas completamente de otra cosa que de la preparación de la comida, hablas de ti, de tu rabia, de la impresión de ser el sirviente, de hacer siempre lo mismo, de sentirte inútil, etc.

En el segundo caso, toda la conversación girará en torno a la rabia y a la escucha de tus necesidades. En efecto, raramente somos conscientes de nuestras necesidades. Y, sin

embargo, cuando todas nuestras necesidades están satisfechas, sólo de esta forma nos podemos sentir verdaderamente bien, distendidos, serenos... **La vivencia negativa es el rastro consciente de una necesidad no satisfecha.** Y cuando no somos conscientes de nuestras necesidades, forzosamente, no tenemos un comportamiento apropiado para satisfacer esas necesidades. Por ejemplo, un niño se siente desgraciado porque sus padres no le dedican tiempo exclusivamente a él. Tiene necesidad de afecto y, para conseguirlo, decide llamar la atención rompiendo un vaso. El resultado es que le regañan y todavía recibe menos afecto. Cuando somos conscientes de nuestras necesidades, podemos, o bien expresarlas, o bien satisfacerlas de otro modo, directamente, de manera más eficaz.

El intestino grueso o colon

Anatomía

El colon se llama así por su diámetro (siete centímetros de media). Mide alrededor de un metro y medio de largo.

Comprende:

- a la altura de nuestro costado derecho: el ciego, que abarca el apéndice, y el colon ascendente, fijo;
- en el centro: el colon transversal, móvil;
- a la izquierda: el colon descendente y el sigmoide, que es móvil (en forma de S).

La histología del intestino grueso se caracteriza por:

- una mucosa lisa que, gracias a su producción de mucosidad, envuelve los residuos, lubrica las paredes y facilita la expulsión de las materias;
- una musculosa, que se caracteriza por tres cintas longitudinales para garantizar el peristaltismo.

Fisiología

El intestino grueso desempeña numerosos roles, con, entre otras, las siguientes funciones:

- **química:** las **bacterias** transforman el quimo, degradan ciertas proteínas (olor), producen gas por fermentación y permiten la síntesis y la absorción de las vitaminas B y K;
- **motor:** asegura la progresión de los residuos (heces) hasta su defecación por el ano;
- es, asimismo, el lugar de **recuperación del agua** (90 por 100).

El recto

El colon continúa por el **recto**. Esta parte terminal, la más baja del intestino, incluye una parte dilatada, ampolla rectal, seguida del canal anal, dirigido por los esfínteres.

*

El peritoneo

Se trata de una membrana que cubre la cavidad abdominal y los órganos que allí se encuentran. Se compone de una **serosa** (o envoltura) con una capa parietal y una capa visceral. Entre las dos capas se producen **secreciones** de líquido lubricante que van a facilitar los desplazamientos. El pliegue principal del peritoneo se llama **epiplón mayor**. Cuando el peritoneo une un órgano a la pared posterior, lo llamamos **el mesenterio**.

Una irritación del peritoneo puede conllevar su espesamiento, hablamos entonces **de adherencia**, constituyendo las **bridas** (soldaduras entre los órganos vecinos).

La membrana peritoneal tiene una superficie de 10 m^2 y absorbe fácilmente el exceso de agua. El bloqueo de esta función acarrea una **ascitis**.



LAS GLÁNDULAS ANEXAS

Éstas son:

- las glándulas salivales;
- el hígado, con las vías biliares (la producción se llama **bilis**);
- el páncreas.

Las glándulas salivales

Funcionan de dos en dos:

- las parótidas;
- las submaxilares;
- las sublinguales.

Glándulas parótidas: producen una saliva acuosa rica en enzimas. Su secreción desemboca en la cavidad bucal por el **canal de Stenon**.

Glándulas submaxilares: los canales colectores son los **canales de Wharton**.

Glándulas sublinguales: excretan una saliva lubricante. Los canales colectores son los **canales de Rivinus y Walther**.

La secreción de las glándulas salivales está bajo el **control del sistema nervioso neurovegetativo**:

- las fibras **parasimpáticas** provocan una saliva acuosa, rica en enzimas y en iones,
- las fibras **ortosimpáticas** procuran una saliva espesa rica en mucina.

Esta secreción está asimismo bajo la influencia de los **centros nerviosos superiores** (rol de los factores psíquicos).

El hígado

Situado bajo el diafragma, está compuesto de células, los hepatocitos, agrupados en lobulillos. Es la glándula más grande

del cuerpo, de un kilo y medio a dos kilos. El hígado está constituido por varios lóbulos. La vena lleva hacia el hígado la sangre procedente del intestino delgado para que los nutrientes sean metabolizados.

El hígado sintetiza los factores de coagulación, produce la heparina. Tiene una función endocrina. Absorbe las toxinas del cuerpo, elimina los medicamentos, transforma los nutrientes, sintetiza la mayor parte de las proteínas, interviene en la síntesis de la vitamina D, y tiene una acción fagocitaria (porque los macrófagos se encuentran en los lobulillos). Almacena las sales minerales, las vitaminas, el hierro, el cobre y el glucógeno.

Y, sobre todo, mantiene una glucemia normal porque puede almacenar el azúcar bajo forma de glucógeno, o liberarla.

El hígado tiene una función exocrina. Produce la bilis, que luego es almacenada en la vesícula (50 ml de capacidad); los estímulos provocan su evacuación en la ampolla de Vater, donde se une al jugo pancreático.

La bilis

Es un líquido amarillo, verdoso, amargo, alcalino. Permite la activación de los jugos intestinales. Fabricamos un litro por día. Está constituida por pigmentos biliares (residuos de hemoglobina deteriorada, sin el hierro), de sales biliares (que intervienen en la digestión de lípidos), de sales minerales, de colesterol (el 80 por 100 del colesterol es sintetizado por el hígado; el exceso favorece los cálculos), ácido biliar, ácido graso, agua, bilirrubina, etc.

En gran parte, la bilis es reabsorbida por el intestino grueso. La bilis va a emulsionar las grasas, a permitir absorber las vitaminas D, E, K y el colesterol. Asimismo, estimula el peristaltismo del intestino delgado.

La bilis desempeña un rol antipodredumbre.

Por la bilis se eliminan las sustancias extrañas o medicamentosas metabolizadas por el hígado, así como los productos de degradación de los glóbulos rojos.

El nervio vago y la secretina aumentan la secreción de la bilis.

El páncreas

Es una glándula mixta:

- **endócrina** por la presencia de los islotes de Langerhans, que fabrican dos hormonas: la insulina y el glucagón (véase la obra: *Décodage biologique des problèmes neurologiques et endocriniens*);³
- **exocrina** por los acinos que fabrica el jugo pancreático, un líquido incoloro, viscoso, alcalino. Es el más importante de los jugos gástricos, porque contiene un conjunto de enzimas completas. Secretamos alrededor de un litro por día. Está compuesto de agua, de enzimas y de HCO_3^- ⁴ que taponan la acidez del estómago. Las enzimas actúan sobre los glúcidos, lípidos y protéidos para permitir su digestión.

3. Éditions Le Souffle d'Or.

4. Bicarbonato o hidrogenocarbonato.

Su regulación se efectúa por vías neurológicas y hormonales.



EL SISTEMA NERVIOSO DIGESTIVO

El sistema **ortosimpático** reduce el peristaltismo, contrae los esfínteres, disminuye la secreción de la bilis y relaja la vesícula.

El sistema **parasimpático**, por el contrario, estimula las glándulas, aumenta la motricidad intestinal, relaja los esfínteres, aumenta la secreción de la bilis y hace contraerse a la vesícula.

Los centros nerviosos

En el hipotálamo se encuentran el **centro del hambre**, que está siempre en actividad, y el centro de la saciedad, que puede inhibir el precedente (es sensible a la glucemia y a los ácidos aminoácidos). La estimulación de uno u otro comportará un comportamiento **bulímico o anoréxico**.

En el tronco cerebral se encuentra el centro de la deglución y de la glucemia.

Hiper glucemia y fiebre hacen disminuir el apetito.

La vista del alimento, el estrés, la emoción, llegan al cerebro, que ordena la secreción de los jugos gástricos. La llegada de los alimentos al estómago estimula la gastrina, que va a la

sangre; después estimula, asimismo, la secreción de los jugos gástricos.

Embriología

El **saco vitelino** queda aprisionado en el curso de la cuarta semana por la cabeza y la mitad inferior del cuerpo; es ahí cuando se forma el intestino primitivo: tubo digestivo y glándulas digestivas.

El **endodermo** va a revestir de tejido epitelial todo el tubo. Es el origen del parénquima del hígado, de las células secretoras y del parénquima del páncreas.

El **mesodermo** parece estar en el origen del epiplón, del peritoneo, de la túnica muscular y de las serosas.

Las extremidades (boca y ano) son salidas del **ectodermo**. La parte de arriba está en el origen de los arcos branquiales, es decir, del ectodermo.

Las patologías

Diarrea: excrementos numerosos o líquidos.

Cólicos: dolores intestinales.

Enteritis: inflamación intestinal.

Estreñimiento atónico: excrementos gruesos.

Estreñimiento hipertónico: excrementos pequeños.

Oclusión: obstrucción.

Vólvulo: torsión de un asa.

Colerético: que excita la secreción biliar.

Colagogo: que provoca el flujo de la bilis almacenada.

✱

Resumen

El aparato digestivo está formado por el conjunto de órganos que garantiza la transformación de las sustancias aportadas por los alimentos, para permitir su asimilación por las células del organismo.

Se compone de una serie de **órganos huecos**, el conjunto de los cuales forma el tubo digestivo (boca - esófago - estómago - duodeno - intestino delgado - ciego - colon - sigmoide - recto - ano), y de **órganos macizos** anexados al tubo digestivo (glándulas salivales, estomacales, intestinales - hígado - páncreas).

Estos órganos están unidos al tubo digestivo por medio de conductos: canales de las glándulas salivales, vías biliares, conductos intra y extrapancreáticos.

La parte abdominal del aparato digestivo está recubierta por el peritoneo.

El Yo transforma el exterior en interior.

CONFLICTOLOGÍA

Los conflictos que afectan al aparato digestivo son, globalmente, los conflictos relativos a todo aquello que podemos reunir bajo el término genérico de **pedazo**: el *pedazo a coger, a tragar, a hacer pasar, a asimilar, a eliminar*.

El aparato digestivo habla de nuestra relación con el mundo exterior: ¿eres aceptado?, ¿rechazado?, es decir, ¿nutritivo o tóxico? Podemos decir que, en cierta manera, el aparato digestivo es un órgano sensorial que empieza en la lengua y continúa a lo largo del tracto digestivo. Nos enfrentamos con el mundo exterior tanto a través de los ojos como del estómago, el intestino, el colon...

El uno prueba a uno⁵

La lengua sirve para probar lo que viene del exterior, el estómago sirve para recibirlo y aceptarlo, el intestino delgado hace la selección entre aquello que va a ser rechazado y aquello que va a ser absorbido, y en el intestino grueso, de nuevo la selección se centrará entre eliminar y conservar. Esta selección permite definir lo que soy Yo de lo que no soy, en mi relación con el mundo exterior (el riñón tiene la misma función, pero en la sangre).

5. En francés, *L'un teste un*. El autor ha jugado con la fonética de la palabra *intestin* con *l'un teste un*. Hace un símil entre el intestino y su función: el intestino prueba o testa el alimento. (*N. de la T.*)

Preámbulo

Si deseamos hacer *conflictología*, es decir, estudiar los conflictos biológicos relativos a esta parte del aparato digestivo, empecemos por conocer la *fisiología*, el buen funcionamiento, y su *anatomía*, su descripción.

«Toda enfermedad es el reflejo de las circunstancias de la construcción de la vida de la persona». Salomon Sellam.

El cuerpo es nuestro primer cuerpo médico personalizado.

Estamos enfermos de una falta de vocabulario. La enfermedad: una palabra, una frase suplementaria.

Nociones de base

Nuestro cuerpo está compuesto de **células**; un conjunto de células con fines comunes y sus sustancias intercelulares lleva el nombre de **tejido**; muchos tejidos que tengan una función común se unen para formar un **órgano**; un conjunto de órganos es un **aparato**; y nuestro **cuerpo** es este conjunto de aparatos.

Cada aparato tiene una **función** principal, una manera de estar en el mundo, una misión, un sentido biológico de su pervivencia.

Función específica del aparato digestivo

El aparato digestivo gestiona el alimento por medio de los órganos que lo constituyen.

¿En el fondo, qué es, *biológicamente*, este alimento?

Para mí, es el mundo exterior. Comemos lo que nos rodea: las plantas, que se alimentan de los minerales que contiene el suelo; los animales, que han comido vegetales. Comemos lo que nos rodea, lo absorbemos, lo digerimos... ¡o no! La pregunta que podemos hacernos es: ¿aceptamos hacer nuestro lo que nos rodea? Porque lo que comemos se transforma, en nuestros intestinos, para convertirse en... ¡nosotros! Si como un tomate, no me vuelvo rojo, ni dulce o brillante, sino que continúo siendo el que soy. He ganado, he incorporado lo que me ha llegado. El mundo exterior, el universo, el Uno se ha convertido en mí mismo, único y unido por mi código genético. Mi tarjeta de identidad está presente en cada célula de mi cuerpo. Soy uno que prueba al Uno a fin de aceptarlo, digerirlo o rechazarlo, eliminarlo: el uno prueba Uno, y en muchos sitios.

Mi lengua prueba si el alimento está sabroso, apetecible, y el esófago, el duodeno, el intestino delgado y el intestino grueso se suceden con el fin de aplicar sus respectivos test: unos prueban Uno en los intestinos.

La adaptación específica del aparato digestivo

¿Aceptamos el universo que nos ha sido ofrecido, presentado, Él y todo lo que le constituye? ¿De veras (ostras, champiñones, caviar, despojos, etc.) o metafóricamente (conversacio-

nes venenosas, diálogos indigestos, vecina fastidiosa, palabras amargas, rostros de miel...)?

Podemos vivir *uno de los* elementos del plato como tóxico (las piedrecitas en las lentejas) y, a veces, aunque todo el resto, delicioso, haya salido bien, vamos a *devolver* todo: vamos a vomitar tanto lo bueno como lo tóxico.

Agredidos de manera digestiva, borramos ese alimento real o simbólico (problema de mala calidad) o ese exceso (problema de cantidad).

Agredidos o separados, porque también podemos tener carencia de alimento en cantidad o en calidad (ausencia de sabor, de vitaminas, etc.).

La **carencia** pura, lo sabemos, concierne al hígado; la **agresión**, al colon.

A menudo, los dos están presentes simultáneamente: «¡Quiero chocolate y me dan aceite de hígado de bacalao!»: **carencia + indigestión**. «Quiero un mimo y recibo una bofetada».

Funciones y matices

Si comparamos el tubo digestivo con un tubo, empieza en la boca para acabar en el ano. Comparación falsa, porque este tubo es dinámico y muy activo. Los alimentos, después del estómago, llegan al duodeno. Éste recibe las secreciones y las excreciones del hígado y del páncreas. Después del duodeno (25 centímetros), este tubo recibe el nombre de yeyuno (2 metros), luego se llama íleon (3,6 metros); estas tres partes forman el intestino delgado.

Múltiples funciones, cuando no son satisfechas, se transforman en conflictos biológicos que no hay que confundir entre ellos. Tienen contenidos y síntomas diferentes:

- **Función de tránsito**, mantenida por los músculos blancos con el fin de hacer avanzar el pedazo, o de no quererlo o de no poderlo. El autor hace un símil entre lo que sucede físicamente y la relación emocional. Por ejemplo: casi he vendido la casa, pero el comprador no ha pagado la totalidad de la suma, incumple. La situación es inaceptable y el dinero nos falta (carencia + indigestión vivida de manera motriz; parálisis del peristaltismo, estreñimiento. O: «Quiero hacer avanzar este pedazo vital bloqueado en mí, ¡y esto se está alargando!» y se desencadenan las diarreas).
- **Función de contacto**, mantenida por las mucosas de la boca al ano, que actúan como una piel interior, si queremos compararnos con una lombriz con una piel externa (tegumentos) y una piel interna (mucosa). Conflicto de separación con el alimento. El conflicto de contacto se impone frente a lo que uno no desea: problema de irritación de la mucosa, enfermedad de Crohn. Ejemplo: «Quiero la leche de mamá, lo que quiere decir que estoy en contacto con ella, pero no con su irritación».
- **Función de secreciones**: ¿acepto digerir lo que me imponen?
- **Función de secreción de mucosidad**, cuyo rol es el de hacer resbalar los alimentos y de proteger la mucosa; en efecto, puedo comer callos (intestino de animal) y los voy a digerir, pero en cambio no voy a digerir mi propio intestino que, sin embargo, es químicamente si-

milar al del animal. ¿Por qué? Gracias a esa mucosidad que actúa como una protección. ¿Acepto protegerme de lo que es tóxico para mí?

— **Función de absorción** de los nutrientes o alimentos desmenuzados en pequeños trocitos por todos los líquidos de la digestión (saliva, bilis, ácido clorhídrico, etc.). Es el momento esencial, el de la clasificación entre lo puro y lo impuro, entre lo que acepto y hago mío y lo que devuelvo al exterior, lo que excreto; al final del test, devuelvo lo que rechazo, lo que detesto, mientras que lo bueno del contexto se convierte en mi texto de vida.

— **Por último, una función particular: los gases.** Su papel es el de empujar hacia la salida lo que nos molesta, nos contamina, nos impide vivir. «Hay que acabar los deberes *cagando* para, después, poder compartir el pan con los amigos y amigas». **Aerofagia:** «Alguien ha muerto sin sepultura; los gases de putrefacción están en mí; soy su panteón». «¡Rápido!, un poco de aire en este barullo».

Resumen

¿La cosa ha *pasado* o no?

Si no ha pasado, no ha sido aceptada, gestionada, digerida y consumada, admitida, ratificada, ¡la cosa es devuelta al exterior!



LA SUBMUCOSA DE LA BOCA

Órganos afectados

La submucosa de la boca (capa profunda), así como la submucosa de todo el tracto digestivo.

La vivencia biológica conflictiva

El conflicto *del soldado raso*.

La tonalidad central es *arcaica*.

Aftas, candidiasis bucal.

Las aftas pueden ir de la boca al sigmoide.

SÍNTOMA A LA IZQUIERDA DEL CUERPO (diestro): «No lo puedo sacar, no puedo verter el pedazo».

«Lo vivo como una vileza, un insulto, una injuria, una grosería y, al mismo tiempo, me es imposible, prohibido responder».

«No consigo responder a un comentario molesto vivido de modo indigesto».

«No puedo responder a un insulto».

«Las palabras me han herido, pero yo no he contestado».

Pequeños conflictos de «marranada».

«Tenía ganas de decirte...».

Cuanto más agredidos nos sentimos, más dolorosas pueden ser las aftas.

Ejemplo: un soldado agredido por las palabras del jefe.
«Quiero rechazar algo concreto, por ejemplo un tumor».

Localización: Aftas cerca de los labios: la palabra casi ha salido. «Estuve a punto de contestarle que... y no lo hice».

Las palabras no dichas ulceran la boca, al igual que los deseos no dichos.

SÍNTOMA A LA DERECHA (diestro):

«No consigo atrapar el pedazo, aunque para mí es importante hacerlo».

Ejemplo: conflicto de no poder alimentarse aun cuando queremos hacerlo.

Candidiasis bucal:

«Me alimento de sufrimiento y de muerte».

«He perdido contacto con mi protector».

Ejemplos

El señor X tiene **aftas**. **Soldado raso**, no puede contestar a las órdenes y a los insultos del sargento y, por otro lado, quiere constantemente coger el pedazo de permiso.

La señora X tenía una buena colega, que se ha alejado de ella después de un suceso malinterpretado. Durante 15 días, sin poder aceptar esta actitud, la señora X ha vivido en el estrés de

desear un **intercambio verbal** con ella. No lo ha conseguido porque nunca la veía sola en el trabajo. Cansada, abandona y acepta la situación, de la cual se deriva la solución y, unos días más tarde, le aparecen enormes aftas dolorosas.

Aftas muy importantes

Conflicto programador: a los 7,5 años, la niña X se pelea con su hermanita; su madre le dice: «¡Eres mala, más tarde, serás incapaz de tener hijos y de cuidarlos bien!». La niña quiere contestarle que, más tarde, será una buena madre. No ve el momento de crecer.

Cuando dobla la edad, es decir, a los 15 años, su madre muere: «Ya no puedo responderle, probarle que seré una buena madre», la felicidad se vuelve imposible y escogerá a un marido totalmente diferente a ella, que sólo podrá conducirla al fracaso ¡y tanto mejor! Eso certificará su creencia generadora de decisiones: la felicidad es imposible.

Todavía a los 15 años, en el entierro de su madre, la familia le dice: «Ocúpate de tu padre y de tu hermana, sé responsable de ellos». Acepta porque se siente culpable de la muerte de su madre (muerta de un cáncer de mama, su madre se preocupaba por ella, anoréxica, y se lo reprochaban: «Preocupas a tu madre, ¡come de una vez! La pones enferma»). Para redimirse, se considera responsable de su padre y de su hermana sin poder decir ni lo que piensa ni lo que siente, es decir: «¡Es injusto, yo también existo, estáis todos podridos!».

Más tarde, encuentra a su futuro marido, que la presenta a su familia. Al día siguiente, su novio le pregunta a su padre:

—¿Qué te parece?

—Las has tenido mejores; tiene una cabeza de rata.

Repite esas palabras a su novia;

—¿Y tú, qué le has contestado?

—Bluf, ¡nada de nada!

Ha perdido su madre a los 15 años y esperaba encontrar, a través de esta familia política, una madre y una familia. Conflicto en ese momento: «Él no contesta y no dice nada frente a los insultos». Las aftas empiezan tres meses después de su boda.



LOS HUESOS DE LA MANDÍBULA

La vivencia biológica conflictiva

El conflicto *del psicoanalista*.

La tonalidad central es *desvalorización*.

Desvalorización vinculada con la palabra, con la expresión.

Desvalorización porque no nos sentimos escuchados, aunque es importante serlo.

«Me prohíbo expresar mi propia agresividad».

«Tengo algo insoportable que decir».

«No he podido hablar».

«Me reprocho no haber utilizado la expresión justa».

«Me desvalorizo a través de mis palabras».

«El otro no dice nada y, por lo tanto, me siento aislada».

«¡Decir ya no tiene sentido!».

«Él/ella no tiene palabra, él/ella me ha mentado».

A LA DERECHA (diestro):

«Me desvalorizo por no poder atrapar el pedazo o por no poder retenerlo cuando lo he cogido».

«No soy capaz de coger y de guardar el pedazo, material o inmaterial (ejemplo: tiempo, palabra)».

«Aunque lo coja, no puedo retenerlo».

A LA IZQUIERDA (diestro):

Conflicto de desvalorización por no poder exteriorizar el pedazo (de palabra, de violencia, de comida, etc.).

Zurdo(a): es sencillamente lo contrario.

Maxilar (mandíbula superior):

Conflicto ligado a la alimentación.

Desvalorización en relación a algo que hemos comido.

Desvalorización relacionada con la comida. Ejemplo:

«Debería dar ejemplo en la mesa a mi hermana pequeña, pero como jamón. Nos peleamos. Me desmorono».

Conflicto en relación con el padre, en el estómago.

/// Observamos aquí descodificaciones diferentes para el mismo órgano. ¿La mandíbula superior está vinculada

/// a un conflicto con el padre? ¿A la comida? ¿A los dos?
¿A otra cosa? Nos corresponde explorar.

Igualmente, la mandíbula inferior, que vamos a ver ahora, sirve para la palabra y para la masticación.⁶

Mandíbula (mandíbula inferior):

Este hueso es móvil.

«Me está prohibido hablar».

«Me desvalorizo de no haber podido expresar mi agresividad».

«Mi palabra, fundamentalmente, no tiene peso, **no tiene valor**, no soy comprendido».

«Hablar no sirve para nada».

«¡Eso que dices es estúpido, inútil, nulo!».

«¡Cierra el pico! ¡Cállate!».

Cólera, rabia contenida.

«Y cueste lo que cueste quiero hablar, masticar, comer o morder».

Conflicto en relación con la madre.

DESMINERALIZACIÓN, ABSCESO EN LA MANDÍBULA, QUISTE EN LA RAÍZ DE LOS DIENTES:

A menudo, esto pone en peligro el diente.

«Me reprocho haber estado agresivo, hubiera querido no tener dientes, no haber mordido...».

6. Observaremos este idéntico fenómeno en los dientes. Numerosos autores divergen sobre su interpretación de tal o cual diente.

«Soy demasiado cruel». La persona se desvaloriza, se culpabiliza. Esto puede provocar descalcificaciones de la mandíbula y, de esta forma, no nos arriesgamos más a ser agresivos en el futuro; ¡nuestras armas, los dientes, caen! «Me neutralizo antes de ser agresivo».

No hay que reconocer un muerto.

LA ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR O ATM

«Tengo que ser competente en la palabra, en la capacidad de morder, en el movimiento de la mandíbula».

Conflicto de no poder atrapar el pedazo.

Desvalorización por haber mordido de forma real o verbal.

«He ido demasiado lejos con eso que he dicho».

«Lo que tengo que decir me desvaloriza (me prohíbo ser agresivo)».

«Mi palabra no ha sido eficaz».

ATM que se parte:

Confrontación por la palabra, disputa.

«Diga lo que diga, está mal».

Conflicto por no poder abrir la boca, por no poder contradecir, por no poder oponerse verbalmente a la palabra de los demás.

«Hablar me desvaloriza».

«En cuanto hablo, me siento juzgado, entonces mejor callarme y bloquear mi mandíbula para no arriesgarme a decir una tontería y ser criticado».

Freud (Segismundo, su verdadero nombre) murió de un cáncer en la mandíbula.

Es el descubridor del psicoanálisis. Desarrolló la terapia durante la cual ¡el terapeuta está sin palabras!⁷ «Nada de palabras», «Estoy sin palabra, un cerebro entendiendo y una oreja escuchando».

Freud entiende todo el drama de su propia vida familiar y no puede decir nada.

Descubre el psiquismo. Entiende los horrores y no puede decir nada. Es así, en la época, en la sociedad bienpensante de Austria.

Es víctima de un cáncer tan doloroso en la boca que necesita opiáceos.

La traducción (fonética) de Segismundo es: ¡«victoria por la boca...»!

Ejemplos

¡Están taponados!

Un hombre brillante había confeccionado un plan para la reorganización de una empresa. Cada vez que lo proponía al consejo de administración, no lo incluían en el orden del día y no lo podía presentar para exponerlo. Se sentía muy desva-

7. Uno de sus maestros, Charcot, estaba, sin embargo, frente a pacientes en silencio y era el único que hablaba cuando los ponía en hipnosis.

lorizado. Estaba acostumbrado a que le escucharan durante horas, dada su elocuencia. Pero este proyecto molestaba a la dirección. Patología en la mandíbula.

Profesor de física

La señora X tiene una **pérdida de dientes (debido a una pérdida de encía) y una descalcificación del hueso de la mandíbula superior**. Su hija tiene dificultades escolares (en particular, la física); habla con su marido, que es profesor de física en la facultad. Pero ella se dice de antemano, incluso antes de intentar hablarle: «Como siempre, se lo va a tomar mal, va a sentirse acusado», entonces no le dice nada. «No voy a decirle nada; no va a escucharme, y me replicará: "¡No es interesante lo que tienes que decirme!"». Luego, ella se reprocha su silencio, culpabiliza por no haber intentado hablarle cara a cara de su hija quien, finalmente, repite curso.

Demasiado violento

El señor X tiene mucha rabia, mucha violencia contra su hijo al que, por otra parte, quiere. Por ello, él neutraliza su agresividad: «Es preciso que me abstenga de morder»... descalcificando el hueso que sostiene el diente. El diente, a causa de esto, sólo puede caer; la agresividad, de esta forma, se ha impedido, el programa ha funcionado bien. El padre tuvo un **absceso en la mandíbula seguido de un quiste en la raíz del diente**.

ATM

Una dama se queja de un **trismo** permanente y doloroso en la articulación temporomandibular. Padece una contractura de los maseteros, músculos de la mejilla muy potentes. La única

cosa que la alivia es abrir la boca de vez en cuando. Se queja, además, de dolores cervicales. Ha tenido crisis de espasmo-filia con la sensación de ahogarse. Tiene problemas en el vientre. El terapeuta le pregunta si nació con el cordón umbilical apretado alrededor del cuello. Nació, efectivamente, de esta manera. Él le pregunta qué pasa cuando nacemos así. Se levanta, aprieta el cuello de la dama y le pide que pruebe a respirar. Eso obstruye, no es posible. Cuando apretamos el cuello de alguien para impedir que respire, pasa esto: la persona tose y abre la boca para que entre el máximo de aire en ella. Es preciso que el ATM sea competitivo para que pueda dejar entrar el aire. La paciente tenía este recuerdo desde su nacimiento y, después de que el terapeuta le haya puesto la mano en el cuello, se ha puesto a toser durante dos minutos. Y más tarde, ha desbloqueado completamente su ATM.



EL PALADAR

La vivencia biológica conflictiva

Conflicto del *cuervo y el zorro*.

La tonalidad central es *desvalorización*.

Bóveda del paladar

«Ya tenía el pedazo en la boca y, de repente, se me escapa».

«Mis placeres me han sido quitados de la boca y esto me vuelve amargo».

«Es como si, en mi boca, tuviera ya la comida y ésta se escapara porque mi boca no es lo suficientemente hábil». Gran desvalorización ligada a la palabra, peligro en relación con la palabra, introversión.

El velo del paladar permite que la palabra sea correcta.

Conflicto: «**Mi palabra está aprisionada**».

Ejemplos

La lotería - paladar

El señor X ve el resultado de su combinación de la lotería en el periódico. Está seguro de que ha ganado. Quiere celebrarlo y paga rondas en el bar a todo el mundo. Vuelve tarde a casa, su mujer le sermonea: «¿Y las mensualidades de los créditos?...», y le trata de estúpido porque el juego que ha hecho durante diez años, esa combinación ganadora, ¡la ha cambiado hace dos meses! Y el pedazo, el premio gordo que creía haber pescado, se le escapa. En los dos meses siguientes, le diagnosticaron un enorme **tumor de paladar**.

Nada de ascensos

El señor X trabaja en impuestos. Durante cinco años, ha dado pasos para cambiar de destino. Está seguro de tener acceso a un puesto mejor. La persona que lo ocupa es mayor y se jubila. Además, todo el mundo está de acuerdo en que acceda

a ese puesto, su jefe y sus colegas. Para él y para su mujer, es como un gran ascenso en la vida. La mujer está embarazada y espera esa promoción. A las 17:30 horas tiene lugar el brindis de despedida del jubilado. El sucesor espera el final de la ceremonia. El jefe del servicio le llama a su oficina para decirle que no tendrá ese puesto, es para alguien que ha sido nombrado de improviso, por orden ministerial y directamente desde París. En el momento en el que, por fin, accedía al puesto, se lo han quitado. Es terrible: «Es porque mi paladar no es bastante grande: es demasiado pequeño». Su hijo nace con un **paladar hendido y un labio leporino**. Abre todavía más la boca para poder atrapar todo.



LOS DIENTES

Los dientes son el lugar más duro del cuerpo.

Son como los pilares del paladar.

Los dientes materializan la frontera entre yo y el exterior.

La vivencia biológica conflictiva general

Los incisivos:

Son ocho en total, afilados, están ahí para cortar.

Para algunos investigadores, están relacionados con la seducción, porque son éstos los que enseñamos.

Los caninos:

Cuatro, están ahí para despedazar, desgarrar.

En relación con el trabajo, el ensañamiento, a veces, con el odio o la vida sexual.

Los molares:

Ocho premolares para machacar y doce molares para triturar.

La protección, la resistencia, la perseverancia. Nos sentimos afectados en su **estabilidad**.

Pistas para explorar:

«¿Cuáles son las mentiras dichas?».

Conflicto de la piedra del molino.

Dientes superiores: «Muerto».

Dientes inferiores: «Como».

**Pulpa de los dientes:**

La pulpa nutre, alimenta al diente.

«No puedo nutrir mi agresividad».

Pérdida de sus dientes:

Hay dos denticiones sucesivas (dientes de leche, entre seis meses y siete años, y definitivos, a partir de siete años).

Renunciar a su juventud, a su agresividad, a su poder.

«¡Cállate!».

Signo de sabiduría en el anciano, rechazo a hacerse mayor, a ser agresivo para el joven.

AGENESIA DE LOS DIENTES:

Si esto no tiene la función de morder, los dientes van a desaparecer. También puede haber habido peligro de morder.

Ejemplo: agenesia de cinco dientes.

Una mujer tenía una hija a la que no le habían salido nunca cinco dientes. Si ella hubiera podido morder durante su infancia, me dice, estaría muerta. De niña, ¿no había tenido el derecho! Muerde = muerte.

SARRO, PLACA DENTAL:

Conflicto de trituración imposible.



Collar de dientes:

Los primitivos llevan dientes alrededor del cuello. Es un signo de poder y de agresividad victoriosa.

Ejemplo de un dentista:

Querer arrancar la agresividad de alguien.

Extraer un secreto de familia.

El hombre que rechazaba toda agresividad

El señor X tiene un cáncer de recto sigmoide, un cáncer de hígado. Está delgado. La primera impresión que produce es la

de estar *en las últimas*. Me dice que es cristiano. Y, a medida que avanza la entrevista, lo que más le choca de Cristo es la expulsión que hizo de los mercaderes del templo. Dice que, en este tema, Jesús ha debido de equivocarse. No se expulsa a la gente. Hay que ser buena persona. Él es dentista; va a limar la agresividad de todos los pacientes a los que encuentra. Y se prohíbe ser malo. Se le puede machacar, se le puede dar puñetazos y si, a fuerza de darle puñetazos, nos hacemos daño en las manos, él vendrá a curar las manos que le han pegado. No hay que ser agresivo; él está en peligro de muerte por ese exceso de querer *borrar*. Porque su **consciencia biológica** está a la altura de los dientes, de la agresividad. Aunque sea por negación, porque hay que limar los dientes, a pesar de todo, es ahí donde él pone SU CONSCIENCIA. No es una persona agresiva. Es alguien antiagresivo. Poco importa. Que seamos agresivos o estemos contra la agresividad, es la misma focalización. Es la agresividad lo que cuenta y, en todas las cosas, él busca no ser agresivo y evitar la agresividad. Lo que cuenta para él es la armonía a cualquier precio. Sólo que la armonía lleva a la soledad. La armonía, en lenguaje fonético es: *art monie*,⁸ el arte de estar solo. Monie: monos = *le moine* (el monje); etimológicamente, viene del griego *monachos* «soltero, solitario, único», derivado de *monos* «solo».

«En nombre de mi voluntad de estar en armonía con el grupo, me encuentro solo». Porque no es realista; en cuanto hay una relación, hay un conflicto potencial.

8. Literalmente, arte del monje. (N. de la T.)

La señora X se come la palma de las manos
«No tengo derecho a **morder** al otro, así pues me muerdo a
mí misma».

Autoagresividad.

Callarse

La señora X está obligada a callarse: se convierte en psicoanalista.

Bruxismo:

Es vital hablar y es vital callarse.

Es una tentativa de romper la prohibición familiar que exige callarse, para no revelar un secreto de familia, pero es vital hablar.

«Me impidieron hablar».



LA DENTINA

Se trata del interior del diente, es un hueso que depende del tercer estrato de la biología (véase pág. 112). (El esmalte depende del cuarto estrato.)

La vivencia biológica conflictiva

El conflicto del *teckel*.

La tonalidad central es *desvalorización*.

Conflicto de desvalorización por no poder, por no ser capaz de morder porque nos sentimos demasiado débiles.

Es el conflicto del perro teckel; el san bernardo es capaz de morder, pero no le está permitido hacerlo; ¡es el esmalte del diente!

«No doy la talla frente a...».

«Necesito morder, me desvalorizo porque no he sabido morder». Es una necesidad natural, fisiológica.

Al principio del conflicto: osteólisis indolora, agujeros en la dentina, es decir, en el interior del diente. Generalmente, sólo son visibles en la radiografía del diente.

Ejemplos

Alumno

La maestra le tiene tirria y él no puede responder, no por educación, sino porque se siente más débil que ella. El terapeuta le dice que muerda una manzana cada vez que tiene un problema con la maestra. Después de varios meses, la **caries** se estabiliza; necesitaba sacar su agresividad.

Inhibido

El señor X tiene **caries** en varios dientes. No sabe decir no, se responsabiliza de todo, no soporta los conflictos, dice sí y se lo reprocha; falta de confianza en sí mismo.

Dolores en los dientes

La señora X tiene dolores en los dientes desde que empezó un régimen. Le gustaría comer todo lo que ve, pero no puede hacerlo. Quiere atrapar el pedazo.



EL ESMALTE DE LOS DIENTES

El esmalte resulta del endurecimiento de la mucosa bucal en el epitelio pavimentoso, espeso y queratinizado.

La vivencia biológica conflictiva

El conflicto del *san bernardo*.

La tonalidad central es *social*.

«No tengo derecho a ser agresivo».

«Eso de morder a los demás no se hace».

Está prohibido morder **por buena educación, por moral**.

«Podría morder, soy capaz, pero no tengo derecho a hacerlo, ¡me han educado demasiado bien!», ¡como el san bernardo!

A menudo, se añade a ese conflicto una desvalorización ósea de la dentina.

El conflicto de no tener derecho a morder es específicamente humano.

«Tengo que callarme».

«No puedo enseñar los dientes, los colmillos, nunca; tengo que guardar *la rabia dentro*».

«No puedo expresar mi poder».

«Tengo el diente duro».

«Quiero despedazarlo a dentelladas y no puedo hacerlo».

«Me echan la bronca y no respondo».

«Me rompo los dientes».

Ejemplos

La señora X tiene una **caries entre los dos incisivos superiores**.

Siempre tiene el mismo tipo de sueño: es agresiva verbalmente frente a personas diferentes. En la realidad, querría cantarles las cuarenta a sus allegados pero no puede hacerlo, *por buena educación*. No quiere decepcionar las enormes expectativas que todo el mundo tiene puestas en ella; si lo hace, dará pena. Se prohíbe mostrarse violenta, hablándome nota cómo le tiemblan las manos.

En clase de primero, es el *shock*: está en el instituto y se enfada con los alumnos que se burlan de ella. «Quiero de-

cir quién soy con violencia, pero no puedo expresarla porque tengo miedo de mi violencia»; comienzo de la caries y de los dientes amarillentos.

Dolores de otro mundo, o de otra índole, a la altura de los dientes y quiste...

El señor X estaba a punto de tomar morfina, de tan fuerte que era el dolor de dientes. Estaba tomando antibióticos. Me explica que estaba haciendo un retiro budista con su cuñado, al que detestaba. Decía que tenía que estar lleno de amor y de compasión. Era vegetariano. En el transcurso de la sesión, le pregunto si, más bien, no tiene ganas de comerse a su cuñado. Me responde que no y añade: «Escuchando a cada uno, escucho cada palabra, cada entonación, me impregno del ambiente del otro cuando encuentro a alguien. De esta forma, soy como una pantalla blanca y me convierto en la historia, lo biológico, lo vivido, lo emocional del otro, en lo que yo interpreto». Y le pregunto: «En el fondo, ¿no hay una parte de ti que no habría amado (e intento ser, verdaderamente, muy dulce con él), pero sólo una pequeñita parte de ti que, posiblemente, en un momento u otro, habría tenido ganas de morder un poco?». Él me contesta: «Pare, me impresiona mucho. No puedo decir qué, pero está moviéndose, y creo que tiene razón». Pero estaba viviendo una emoción desconocida.

Puede ser que un aspecto de su práctica budista no fuera más que una compensación de esa violencia que no podía gestionar porque se creía culpable, malo u otra cosa. Algo muy duro. Y allí, ya atravesó la etapa de poder entenderse, de autorizarse a pensar que podía haber una violencia en él.

He empezado a abrir las puertas. «Es como si, más que ser agresivo con el otro, prefirieras hacerte daño a ti mismo». Me ha contestado que su vida era eso. «Es la compasión, soy *bodhisattva*⁹ y prefiero sufrir, hacerme daño a mí antes que hacer daño a los demás». De esta forma, el síntoma era coherente.

Resumen de los matices dentina/esmalte

El diente es hueso recubierto por el esmalte.

Si es el hueso el que está afectado, es una vivencia de desvalorización: «No soy capaz de morder».

Si es el esmalte: «Soy capaz de morder, pero no me lo permito, me lo prohíbo moralmente».

El san bernardo Esmalte se prohíbe morder al perrito Dentina; el perrito querría hacerlo pero no puede, vive una desvalorización.

Los niños del colegio no se sienten a la altura para morder, se desvalorizan. La dentina, es el 3.º estrato, el esmalte el 4.º estrato, la vida social, los intercambios.

9. La etimología de la palabra *bodhisattva* proviene de las raíces sánscritas *bodhi* (iluminación) y *sattva* (ser), y se trata de un término que alude a un ser que aspira a lograr la budeidad y realiza prácticas altruistas para alcanzar dicha meta. El *bodhisattva* se caracteriza por el amor compasivo y porque no busca sólo su propia iluminación, sino también guiar a otras personas para que la alcancen. (*N. de la T.*)

Observación

Existen diversas descodificaciones para cada diente; la relación con el padre, la madre, etc. Pero, a mi juicio, es conveniente trabajar en primer lugar la agresividad. Desde luego, hay unos matices, unas subtonalidades que son útiles, a veces, y siempre hay que verificarlo como complemento de un tratamiento odontológico. Ejemplo: **incisivo superior izquierdo roto**, la madre amenaza con divorciarse; **incisivo superior derecho roto**, el padre amenaza con divorciarse.



LAS ENCÍAS

La vivencia biológica conflictiva

El conflicto de *conferenciante*.

La tonalidad central es *social*.

Desvalorización relacionada con la palabra.

«Mi palabra no da la talla».

«No puedo expresarme».

«No me siento escuchado».

«Mi palabra no tiene importancia, no tiene valor».

Pérdida de sus raíces.

Pistas para explorar prudentemente.

Injusticia, rebelión contra un ideal de amor no alcanzado.

Rebelión contra la morriña.

La recesión gingival traduce, a veces, una marginalización y una desadaptación. Los problemas de los dientes traducen, para ciertos investigadores, una indecisión, una incapacidad para desmenuzar las ideas, un análisis deficiente de las situaciones conflictivas.

La injusticia, el orgullo herido y el sentimiento de rebelión.

Síntomas

Los dientes se descarnan, las encías se retractan. Gingivitis. Las encías sangran. Parodontosis. Mal aliento.

Ejemplos

Gingivitis, las encías sangran

El señor X siempre tiene miedo de decir una tontería cuando está en grupo; le da mucha importancia a las palabras. De niño, se sentía acomplejado frente a su hermano mayor, porque su hermano sabía leer, contar, etc.

«¡Si por lo menos lo hubiera dicho!»

La señora X tiene los dientes superiores, a la izquierda, que se le mueven. A los 17 años, vive un drama, su padre le prohíbe ver a un chico que le gusta mucho. No debe hablar de él; ella se avergüenza de no poder expresar a su padre todo lo que piensa, así como la rabia que siente.

Cursos de prácticas y retracción de las encías

La señora X empieza unos cursos de kinesiología y de naturopatía. Siente una apertura profesional y desea la armonía, se prohíbe la violencia; quiere estar serena, sin conflicto. Habla de sus cursos con su marido, pero no se siente comprendida, escuchada. Es emotiva, se expresa mal, se abstiene de hablar cuando no es comprendida: «Mi palabra no tiene peso». Conflicto programador: fue concebida antes del matrimonio y ese embarazo no fue aceptado por su abuelo materno; él desaprueba, ella no tiene valor.

Ulceración de las encías

El señor X dice: «Si hablo, se entiende otra cosa. ¡Lo digo yo, no me creen! ¡Me tratan de mentiroso!».

Dientes que se rompen

Desde hace aproximadamente un año, las encías del señor X sangran, se retractan, especialmente alrededor de los caninos inferiores derechos. En esa misma época, su esposa empieza una terapia y se siente bien, discute, dice lo que piensa, se impone, hace reflexiones que le hacen daño. Esto le pone los pelos de punta, **no contesta nada** pero se siente «comido». De niño, es su padre, el hombre, el que manda; la madre,

por el contrario, nunca dice nada. En el modelo familiar, es el hombre el que debe ser respetado y la mujer la que debe callarse. Se siente herido en su derecho (masculino) adquirido (inferior); los dientes se mueven, las bases se mueven.

Los dientes del fondo se curan, se fijan; los de delante no, ¡los que se ven! Se juzga mucho: «Eres muy tonto»; se lo repite. Es la voz de su tía, él la reconoce. Siente agresividad contra ella, está furioso con ella («Soy tonto por no decir esto y aquello»). Tiene ganas de morder continuamente.

Una mujer joven

Su padre le dice: «Perdona, no te he escuchado, me he equivocado»; **brusca resolución** de su conflicto, las **encías** empiezan a sangrar abundantemente.



LA GLOTIS, LA EPIGLOTIS, LA ÚVULA (CAMPANILLA)

La vivencia biológica conflictiva

Epiglotis:

«Tengo que clarificar mi discurso».

«Debo protegerme de la crítica».

«Alguien en mi memoria ha muerto asfixiado comiendo».

Espasmos de la glotis:

Es vital cerrar la escotilla.

Memoria de un camino equivocado y mortal; si bloqueamos el pasaje, esto no entrará.

«Ha entrado en mí algo grave, mortal». En ese momento, la solución es *espasmar*, así no pasará nada más; *«nunca más esto!»*.

Espasmos de deglución:

«Algo se me ha quedado atravesado en la garganta».

Atragantarse:

«Quiero dar fluidez a mis relaciones con los demás».

«Tengo la sensación de haber tomado un camino equivocado».

Úvula (campanilla):

Condicional de la palabra.

«En la mesa, hablarás *si* has acabado la sopa»; por lo tanto, estoy frustrado en la palabra y tengo problemas de úvula (campanilla).

A menudo, estos pacientes hablan en términos impersonales o de «nosotros».

Parálisis de la úvula (campanilla):

Esto puede ocasionar caminos equivocados.

«Hay algo que no puedo tragar, que me niego a tragar».

«No puedo aceptar esto, tragar y esto se me atraganta en la garganta».

La úvula (campanilla), ¡qué órgano!

Un estudio de Jean-Philippe Dumoulin, psico-bio-terapeuta

Como veremos más adelante, la anatomía y la fisiología de la úvula (campanilla) permiten la expresión de una vivencia compleja.

Un paciente se queja de que se ha quedado sin voz y de una úvula que han diagnosticado inflamada y reblandecida. El síntoma es que la úvula se ha quedado pegada en el fondo de la garganta.

Durante la primera sesión, pienso en la incapacidad de escuchar su propia identidad (faringe) y en los dibujos manga (cómic japoneses) que, a veces, muestran las bocas aullantes en cuyo fondo vemos dibujarse una campanilla.

Trabajamos, pues, esta rabia y su identidad vocal, su expresión. La voz empieza a volver, pero la campanilla continúa pegada.

En la segunda sesión, controlo la anatomía y la fisiología de la campanilla. Es un órgano que se encuentra en la extremidad trasera del velo del paladar. Está compuesto de mucosas y de músculos. Su función es la de proteger, la de separar las vías aéreas superiores de las vías digestivas cuando deglutimos. La campanilla tiene funciones en el momento de la fonación para la G (guitarra), la J (jamón), la K (Carolina), cerrando las partes aéreas superiores.

Durante esta segunda sesión, la voz volvió a ser normal y la inflamación desapareció. Los síntomas que perduran son el reblandecimiento del músculo y la campanilla, que está pegada a la deglución de la saliva.

De esta manera, elaboro el portal de entrada en biología, gracias a la fisiología y a la anatomía:

Aparato digestivo/respiratorio

Músculo reblandecido	Impotencia
Vías aéreas	Espacio, libertad
Superiores	(superior)
Deglución	Tragar
Saliva	Incorporar
Separar	Separar
Protección	Proteger
Separación	Separar
Inflamación	(cólera)
Fonación	(expresión)

Escribo cada palabra de la columna derecha en un trozo de papel y dejo al paciente hacer una frase con estos términos. Le explico que puede añadir otros o, por el contrario, quitarlos, reorganizarlos, transformarlos para formar una frase que corresponda a su vivencia.

«¡Bingo!».

Después de algunos tanteos para precisar su vivencia con las palabras propuestas, dice: «Tengo dificultades para marcar de manera nítida mis límites; ser yo mismo o ser incorporado».

La frase final, que expresa perfectamente su vivencia, es: «A veces, tengo dificultad para expresar libremente mi manera de ser, particularmente frente a un sistema establecido».

Y yo de descifrar: «Cuando dices eso, ¿qué sientes en tu cuerpo?... ¿es cuándo (momento preciso)?...».

Este ejemplo muestra bien:

- la utilidad de conocer la anatomía y la fisiología;
- la eficacia del portal (*véase* pág. 159);
- que dejar al cliente hacer su frase él mismo es pertinente (y tranquilizador).



LA LENGUA

La vivencia biológica conflictiva

Si el **músculo** está afectado, desvalorización relacionada con el hecho de utilizar su lengua, por ejemplo para sacarla, para hablar o incluso para servirse de ella sexualmente. Ejemplo: durante la guerra de Argelia, el señor X debía traducir a los soldados el árabe que hablaban los torturados.

«No te vayas de la lengua».

«Hablar por los codos».

Sabores:

El gusto de las cosas.

«La vida ya no sabe a nada».

Nuestra relación con los sabores da mucha información.

Necesidad de dulce:

El sabor dulce es experimentado por la punta de la lengua.

«Necesito a mamá para vivir», necesito ternura, dulzura.

Necesidad de **salado**:

«Necesito un padre: salario, dinero, valor de las cosas, profesiones...».

«Necesito condimentar la comida».

Necesidad de **ácido**:

«Necesito comprender, aprender, analizar, destruir el envoltorio de las cosas para llegar a su centro, debo descubrir la vida».

Necesidad de **amargo**:

«Necesito base y madurez».

Lo amargo mata el yo; *la amargura*.

La bilis básica, amarga, neutraliza lo que viene del estómago, HCl ,¹⁰ el ácido.

Ácido + base = agua + sal; de esta forma, encontramos la madre (el agua) y el padre (la sal).

Todo esto pasa en el duodeno, el *duo de nombres*.

Ejemplos

Una mujer **pierde el gusto del salado**. Añade sin cesar sal, ¡a todos sus alimentos!

«Un día, fui a la playa, e incluso el mar ya no estaba salado».

10. Ácido clorhídrico o solución acuosa de cloruro de hidrógeno.

Conflicto: «La vida ya no tiene sabor, me gustaría que todo el mundo hiciera como yo, ¡bio-descodificación!», me dice.

En los problemas con la sal, el terapeuta debe explorar la relación con el padre.

«Hace falta gusto, sabor en mi vida», es una forma de depresión. «Ya no tengo ganas de nada,¹¹ ya no tengo ganas de vivir».¹²

Macroglisia

El señor X vive en un país multilingüe: «Es preciso que mi lengua sea hablada. Mi lengua debe ser preponderante y yo no dije bastante».



LA BOCA Y SU DIVERSIDAD

La vivencia biológica conflictiva

Mentón = emotividad.

Hueso del mentón: desvalorización en términos de emociones.

11. *Goût à rien*, literalmente, en francés: «gusto a nada». (N. de la T.)

12. Ídem nota anterior: *plus le goût à vivre*, literalmente, en francés: «ya no tengo el gusto de vivir». (N. de la T.)

La emoción puede manifestarse por un temblor del mentón.

Tocar el mentón es una manera de ponerse en contacto con el cerrojo de las emociones.

Tics de la boca:

«Está prohibido o es peligroso hablar, expresarse, comer, pero continuo haciéndolo en mi biología, secretamente, *en silencio*».

Labio inferior: femenino.

Labio superior: masculino.

Ejemplos

Un automovilista se ve forzado a soplar en un **test de alcoholemia** y le retiran su permiso de conducir. Él se autoevaluaba ya negativamente; estrés - **úlceras bucales**.

El señor X tiene un **tumor en el cavum**.

Shock desencadenante: «Mi mujer se ha marchado sin decirme por qué; me hubiera gustado **atrapar esa palabra** que no ha salido de su boca, lo no-dicho» (él se siente en conflicto y no puede hablarlo con nadie).

Shock programador: tres años antes, se enamora de su vecina, veinte años más joven que él. Como ella recibe galantes proposiciones de hombres de su edad, está celoso; quiere poseerla, **atrapar el pedazo, este «bombón»** (instintivamen-

re, biológicamente: el *esto*) pero, **razonando** (superego), se da cuenta de que es un completo idiota y de que sería mucho mejor no desear relaciones sexuales con ella. Recuerda que, en esa época, cada vez que un joven se acercaba a la puerta de la vecina, él notaba una sensación extraña en la boca.



LA FARINGE, LAS AMÍGDALAS

Para más detalles, remitirse a la obra: *Décodage biologique des problèmes respiratoires et ORL*.¹³

La vivencia biológica conflictiva

La tonalidad central es *arcaica*.

«El pedazo puede escapárseme en todo momento».

«Casi lo tengo, pero todavía puede escapárseme; no estoy seguro de tenerlo; todavía pueden quitármelo».

Desvalorización teñida de angustia; las amígdalas son un tejido linfoide.

13. Editions Le Souffle d'Or.

Ejemplo

Un niño quiere ir a un cumpleaños. «Primero tienes que acabar los deberes, si no...», le amenaza su madre. Cuando su madre le dice «puedes ir», se le declara una angina en fase de reparación.

Es el interrogante «¿Tendré el placer de ir a la fiesta o no?» el que crea el *shock*, es decir, la incertidumbre de tragar el pedazo.

Punto pedagógico: las fases de la enfermedad

Nuestra vida atraviesa dos fases muy distintas:

- la fase del despertar, de actividad, de estrés útil y necesario. Para la mayoría de la gente, esta fase se desarrolla durante el día, nos permite alcanzar nuestros objetivos, sobrevivir.
- la fase de descanso, de recuperación, de relajación, de sueño que, la mayor parte del tiempo, tiene lugar durante la noche.

Estas fases son más o menos intensas según la necesidad, y la necesidad más grande es la de adaptarse. Cuando ocurre un acontecimiento particular, que nosotros llamamos bio-shock (*véase* la introducción de este libro), todo el cuerpo, el cerebro y la consciencia pasan a la primera fase. Esta fase está gobernada por un sistema neurológico particular, el sistema ortosimpático, SOS, llamada fase de simpaticotonía. La fase de recuperación está gestionada por el sistema parasimpático o sistema vago. Toma el nombre de fase de parasimpaticotonía o vagotonía. Estas dos fases dan síntomas muy diferentes. La primera tiene por objetivo

movilizar toda nuestra energía, todos nuestros recursos y nuestra atención; mientras que el objetivo de la segunda es el retorno a las funciones normales o normotonía.

✱

LAS GLÁNDULAS SALIVALES: LA GLÁNDULA

Parte del órgano afectado

La parte acinosa de las glándulas salivales.

La vivencia biológica conflictiva

Conflicto *del hámster y del conferenciante*.

La tonalidad central es *arcaica*.

GLÁNDULAS A LA DERECHA (diestro):

Las glándulas situadas a la **derecha** están relacionadas con el deseo de hacer **entrar**: «Quiero deslizar la comida que quiero», por ejemplo.

«Tengo miedo de no poder **incorporar** el pedazo».

Haría falta, a toda costa, pero no podemos atrapar el pedazo (lo más común: de comida).

Miedo a la inanición. Miedo a no ser capaz de encontrar de qué alimentarse, a quedarse totalmente desprovisto de alimento (exactamente, como el hámster que almacena granos en sus mejillas).

«¡Me quitan el pan de la boca! Mientras se me hace la boca agua».

«Tengo miedo de no poder satisfacer mi necesidad de alimentarme».

GLÁNDULAS A LA IZQUIERDA (diestro):

«Tengo miedo de no poder **escupir** el pedazo».

Las glándulas situadas a la **izquierda** están relacionadas con el deseo de hacer **salir**: escupir el pedazo de comida no querida, por ejemplo.

«¿Qué me he tragado en mi vida que detestaba profundamente?».

«Me han quitado el pedazo de la boca», dice un hombre aquejado de un tumor de la glándula parótida izquierda.

Y para las **zurdas** y los zurdos, es como para los otros órganos: la vivencia del otro lado.

Para la glándula **parótida**, conseguir el pedazo es un poco más vital, y un poco menos seguro, que para la glándula submaxilar.

GOUGEROT-SJÖGREN:

Afección autoinmune con insuficiencia generalizada de la secreción de las glándulas exocrinas, con poliartritis y arteritis crónica.

«Debo tragar eso que no me gusta».

«Me niego a salivar».

«Rechazo ensalivar para no tragar».

«Me retracto, guardo todo en mí».

«Hubiera querido que el otro no me escupiera encima».

Esta patología puede alcanzar a las lágrimas de los ojos:

«No hay que llorar, hay que retener las lágrimas, esconder las emociones, hacerse el fuerte».

HIPERSIALORREA: HIPERSALIVACIÓN

Hay veneno que no ha podido ser escupido, palabras que no han podido ser dichas.

«Quiero escupir el pedazo de... que me lo han impuesto».

Memoria de alcohólico: hay que diluir el alcohol.

Sentido biológico

La glándula **parótida**: conflicto del hámster que quiere **almacenar** impulsivamente el alimento para **asimilarlo** después con toda tranquilidad.

Asimismo, es el conflicto del **coleccionista** que acumula esto o aquello sin poder evitarlo. A veces, la explicación reside en el hecho de que alguien en su genealogía careció de ello. Por ejemplo: «Colecciono sellos porque, durante la guerra, mi abuela siempre esperó una carta de su marido, una carta que éste no podía enviar... por falta de sellos».

También es el problema tan habitual de los **conferenciantes**, que tienen la boca seca y que no pueden dejar de beber a lo largo de su exposición. Y, evidentemente, no es a causa del caudal de palabras que dicen. Son capaces de hablar en otras circunstancias sin tener que beber en todo momento. Su

vivencia puede ser: «Quiero que los demás asimilen el pedazo de información, lo que tengo que decir, lo que sale de mí». Es típicamente la tonalidad conflictiva de la glándula salival izquierda.

Ejemplos

El señor X tiene un **tumor en la glándula parótida derecha**.

Está soltero y vive con su madre, que le prepara siempre la comida. La madre debe ingresar en el hospital. Al saberlo, el hijo tiene un *SHOCK*, teme no volver a comer a gusto porque no sabe valerse en la cocina y no tiene dinero para comer fuera de casa.

Paperas

El niño X le hace muchas preguntas a su madre: «Dime, mamá, ¿esto, aquello, y cómo y por qué?». Ella contesta: «¡Cállate y come!». Esta frase le choca. «Quisiera que las cosas tuvieran sentido, quisiera incorporar alguna cosa, pero en vez de eso, aguantó: «¡Cállate y come!». Es un conflicto de sentido vinculado a la imposible incorporación de algo.

Muchos de nosotros hemos padecido este conflicto de sentido; es decir, que, siendo niños, hicimos preguntas que se quedaron sin respuesta. Y luego, nos pasamos la vida haciéndonos preguntas, leyendo libros, realizando cursos y fomentándonos, etc.

La señora X ya no fabrica saliva con sus glándulas salivales izquierdas

En el trabajo, lo pasa mal, tiene la impresión de que **sus colegas le escupen encima**, de tan desagradables como son. «No quiero producir, secretar esta saliva y que me alcance». Es un conflicto de identificación.

Un niño tiene un tumor en la glándula salival

Se da cuenta pero no dice nada, por vergüenza. Un año antes, llegó a una clase nueva y los niños se burlaban de él, le escupían encima. Su deseo es: «Quiero estar integrado, incorporado al grupo, quiero atrapar ese grupo de amigos». A los 20 años, estudiante, tiene de nuevo un tumor; quiere atrapar su diploma y una novia, sin conseguirlo.

Punto pedagógico: «Cuando no puedo actuar sobre el cuerpo de los demás, actúo sobre el mío». Es el conflicto de identificación

La hija de la señora X pierde su trabajo. Es terrible para la madre, que tiene la impresión de que su hija se va a morir de hambre, tirada en la calle... Empieza una patología del hígado. «Hay un gran riesgo de muerte por inanición», el sujeto está ausente de la frase, la biología sólo sabe conjugar la primera persona del singular y en presente.

Buena noticia: ¡tu hijo, el otro, no necesita tus pulmones para respirar, tu estómago para nutrirse! Si, el otro es autónomo, está libre de ti y tú de él.

LAS GLÁNDULAS SALIVALES: LOS CANALES

Parte del órgano afectado

Los conductos excretores de las glándulas salivales.

La vivencia biológica conflictiva

Conflicto de *la llama de los Andes*.

La tonalidad central es *social*.

A LA DERECHA:

Conflicto de **NO TENER DERECHO** a comer, almacenar, incorporar. «¡Eso no se hace!».

A LA IZQUIERDA:

Conflicto de **NO TENER DERECHO** a escupir. «¡Eso no se hace!».

La tonalidad específica de los **cálculos** presentes en los canales de las glándulas salivales es: «No quiero que el otro me subyugue». A veces, también: «No quiero que el otro sienta rabia hacia mí».

Punto pedagógico: los órganos simples y los órganos complejos, es decir, constituidos por dos tejidos

La mayoría de los órganos del cuerpo son órganos complejos, es decir, constituidos por numerosos tejidos, como,

por ejemplo, el ojo, resultante de la combinación de los tejidos nerviosos, sanguíneos, conjuntivos, epiteliales... Los órganos simples son raros. El músculo, por ejemplo, sólo está constituido por fibras musculares.

De esta forma, en los **órganos complejos** se encuentran los tejidos de origen embriológico diferentes, o sea, con funciones diferentes. La descodificación de un órgano deberá tener en cuenta el tejido enfermo.

La distinción que tenemos que hacer entre la vivencia arcaica (glándula) y social (canales) es que encontramos en esta última una vivencia de vertiente **MORAL**. Con la arcaica, no controlamos: queremos *papear*, pero no hay nada para hincar el diente. Con la social, resulta que hay para comer, pero seremos castigados si miramos hacia la mesa, o ya no seremos amados, o vamos a dar lástima. En fin, **eso no se hace**, simplemente: «*Nada de eso en mi casa, aquí estamos bien educados!*». Esto es válido para numerosos órganos complejos como los dientes (esmalte y dentina), canales y glándulas salivales, entre otros.

Los **órganos complejos** constituidos por glándulas y canales como, por ejemplo, las glándulas lacrimales, las glándulas de Bartholin, las glándulas salivales, pero también los dientes, con dentina y esmalte, el estómago con curvatura pequeña y grande, tienen un matiz en el sentir:

- la **glándula**, el hueso del diente, están vinculados con lo arcaico,
- el **canal**, el esmalte, están vinculados con lo social, el orden moral.

Por otra parte, los órganos situados a la **derecha** corresponden, en general, a «hacer entrar»; los situados a la **izquierda**, a «quiero hacer salir».

Para **los zurdos y las zurdas**, eso será exactamente a la inversa.

Ejemplos

Una persona que se somete a diálisis y que no puede beber ha desarrollado un **tumor en la parótida** derecha: «Quiero atrapar el agua sin poder hacerlo».

Cálculos de los canales salivales

Un hombre sufre el hecho de verse **obligado a incorporarse** al servicio militar. Por otro lado, no puede responder nunca a las groserías del sargento y le salen aftas.

Sesión con un problema de cálculo de la glándula salival

La señora X empieza un trabajo nuevo en mayo de 1997 y debe mudarse a Lyon. No le gustan las grandes ciudades y no deja de repetirse: «Tengo que **asimilar** el nombre de las calles, cómo debo moverme por esta ciudad, pero me parece que seré incapaz de hacerlo, no quiero hacerlo, no me gusta esta ciudad. **¡Me niego a incorporar todo esto!**».

En el verano de 1997, empieza una **colección** de cucharillas con el escudo de cada ciudad.

A principios del año 1999, tiene un problema con su jefa:

«No quiero que me utilice, que **se sirva** de mí para fines que no quiero. No estamos de acuerdo en la forma de ver las

cosas. Me mantengo en mis trece. Vuelvo a hacer sólo lo que dice mi contrato y no vuelvo a hacer lo que hacía antes».

El psico-bio-terapeuta:¹⁴

—«No atrapas el pedazo, el contrato, ¿verdad? (Es la glándula salival derecha la que incorpora el pedazo). Tu vivencia es: «No quiero atraparlo, no quiero integrar el pedazo», ¿es eso?

—Seguimos hablando de ello; además, aparece un frío muy intenso.

—¿Te hace daño, ese frío?

—Sí, sí.

—¿Tienes fiebre de vez en cuando?

—Siempre tengo mucho calor, tanto en verano como en invierno. Siempre voy en manga corta.

—Tal vez tengas como sofocos. Entonces, es que entre vosotras [la jefa y ella] hay frío y tú creas calor. ¿Eres diestra o zurda?

—Zurda.

—Entonces, por el lado izquierdo, hay que invertir, porque para **los zurdos y las zurdas**, la vivencia del lado derecho es: «Quiero que esto salga, quiero echar el pedazo, no lo quiero coger».

—Y desarrollo un cálculo en las glándulas salivales submaxilares en junio de 1999.

—Desarrollas cálculos en la glándula submaxilar algún tiempo después. ¿Continúas con tu colección?

14. El psico-bio-terapeuta es un terapeuta especializado en la escucha biológica de los síntomas. Utiliza la decodificación biológica y trabaja de forma complementaria con el médico y el psicólogo, no los sustituye.

—Sí, pero menos. De vez en cuando me olvidó, pero antes era algo sistemático.

—De alguna manera, es como tu forma de moverte por el mundo: «*Tú eres la glándula salival*». Coleccionar es atrapar (si no quiero atrapar el pedazo, quiero, más bien, echarlo, esto descodifica la glándula salival derecha, para una zurda, y la izquierda para un/a diestro/a).

»Y para el cálculo: ¿Te consideras como el pedazo que ella [la jefa] querría atrapar?

—*Utilizar*, que ella me utilice para fines que yo no quiero. Es una persona que manipula mucho.

¡No quiero que el otro se apropie de mí! He aquí la vivencia, en la zurda, de los cálculos de la glándula salival derecha».



EL ESÓFAGO: PARTE SUPERIOR

Órganos afectados

La mucosa y la muscular de la parte superior del esófago.

La vivencia biológica conflictiva

La tonalidad central es social.

«Lo que quiero ingerir me es negado y lo que me resulta repugnante, atiborrante, me es impuesto».

«Quiero fresas y me dan acelgas frías y, además, no tengo derecho a quejarme, ¡si no, ten cuidado!».

«No tengo derecho a aprovecharme del pedazo tragado», ejemplo de la herencia.

Conflicto de no querer engullir el pedazo, cuando se está obligado.

Conflicto de no querer incorporar algo (también en sentido figurado).

«No acepto la relación, la rechazo, no es buena para mí, quiero otra cosa».

«Algo se me ha quedado atravesado en la garganta. No puedo engullir. ¡Estoy hart!».

Pistas para explorar prudentemente:

En el tránsito puede existir la noción **de intransigencia**:

«No puedo hacer este **tránsito**, no puedo dar ese paso».

«Me está prohibido avanzar».

Recordatorio:

Distinguimos dos partes:

La parte alta (social) corresponde al conflicto: «Me imponen algo, no tengo ganas de que me impongan, no puedo aceptarlo, pero estoy obligado a tragarlo mientras que yo desearía otra cosa nutritiva y agradable».

La parte inferior (arcaica) del esófago corresponde al conflicto a la inversa: «Quiero atrapar el pedazo, pero no lo consigo» o, incluso, «Me atiborran».

Ejemplo

El señor X siente **unas molestias a la altura del esófago.**

Dice: «No tengo más remedio que tragarme una conversación aburrida, cuando quisiera estar en otro lugar y tragar otras conversaciones divertidas con mis amigos. Me niego a tragarme las conversaciones de unos, se las quiero devolver, las rechazo desde el principio para permitir que me llegue otra cosa más apasionante. Por supuesto que no quiero ocupar mi estómago con necedades, con platos sin interés, quiero que esté libre para el resto de la velada».

✱

EL ESÓFAGO: PARTE INFERIOR

Órganos afectados

La submucosa y la muscular de la parte inferior del esófago.

Punto pedagógico: la goma y el tintero

Este cuadro de observación, igual que la puerta de entrada a la biología y los predicados, será el tema de una obra de próxima aparición, razón por la cual estos tres conceptos permiten ir rápidamente al centro del inconsciente, en la biología, en la vivencia que está en el origen del síntoma.

Dos experiencias constituyen la cotidianeidad de todo lo que está vivo sobre la tierra y bajo el mar:

- ir hacia lo positivo para uno mismo: alimentación, oxígeno, seguridad...;
- alejarse de lo negativo para uno mismo: frío, agresividad, gas carbónico...

Por supuesto, *considerado como positivo o negativo por el sujeto*. El tabaco, para unos, es agresivo y les hará toser. Para otros, si se sienten privados de fumar, sienten que les falta el tabaco, se frustran. Algunos necesitan el frío, otros lo detestan.

Así, en cada momento, nuestro inconsciente, es decir, nuestra biología, es bombardeada permanentemente por estimulaciones. La biología las evalúa y se pregunta: «¿*Es bueno o malo para mí?*». «Veamos el alcohol, ¿qué siento: deseo, aversión?». «Me privan de escuela: ¿placer o disgusto?». «Ir a casa de mi suegra: ¿es una experiencia positiva o negativa?».

De esta forma, todo lo que entra en mí, conscientemente o inconscientemente (como es el caso de las alergias), está clasificado en:

- positivo, o
- negativo.

En función de lo cual, nosotros tendremos dos tipos de comportamientos:

- si X es positivo: «Voy hacia, quiero más, lo busco y lo almaceno».
- si X es negativo: «Lo rehúyo, lo evito, lo elimino».

Dos problemas hacen nuestra cotidianeidad:

- estar separado de lo positivo o evaluado como tal: un oficio, un amigo, de los alimentos, del oxígeno, del espacio, del contacto físico...
- estar en contacto con lo negativo: el humo de la contaminación, el frío glacial de la nieve, un contacto físico...

Frente a todo bio-shock o *shock* enfermizo, no tengo ninguna elección:

- X es positivo, pero estoy privado de él, es inalcanzable: «Mamá retoma su trabajo»; «Me han despedido y mi salario va a bajar»; «Me han robado el coche»; «La presa se ha escapado y mi comida se ha esfumado»...
- X es negativo y me es impuesto: «Detesto el aceite de hígado de bacalao, pero estoy obligado a tomármelo», ha dicho el médico. «El aire es pestilente, pero estoy obligado a quedarme aquí»...

Dos reacciones emocionales gestionan nuestra cotidianeidad:

en el primer caso: separado, frustrado, abandonado, con falta de, pérdida de...;

- en el segundo: agredido, mancillado, herido, ofendido, sucio...

Dos tipos de soluciones animan nuestra cotidianeidad, dos formas de compensaciones:

- En el caso de privación, relleno: es el **tintero**, el **coleccionista**. Me ha faltado alimento durante la gue-

rra, almaceno alimentos en el sótano, en el granero, en mi cuerpo, en todas partes y todo el tiempo. De niño, no he tenido amigos en mi pueblo; de adulto, colecciono amigos, no estoy nunca solo. Me falta el aire, desarrollo más pulmones. No tengo vínculo con mi familia, fabrico más plaquetas sanguíneas. No me hablan nunca, fabrico sonidos, acúfenos. Me falta el agua en el desierto, tengo alucinaciones, es el espejismo, veo lagos.

— En caso de agresión, sustraigo: es la **goma**. Me han impuesto ruido, insultos; me vuelvo sordo, borro el sonido. Me han torturado, ya no siento ninguna sensación, es la anestesia. Veo a mi perro atropellado por mi culpa en mis narices, mi vista se nubla. La muerte a lo lejos se acerca porque envejezco, es la presbicia...

Así, mi hipótesis es que, cuando me encuentro frente a un síntoma de «**más**» (tumor, pólipo, alucinación...), esto viene de una vivencia de carencia, de vacío, de ausencia. Es el *súmmum*.

Y frente a un síntoma de «**menos**» (necrosis, lisis, pérdida de la función visual...), preveo un bio-shock vivido como una agresión, de la cual el sujeto procura sustraerse.

En algunos casos, señalados en este libro, las dos vivencias pueden estar presentes. Lo encontraremos en la neumología con el asma: «Me siento agredido por este espacio no querido y separado del espacio deseado».

La vivencia biológica conflictiva

La tonalidad central es *arcaica*.

Dos vivencias son posibles en función de la polaridad «goma o tintero»,¹⁵ es decir:

¿soy agredido por algo negativo?: oca cebada,

¿soy agredido por algo positivo?: pelicano hambriento.

1. Conflicto de la oca cebada

La tonalidad central es *arcaica*.

Conflicto de no querer ingerir lo que nos imponen como alimento.

«Me siento cebado como una oca».

«Me imponen el aceite de ricino, y *yo* no quiero».

«No tengo hambre y me dan de comer **demasiado pronto**, antes de que se active en mí la sensación de apetito. Se **precede a mi deseo**».

Motricidad del esófago:

«Quiero y, a la vez, no quiero tragar, hacer descender el pedazo».

15. El autor quiere hacer un paralelismo entre la acción de borrar y la de rellenar. (N. de la T.)

Espasmo del esófago:

«No puedo atrapar y tragar el pedazo y tengo un sentimiento de impotencia».

Atresia (falta una parte del esófago): «¡Todo el alimento de mi niño vendrá de mí!». Fusión demasiado grande de la madre con el niño durante el embarazo.

«Mi alimentación depende de quien me trae comida».

«Soy como un pajarillo, dependo de otra persona para alimentarme, para sobrevivir».

«Debo tragarme algo en contra de mi voluntad, debo aceptar contratiempos mortales».

Pistas para explorar prudentemente:

«Dejar pasar todo a otros, pero no a mí».

«Esto no debe avanzar».

«El afecto que viene de mi madre es peligroso para mí».

Glotonería, grandes tragaderas, pozo sin fondo, despilfarro, atiborrado. Se trata aquí de predicados que hay que vincular con la tonalidad de ese órgano.

Punto pedagógico: en cada ser humano, el lenguaje le compromete¹⁶ - los predicados

El predicado es una palabra o un grupo de palabras aparentemente mal contextualizado.

16. El autor juega con dos palabras que tienen la misma fonética y sentidos diferentes que interrelaciona: *le langage l'engage*. Lo que en castellano sería, metafóricamente, el pez muere por la boca. (N. de la T.)

Ejemplo: «Me como tus palabras». Aparentemente, porque en realidad este interlocutor está en el restaurante donde trabaja de cocinero, su consciencia biológica está, en efecto, en su estómago. El predicado nos informa del lugar biológico en el que se encuentra nuestro interlocutor. Así es como, después de muchos años, he constatado hasta qué punto nuestra manera de hablar está relacionada, de forma profunda, con nuestras células; hablamos con nuestros órganos, nuestros pulmones, nuestros intestinos, nuestro páncreas, etc. Una paciente utiliza términos relativos a los ovarios para hablar de sus dificultades: «¡He PERDIDO lo mejor de mi marido!». Es como si su inconsciente, es decir, su consciencia biológica, se encontrase precisamente a la altura de los ovarios. «¡Es inconcebible!», me dice una mujer que tiene igualmente patologías de ovarios, órganos de la concepción. Esta manera de entender, de descodificar, acelera de manera eficaz la consulta terapéutica. A veces, esto se dice de manera disimulada, fonética: «Quiero irme a descansar al campo».¹⁷ La PNL ha descubierto desde hace mucho tiempo el aspecto sensorial del lenguaje, es decir, visual, auditivo, táctil, olfativo, gustativo.

Desgraciadamente, confunde lo táctil con lo que ella llama, de manera errónea, kinestésica. Ha observado que ciertos términos del lenguaje no eran sensoriales; «Esto me ha removido», «Estoy anonadado», «Estoy nervioso», «Esto me ha afectado mucho», etc. Estos términos des-

17. En francés, irse a descansar al campo se dice *se mettre au vert*, y *au vert* (en el verde), fonéticamente, es similar a *ovaire* (ovario). (N. de la T.)

critos, los coloca en un saco enorme llamado kinestésica. Esta hermosa intuición, yo la subdivido en dos grupos: los predicados táctiles y los predicados orgánicos. He aquí algunos ejemplos de predicados táctiles: «Esto me ha *conmovido* mucho», «Tus declaraciones acarician mi alma», «Es una persona de contacto». Y ahora ejemplos de predicados orgánicos: «Esto me ha removido»: ¹⁸ el brazo o el colon; «Anonadado, perdido, estoy sin referencias»: el riñón; «Estoy nervioso»: los nervios.

Poder escuchar esto, reconocerlo en nuestros pacientes, es capital. Esto nos permite suponer dónde está su consciencia biológica, su inconsciente. E intuir qué tenemos que trabajar en primer lugar, dónde se encuentra la herida.

Ejemplo de un correo electrónico recibido, que procedía de un enfermo:

«Un corto correo electrónico al que espero tenga tiempo de responder. La correspondencia emoción-órgano para mí está *clara*. He comprado su libro con la esperanza de encontrar una ayuda para **desembarazarme de las hemorroides**. No he encontrado nada sobre esto. ¿Será una manifestación de curación, como me ha sugerido mi terapeuta?

»Con la esperanza de que **me abra una puerta para aliviarme esta molestia**, cordialmente.

M. X».

18. En francés, «*Cela m'a brassé*», de brazo (*bras*). (N. de la T.)

Ejemplo

El padre del señor X padece un cáncer. Lo que le choca es ver al personal sanitario tratando de ponerle una **sonda gástrica**, pero no lo consiguen. Es su *SHOCK*, ¡le gustaría tanto hacer deslizar ese tubo que no pasa!

Lo que siente: «Quisiera que mi padre atrapara el pedazo de tubo, es decir, ¡de alimento, de vida!». Desarrolla un tumor en el esófago.

2. Conflicto del pelícano hambriento

La tonalidad central es arcaica.

Conflicto de no estar seguro de digerir todo lo que se ha tragado.

Por supuesto, se trata, como comprenderéis, de alimento material, sólido, o **afectivo**.

Conflicto de no poder tragar aquello que quieres agarrar.

«El pedazo todavía puede escapárseme».

Miedo y contrariedad con respecto a la comida; cuando no puedo tragarme los pedazos, en el sentido de miedo a que me los «birlen».

«Comer más con los ojos que con la boca».

«Nunca tengo bastante».

«¡No percibe el trasfondo de su vientre!».

«¡Basta de despilfarro! No hay que tirar nada, hay que coger todo, tragar».

Divertículo del esófago:

Los rumiantes comen, introducen los alimentos en una primera bolsa y, después, sacan los alimentos de esta bolsa para digerirla.

Es como si hubiera una necesidad de reserva alimentaria.

Sentido biológico

Mientras que el pedazo no está en mi estómago, todavía puede escapárseme, me lo pueden coger; exactamente como al pelícano, que ha puesto un pez en su esófago, y sus retoños van a ir a recuperarlo. Igualmente, podemos utilizar como imagen metafórica para entender, agarrar y percibir el sentido biológico del esófago, la imagen de las gaviotas en pleno vuelo. Una ha cogido un pez, otra viene a atacarla para quitárselo. Esto es posible mientras que el pez no sea digerido, no esté completamente en el fondo de ella.

Ejemplo

Tumor en el esófago

Un hombre dice, textualmente: «No hay que despilfarrar. Hay que coger todo». Es como si abriera al máximo su esófago pa-

ra atrapar todo. Expresándose de esta manera, poco a poco, tenía sensaciones en el esófago. Toda su vida está estructurada sobre eso. Incluso va a ir a África para ayudar a los pobres y llevar lo que se despilfarra en Francia. Tenía una bisabuela que guardaba absolutamente todo. Se acuerda de que, cuando era pequeño, en la casa de la bisabuela había incluso una caja sobre la que se podía leer: «Trozos de cuerda que no sirven absolutamente para nada!» y dentro había trozos de cuerda que no servían absolutamente para nada. Era: «¡No hay que despilfarrar!».



EL ESTÓMAGO: CURVATURA MAYOR

La vivencia biológica conflictiva

Conflicto *del animal del zoo*.

La tonalidad central es *arcaica*.

Conflicto de carencia y conflicto de indigestión, a la vez.

**«No tengo lo que quiero; tengo lo que no quiero»:
carencia + indigestión.**

«Se me ha quedado en el estómago».

«No puedo digerir el pedazo y se queda ahí».

Conflicto de la «comida» en el seno familiar.

Problemas, arrebatos, miedo arcaico a morir de inanición.

«Quiero el amor que no llega nunca. En su lugar, sólo hay una continuación infinita de conflictos que me hacen sentir fracasado y que me angustian».

Como siempre, puede tratarse de alimento real o simbólico, por ejemplo, afectivo.

Punto pedagógico: hay tres maneras de vivir y de sentir un conflicto biológico

1. **de manera encarnada,**
2. **de manera disociada,**
3. **de manera desencarnada, fuera de su cuerpo.**

Por ejemplo, la señora X se siente separada de su hija, pierde el contacto físico dejándola por primera vez en la guardería.

1. Si ella lo encarna, es decir, en su cuerpo, puede desarrollar un problema de piel, de epidermis, de eczema, entre otras afecciones posibles.
2. Si ella lo disocia, necesita pensar, controlar, ser más bien intelectual y, en consecuencia, puede sufrir problemas cerebrales, por ejemplo, migrañas.
3. Si ella no lo vivencia desde su cuerpo, sino desde la mente, imagina todo el tiempo numerosas fantasías, podemos decir que está «desencarnada»; abandona la guardería totalmente perturbada. No tiene problemas físicos (cuerpo, cerebro), sino un malestar psicológico, un trastorno de comportamiento.

Bulimia:

Para el bebé, el estómago lleno es una sensación asociada a la seguridad y a la plenitud. Es la tranquilidad gracias al relleno. Lo guardamos en la memoria. Si siempre tengo necesidad de comer y de rellenarme, tal vez me quedo en esa necesidad infinita de seguridad.

«En lo más profundo de mí, estoy ansioso y quiero esconderlo».

«Tengo miedo de que me falte el afecto, el alimento afectivo o real».

«Algo me da asco, mi madre, mi padre, mi cuerpo...».

«Siento angustia, en el fondo, me siento vacío, por eso como, para llenar ese agujero, esa nada infinita».

«Nadie me comprende, me siento solo(a)».

«La sexualidad me da miedo, me da asco».

«Quiero ocultarme y, al mismo tiempo, no ser olvidado».

Náuseas, vómitos:

«Rechazo el mundo exterior, los acontecimientos».

Puedo manifestar mi dificultad, mi rechazo o mi rabia frente a los acontecimientos, a través de náuseas, de vómitos. Mi solución es de echarlos fuera.

Úlcera de la pared de la curvatura mayor del estómago:

«Estoy enfrentado a un exterior que me agrede».

Hernia de hiato y reflujo gastroesofágico:

El conflicto del búho que regurgita los pelos de sus víctimas.

Se trata de personas que cierran menos el cardias, que es la parte situada entre el esófago y el estómago.

«**Quiero recibir, dejo siempre la puerta abierta, siempre estoy esperando recibir ternura, estoy vaciado** (ávido)¹⁹ de alimento, de mujeres...».

«Nunca tengo bastante».

Pistas para explorar prudentemente:

«Hay algo que me he tragado voluntariamente y que no puedo expresar, aunque tengo ganas de hacerlo».

«Estoy separado de aquel o aquella que me alimenta».

Hay dos hogares, dos familias. Ejemplo: segundas nupcias, presencia de la familia política o de tíos en el territorio.

«Para sobrevivir debo partir, salir».

Reflujo gastroesofágico del niño:

El niño espera todo de su madre: su atención, su amor; pero eso no llega de la manera que él desearía. Lo espera a cada momento, se hace disponible a ello, abre su estómago.

La madre está irritada y, al mismo tiempo, da el pecho a su bebé. El bebé mama tanto la leche como el humor de su madre. Quiero lo uno pero no lo otro, entonces escupe todo, regurgita su leche para no ser envenenado por el estrés de su madre.

«Rechazo **este** alimento».

19. En francés, juego de palabras entre *à vide* (vaciado) y *avide* (ávido).
(N. de la T.)

Punto pedagógico: los cuatro estratos de la biología

Existen cuatro grandes maneras de vivir un acontecimiento conflictivo. Esto está organizado en lo que llamo los cuatro estratos de la biología.

1.º estrato:

La tonalidad central es **arcaica**, es decir, vital: «Mi supervivencia está en juego; tengo que comer, respirar, eliminar los deshechos...». No es una situación razonada, en absoluto; se puede decir que sale de las entrañas. Con esta forma de percibir un acontecimiento, la parte del órgano que va a reaccionar es la **funcional**, la que va a crear la solución de adaptación, es decir, el síntoma. Es «el primer estrato de la biología» o vivencia arcaica.

Veamos algunos ejemplos:

- el miedo a morir de inanición: el hígado;
- una jugarreta: el colon;
- la urgencia: la tiroides.

Aquí, el entorno no es relacional ni social, el otro no existe en tanto que *alter ego*: el otro es una cosa, presa o depredador, por ejemplo.

2.º estrato:

La tonalidad central es una **falta de protección**: nos sentimos sucios, deshonorados, agredidos, heridos, la **integridad está amenazada**, en peligro, hay una fractura; será preciso reforzar las barreras. Es la parte **protectora** del órgano que está afectado, es decir, las envolturas, las serosas, la dermis.

Ejemplo: amenazan a mis pulmones, debe crear más protección, así pues desarrollo una cubierta pulmonar que se denomina pleura.

3.º estrato:

La tonalidad central es **desvalorización**.

Cuando una cosa ya no tiene valor, desaparece. Se trata de la **estructura** del órgano, de su tejido conjuntivo. Cada zona del cuerpo tiene una subtonalidad de desvalorización particularmente precisa.

Ejemplo:

«Me siento una mala madre», es el hombro izquierdo el que se verá afectado.

En una desvalorización sexual, será la articulación sacrolumbar.

En una desvalorización manual, las manos.

4.º estrato:

La tonalidad central es **social, relacional**.

Los órganos implicados en esta vivencia gestionan las relaciones. Se trata de los órganos de los sentidos, de los canales en general, del revestimiento epitelial. Un ejemplo de ello es la vejiga. Si el otro avanza por mi territorio, la vejiga se estresa porque, seamos perro, hiena u hombre, es ella la encargada de marcar los límites del territorio; entonces llegan la cistitis y las ganas frecuentes de orinar. Otro ejemplo: todo lo que es separación, pérdida de la relación va a afectar a la piel, a las mucosas; no tenemos más contacto piel a piel con mamá, que ha vuelto a trabajar...

Consecuencias

Así pues, un órgano está constituido por diferentes tejidos, cada uno de los cuales tiene un papel específico. Los bronquios están constituidos por músculos, cartílago, mu-

cosa, glándulas productoras de mucosidad, nervios y vasos sanguíneos. Cada uno de estos tejidos está en uno de los cuatro estratos de la biología. Las glándulas productoras de mucosidad están en el primer estrato porque su función es arcaica; eliminar el polvo que molesta la buena respiración. El cartilago en el tercer estrato, ¿esto es útil, tiene el valor añadido de hacer entrar más aire? La mucosa está asociada al cuarto estrato. Es ella la que está en contacto directo con el medio ambiente, el aire.

La consecuencia directa es que la tonalidad conflictiva, las vivencias vienen determinadas por el aparato, el órgano y el tejido. En consecuencia:

- cuando las **glándulas que producen mucosidad** desarrollen un síntoma (bronquitis muy grasa, asma inducido...), buscaremos el **miedo a la muerte** asfixiado por atasco, intrusión;
- cuando la **mucosa** esté afectada (bronquitis seca, ciertos tumores...), buscaremos más bien los conflictos de **separación**: «Tengo miedo a perder el contacto con mi espacio, con mi territorio»;
- si el **nervio** está implicado en un síntoma como la tos espasmódica o la enfermedad asmática, la disnea laríngea, iremos a buscar una vivencia relacionada con el futuro, con el **proyecto** y, sobre todo, con una **doble contradicción** y exigencia, es decir: «Quiero y, al mismo tiempo, no quiero». «El espacio que tengo (la habitación, la familia, la clase...) no lo quiero, me ahogo. Y lo que quiero (la hermosa y espaciosa habitación perfumada...) no lo tengo».

/// Ésta es otra manera de entender la puerta de entrada en biología, que ya ha sido estudiada en esta colección.²⁰

Sentido biológico de las enfermedades del estómago (1.^{er} estrato)

**La tonalidad biológica de las mujeres y de los hombres
«digestivos» es la aceptación, *comerse el mundo exterior*.**

Tras un bio-shock, el organismo genera células muy especializadas en la producción de ácido gástrico (ácido clorhídrico, etc.). La finalidad es descomponer el gran pedazo impuesto para que pueda ser digerido. El hecho de poder digerir o no un pedazo representa la vida o la muerte por inanición. Efectivamente, mientras un pedazo de alimento indigesto está en el estómago, es imposible comer otra cosa. Necesitamos digerirlo completamente antes de volver a alimentarnos. ¡Mientras que ese pedazo indigesto esté en nuestro estómago, nos moriremos de hambre!

El alimento, en efecto, no está en nosotros, disponible, no ha pasado a nuestros intestinos y todavía menos a nuestra sangre. Por esa razón, la tonalidad conflictiva es: carencia + indigestión.

En cada comida, el tigre del zoo tiene que comer los pedazos de carne que no ha vendido el carnicero, esa carne da vueltas y vueltas en su estómago. No es lo que quiere comer,

20. Véase *Décodage biologique des problèmes respiratoires et ORL*, páginas 73 y siguientes.

prefiere, más bien, la carne de ciervo, fresca y palpitante, atrapado tras una carrera desenfrenada y victoriosa.

Ejemplos

Tumor en el estómago

Un jubilado, que siempre ha estado psicológicamente muy equilibrado, viaja a Córcega tras la muerte de su padre, convencido de que podrá recuperar la casa familiar. Sin embargo, una vez allí, los primos se oponen y él no puede hacer nada, pues la ley de Córcega permite la indivisibilidad de una parcela. Está dispuesto a cederles las tierras si ellos le dejan la casa familiar. Pero los primos se niegan.

SHOCK de doble vertiente: no tiene la casa y no puede digerir la actitud de sus primos.

La señora X tiene dolores en el estómago desde los diez años

Su madre se vuelve a casar con un hombre que grita sin cesar y ella se queda allí, sin reaccionar. Para ella es un conflicto indigesto: «Es como si perdiera a mi mamá; mi verdadera mamá, echo de menos a aquella mamá que no se habría dejado manipular fácilmente; sufro ese padrastro, que no quiero aceptar».

El señor X tiene ardor de estómago

Habla de sus padres de la siguiente manera: «Me falta el apoyo de mi mamá; no puedo digerir las broncas permanentes de papá».

En el verano de 1995, el señor X esperaba recibir su diploma de técnico en Programación Neurolingüística (PNL)

El sábado por la tarde, la formadora afirma: «Te podrás ir con tu diploma mañana al mediodía; vale». El domingo por la mañana rectifica: «Lo siento, pero tienes que volver mañana, lunes; no te puedo dar tu certificado»: bio-shock. El domingo al mediodía el señor X no come nada. A las 16 horas, comprende el conflicto y, de repente, se le abre el apetito: conflicto ante la falta del diploma + actitud juzgada, vivencia del conflicto en forma de indigestión. «No tengo lo que quiero (validación), tengo lo que no quiero (rechazo).

Una madre reclamaba sin cesar dinero a su hija, que no podía hablar de ello con su marido. Después de cierto tiempo, no puede ayudarla más y desarrolla una patología en el estómago. Conflicto de carencia: ya no puedo dar dinero a mi madre; conflicto de indigestión: ¡no puedo aceptar su comportamiento de pedigrüña!

✱

EL ESTÓMAGO (CURVATURA MENOR), EL BULBO DUODENAL, EL PÍLORO

La vivencia biológica conflictiva

Conflicto *del animal de circo*.

La tonalidad central es *social*.

Conflicto relativo a personas o situaciones que debemos frecuentar por obligación.

Conflicto muy profundo con una persona a quien es imposible evitar; se instala en el estómago (entorno familiar, trabajo, vecindad...). Un intercambio, una conversación que no ha hecho más que comenzar ya es rechazada y deseamos expulsarla.

Contrariedad en el territorio (sin rencor, si no: vías biliares).

Discrepancias fronterizas con el jefe del territorio, el vecino, etc.

Esto puede ser por el contenido del territorio, por ejemplo, el (la) pareja infiel.

Un trabajo impuesto, obligado, apenas comenzado ya es negado, rechazado.

Pistas para explorar prudentemente:

«Dejo de protegerme del mundo exterior».

«Quiero estar en contacto íntimo con todo lo que absorbo».

«Me siento separado de alguien o de algo del mundo exterior, de alguien que me alimenta».

«Me niego a destruir lo que me es impuesto».

«No acepto las cosas claramente, tal cual son. Me gustaría mucho tener una cosa y la contraria, al mismo tiempo. Soy incapaz de escoger en el sentido de: *escoger es renunciar*».

«Me siento incomprendido».

«Alguien no me protege».

Existen verdaderos tipos de personalidades gástricas que siempre reaccionan por contrariedades territoriales.



Recordatorio

El estómago está formado por dos partes, cada una con su propia vivencia.

La **curvatura menor**: contrariedad en el territorio. Alguien a quien no puedo soportar, me es impuesto. Úlceras.

La **curvatura mayor**: conflicto de carencia + conflicto de indigestión (situación inaceptable).

Zurdo (a): conflicto de identidad en el seno del territorio (*véase: recto*).

«Estoy puesto en entredicho».

La hiperactividad gástrica:

El ácido sirve para romper las estructuras de los alimentos. ¿Tenemos miedo a ser invadidos por la estructura?

Ardores de estómago:

«El exterior me ataca y me pone en peligro».

«El enemigo ha penetrado y ha invadido». Es el **terreno ácido** en todo el cuerpo.

«No he sabido rechazar un exterior que me impuso una estructura, que ahora cohabita totalmente. Trato de destruir esa estructura interna, pero al mismo tiempo, me destruyo yo mismo».

«Soy ácido porque estoy invadido(a) por todos aquellos que me rodean y que, a menudo, quiero o creo querer».

El exterior es amargo.

Píloro:

Se trata de la puerta del estómago. Por lo que podemos buscar, en la historia clínica del paciente, todo lo que esté relacionado con las *aberturas* y transponerlo.

Podemos hacernos la pregunta: ¿quién vigila la puerta, quién la cuida, quién la protege?

Estenosis del píloro:

«Asimilar es peligroso para mí».

Úlcera de duodeno:

Pistas para explorar prudentemente:

«He tardado demasiado tiempo en manifestar mi desacuerdo».

A la inversa, el duodeno también puede sufrir cuando tú esperas algo que has podido engullir normalmente, pero

que, repentinamente, te lo quitan mientras que tú estabas seguro de poseerlo. Os quitan el pan, no de la boca, sino del vientre.

«Necesito una ayuda exterior, porque estoy solo frente a mí y mi destino».

Síntomas

Hiperacidez estómacal, úlcera de estómago muy dolorosa, pérdida de la sustancia superficial de la mucosa gástrica a lo largo de la curvatura menor del estómago o del píloro o del bulbo duodenal. Su mucosa está constituida por epitelio pavimentoso.

La innervación sensible está regida por el córtex sensorial, dolores vivos y espasmos o cólicos gástricos en el momento del *shock*. Si el conflicto es muy largo, existe riesgo de perforación de la úlcera.

Vómitos.

Como siempre, la opinión médica es más que necesaria, se impone.

Punto pedagógico: la biología hace lo que ella quiere para salir del problema

Uno de los tratamientos quirúrgicos propuestos en medicina es seccionar el nervio neumogástrico o nervio vago, lo que implica que era éste el que provocaba la úlcera. Pero, ¿qué es lo que provoca la actividad excesiva del nervio vago? El conflicto que acabamos de describir.

Por otra parte, es interesante puntualizar que la úlcera es una enfermedad de estrés como todos los médicos y el público, en general, saben. Y el estrés está tradicionalmente asociado al nervio ortosimpático y el nervio vago al descanso, a la relajación que se obtiene, por ejemplo, cuando estamos en la playa, después del estrés de la oficina. Observamos vagamente las olas²¹ romperse en la arena, indolentes.

De esta forma, ¿el sistema nervioso de recuperación podría provocar una enfermedad de estrés? ¿Por arte de magia? Sencillamente, porque la biología hace lo que quiere para sacarnos del estrés, del problema. Utiliza la solución biológica mejor adaptada: el alimento está pasado, tenemos diarrea; nos falta de todo, agua, alimentos, nos volvemos estreñidos; nos sentimos en peligro, toda nuestra sangre se va al interior; nos falta calor, afecto, la sangre se dirige hacia la piel y tenemos calor e incluso, a veces, fiebre; y esas manifestaciones están garantizadas tanto por el sistema ortosimpático, como por el sistema parasimpático (llamado también sistema vago).

En consecuencia, no es el signo físico lo que importa para decirnos si el sujeto está estresado o no, sino su relación con los acontecimientos externos: ¿está apacible o en conflicto? El cuerpo hará el resto.

Tampoco tengáis siempre en cuenta lo que está descrito en ciertas obras relacionando sistemáticamente simpaticotonía y estrés, vagotonía y curación.

21. El autor hace un juego de palabras con el nervio vago y *vagues*, «olas» en francés. (N. de la T.)

Sentido biológico

En el circo, para no morir de hambre, el tigre debe, en cada comida, digerir las humillaciones del domador, las pullas de los niños y los paisajes tristes.

Ejemplos

La señora X padece una **úlcera de la curvatura menor** que le provoca dolores y hemorragias.

Shock: sus vecinos, en su vivienda de protección oficial, la molestan sin cesar y son desagradables. Ella los lleva a juicio y, ante el juez, ellos lo niegan todo. La palabra de la mujer vale igual que la de los vecinos; ella se lo toma muy mal, porque ellos la calumnian. «**No puedo aceptar eso** ni todo lo que pasa en el mundo; me gustaría estar en una isla desierta».

Cada día, se ve obligada a cruzarse con los vecinos en la escalera, en la calle, en las tiendas... Para ella son **contactos impuestos**.

Además, su marido, que es muy celoso, la obligaba a quedarse encerrada en casa sin hablar con nadie (la mujer siempre tiene la mano delante de la boca).

El señor X tiene un **granito en la oreja**. El cirujano le propone una pequeña operación.

—¡Acepto con la condición de que no me quite toda la oreja! ¡¡Aunque sea canceroso!!

—Claro, no se preocupe —le contesta el cirujano.

Cuando se despierta, descubre que el cirujano le ha quitado la oreja entera. Lo vive muy mal y desarrolla dos patologías en el estómago.

En primer lugar, un tumor: *carencia + indigestión*, porque esa oreja le falta y no puede digerir el comportamiento del médico (*véase el capítulo anterior «El estómago: curvatura mayor»*). En segundo lugar, una úlcera porque, tras la operación, cuando se cruzó con un conocido en la calle, se dio la vuelta de manera que el otro estuviera a su lado y no se fijara en la ausencia de su oreja: *«contrariedad en el territorio»*; no puede evitar la relación.

Ostra podrida

La señorita X vive en casa de su hermano casado. Tiene la sensación de molestarle, de estar de más: «Soy como una ostra podrida, él me hace reproches, es frío conmigo. Sería mejor que me fuera, ¿pero para ir adónde?». Padece dolores en el estómago.



EL DUODENO (EXCEPTUANDO EL BULBO)

El duodeno tiene la forma de un marco.

La vivencia biológica conflictiva

Conflicto del *cuadro (dirección) de la empresa*.
La tonalidad central es arcaica.

A la vez, conflicto de carencia y conflicto de injusticia.
Contrariedad con los miembros de la familia, los colegas del trabajo, los amigos o el dinero.

Injusticia vivida de manera indigesta...

Conflicto de no poder digerir el pedazo.

«No puedo soportarlo, no lo trago».

«Me obligan a comer lo que no me gusta, me imponen cosas, gente».

«Debo digerir la **amargura** del mundo». Conversaciones *amargas*.

«Busco neutralizar las conversaciones ácidas de los demás».

... después carencia:

«Mientras que está en el duodeno, todavía no soy Yo. Mientras que no es digerido, no puedo acceder a otra cosa y me muero de hambre».

Miedo a no tener suficiente para comer, a morir de hambre, problemas en relación con la comida.

«Estoy sin familia, sin amigos».



EL HÍGADO: PARÉNQUIMA

La vivencia biológica conflictiva

Conflicto del *desempleado*.

La tonalidad central es arcaica.

Conflicto de carencia.

«Ya no tengo medios de subsistencia, de supervivencia».

«Tengo miedo a carecer de lo esencial, de lo necesario», o vivido como tal por el paciente (dinero, comida, profesión, renta mínima de inserción, seguro de desempleo, becas, etc.). Todo lo que aparece como indispensable para la supervivencia.

«Tengo miedo a no tener bastante para comer».

«Tengo problemas relacionados con **la comida**».

«Tengo miedo a morir de hambre (por problemas familiares o de dinero)».

«Tengo un miedo profundo a carecer, en todos los sentidos del término (en la actualidad, en el futuro)».

«Carezco de todas las cosas que me resultan indispensables para mi supervivencia».

Es un conflicto de carencia asociado a algo más vital, más profundo que el conflicto de no poder atrapar el propio pedazo a las amígdalas, por ejemplo.

«Estoy en conflicto por una imposibilidad física de digerir el pedazo». Ejemplo: «Tengo miedo a morir de hambre a causa de un tumor en el intestino».

«No tengo confianza en mí mismo, en mis capacidades de supervivencia».

... ¡y otras vivencias en función de la función hepática afectada!

En efecto, no perdamos de vista que el hígado tiene numerosas funciones (*véase* el capítulo «Generalidades»). Almacenar sólo es una de ellas, entre otras muchas. En consecuencia, tenemos que descubrir otras vivencias en relación, cada vez, con una de las funciones del órgano no satisfecha.

Con sus novecientas funciones censadas hasta ahora, esto sitúa al hígado, por importancia, como el segundo órgano del cuerpo, después del cerebro, en número de funciones incalculables.

Por ejemplo, las células hepáticas sintetizan:

- el colesterol y las lipoproteínas (HDL, LDL...);
- una gran cantidad de proteínas del organismo, como, por ejemplo, la albúmina, que es la principal proteína del plasma, así como los factores de la coagulación.

El hígado produce moléculas complejas a partir de moléculas elementales, asimiladas por el intestino delgado.

Así pues, reducir el sentido biológico del hígado a almacenar los alimentos y, en consecuencia, deducir como tonalidad conflictiva la carencia, no puede ser más que reductor. Y esto se confirma en el terreno de la consulta;

algunas mujeres y algunos hombres no se sienten concernidos por una noción de carencia.

Asimismo, el hígado tiene el rol de transformar los nutrientes que le llegan, de desintoxicar la sangre, de degradar los glóbulos rojos (más exactamente, de transformar los productos de degradación de la hemoglobina para que puedan ser eliminados). De esta forma, el psico-bio-terapeuta acompañará a su paciente en su escucha biológica en temas tales como:

- transformo mi vida,
- soy un pasaje,
- voy a tener que modificar, transformar, ciertas cosas, para poder asimilarlas o eliminarlas (descodificación de Alain Parrier). Ejemplo: «Debo vender mi casa para poder separarme de mi marido», explica una mujer.
- Me siento intoxicado, envenenado.

Ejemplos:

«Tengo miedo de olvidarme de algo esencial, vital, antes de un viaje».

La señora X toma veneno para abortar, para eliminar al niño que lleva dentro. Éste será el conflicto programador de aquel que tendrá una patología del hígado para filtrar las toxinas que se encuentran en su sangre.

Predicados:

Hígado, hambre, familia, dinero, hambruna.

Éste puede ser un conflicto por **identificación** como, por otra parte, todos los conflictos.

Cirrosis:

Patología del tejido de protección del hígado:

«Es preciso reestructurar la casa familiar».

Pistas para explorar prudentemente:

«Mi familia no me ofrece medios suficientes para alcanzar la felicidad».

«Vivo en un estado de codependencia y de celos».

«No me siento respaldado en mi búsqueda de seguridad, en mi proyecto profesional».

Depósito de hierro en el hígado: hemocromatosis.

La hemocromatosis es una sobrecarga de hierro en el hígado. El almacenamiento de hierro en la sangre se llama **hipersideremia**. En la hemocromatosis, encontramos depósitos de hierro en el hígado. En descodificación biológica, podemos deducir una noción de **carencia relativa al hierro**. Vemos una sobrecarga en los pacientes afectados, un exceso de glóbulos rojos en la sangre (alrededor de seis millones). Al mismo tiempo, la hemoglobina es demasiado alta. A menudo, los médicos envían a estas personas a donar su sangre, realizar sangrías. En términos de conflictos, podemos buscar **conflictos relativos a la sangre, a las hemorragias, al miedo a perder su sangre o a que le falte**. En cuyo caso, la solución es fabricar más sangre.

Punto pedagógico: todos estamos fascinados por nuestros conflictos, inconscientemente, los buscamos...

Parecería que cada persona esté como fascinada por su conflicto: «merodea alrededor de su conflicto». De esta forma, va a leer el mundo exterior, las noticias en la televisión, todo acontecimiento, a través de su propio conflicto. «¡Es asqueroso!», afirma un hombre operado de colon, hablando de asuntos políticos. «¡No vale nada!», diría un reumático; «Es feo», me dejaba caer un hombre que padecía vitíligo, los tres hablando del mismo acontecimiento. Así pues, toda persona vuelve a repetir, en cada ocasión, como forma de identificación, su propia historia conflictiva.

Para los pacientes afectados de patología sanguínea, el hecho de sufrir una toma de sangre puede convertirse en un conflicto desencadenante que los vuelve a estresar (como es el caso, por ejemplo, para la ascitis cuando los pacientes sufren las punciones).

En consecuencia, es esencial explicar el porqué de todo acto al paciente.

Sentido biológico

La intención positiva, biológica y posible de los tumores en el hígado es utilizar al máximo el alimento ingerido, ya que se trata de un conflicto de carencia o de hambruna. El organismo envía obreros especializados (las células tumorales hepáticas) que digieren, **almacenan** y trabajan al máximo. Pero, repitamos, otras vivencias, otros sentidos biológicos son posibles en función de la función hepática afectada!

Observación

A veces, un solo bio-shock genera varios tumores en el hígado, mientras que un conflicto por identificación sólo produce uno.

Ejemplos

Una tienda de alimentación quiebra y la madre dice: «Nos vamos a morir de hambre». La hija se lo cree y desarrolla un cáncer de hígado.

Un hombre tiene un **tumor en el intestino**; le operan. Está de baja laboral y recibe las indemnizaciones correctas. Pero, un día, la caja de su seguro disminuye considerablemente sus indemnizaciones mientras que él pensaba recibir todavía la misma cantidad; sufre un *shock* de miedo a no poder equilibrar su presupuesto: patología de hígado.

Una madre, que padece un tumor de mama, tiene miedo de que sus hijos mueran de hambre. Se siente como una **madre abastecedora** y desarrolla un tumor de hígado.

La señora X tiene una **tasa de hierro elevada**.

Para los médicos, es como si el hígado ya no diera la señal habitual de que está saturado de hierro; el hierro sube sin ser regulado. Su propia madre está permanentemente con el miedo a carecer. El padre de su madre murió por una hemorragia, así pues, el mensaje es que siempre hay que prever lo peor, como un accidente, por ejemplo; por ello precisa almacenar

sangre y, por lo tanto, hierro. Por otra parte, su padre guarda absolutamente todo: tiene un cajón repleto de clavos viejos y de objetos de hierro...

Conclusión: se trata sin duda de un conflicto hereditario que se ha transmitido. «Tengo miedo a carecer de hierro en el futuro; mi solución es almacenarlo en el presente».

El señor X tiene la tez amarilla, terrosa, desde siempre. Su **bilirrubina es alta**, los glóbulos rojos bajos. La bilirrubina es un residuo que el cuerpo, normalmente, elimina. En la consulta, él dirá: «**Si existo, molesto a mi madre** (glóbulos rojos bajos), recibo poco, **guardo los residuos de la relación** (bilirrubina alta)».

La señora X tiene un tumor en el hígado. Su hermano acaba de ser despedido y ella lo vive muy mal. Ya le imagina en la calle, como un **vagabundo**.

Punto pedagógico: el conflicto por identificación

Cualquier persona puede desarrollar, de modo inmediato, un conflicto por identificación. Por ejemplo, una madre ve caer a su hijo y ella siente, enseguida, una molestia en la misma rodilla que su querido hijo, la carne de su carne se acaba de hacer daño.

Un amigo os cuenta un accidente en el que una viga le ha caído sobre su vientre y tú puedes constatar, inmediatamente, una tensión en el tuyo o incluso su endurecimiento, como para resistir a esa agresión.

La consecuencia importante para nosotros es la siguiente: en cuanto la vivencia negativa está en el cuerpo, éste reac-

ciona por un programa de adaptación, lo que en descodificación biológica llamamos una enfermedad.

También es crucial para el terapeuta explorar con su paciente no sólo lo que ha vivido y sentido, sino también, y por añadidura, lo que otro ha vivido y que él mismo después ha sentido. Es el conflicto por identificación.

Se trata, como te puedes imaginar, de proyección imaginaria de un individuo sobre otro, es como una violación de domicilio. La terapia comienza, de este modo, por la toma de consciencia de este funcionamiento y continúa por una desidentificación del otro. A continuación, se regresa al interior de sí mismo.

El señor X es un hombre de negocios que padece un tumor voluminoso en el hígado. Cuando el psico-bio-terapeuta habla de miedo a no tener dinero, no se siente en absoluto preocupado. Y después, repentinamente, rememora un acontecimiento ocurrido algún tiempo antes de la aparición de su tumor. Está de viaje turístico en India y, en la calle, sus ojos se cruzan con la mirada de una niña pequeña con harapos, mugrienta y bella. Él siente lo que ella siente, por lo menos es lo que él cree: no tener nada, no saber si voy a comer hoy un trozo de pan. Es, por supuesto, un conflicto por identificación.



EL PÁNCREAS

Órgano afectado

Páncreas, la masa excepto los islotes.

Las enzimas pancreáticas son las más poderosas de todas.

La vivencia biológica conflictiva

Conflicto del *niño desheredado*.

La tonalidad central es arcaica.

Conflicto de carencia y de ignominia.

Conflicto de miedo y de contrariedad con miembros de la familia: «Lucho por mi pedazo». A menudo, se trata de herencias, reales o simbólicas.

Miedo a no tener. «Debo almacenar energía para más tarde».

Nos reprochan el pedazo ingerido.

Hacerse engañar en el seno de su propia familia.

Cálculo pancreático:

«No quiero que el otro piense que no soy noble».

«Me quitan dinero, me desheredan y yo quiero conseguir algo para mí».

La diferencia de vivencia con el hígado es:

Más rebelión, más amargura.

Conflicto más intenso, a menudo con la familia, el dinero, la herencia real o simbólica.

Síntomas

Tumor, pancreatitis, dolores, enquistamiento.

¡Y, evidentemente, consultar a un médico...!

Ejemplos

Una **señora rica dispone de numerosas propiedades** porque su marido compró muchos terrenos. Es posible que el ayuntamiento cambie y el alcalde, su amigo, sea sustituido. El alcalde siempre la ha respaldado. La señora X teme que su nieto no pueda construir e instalarse. Además, teme tener que pagar impuestos monstruosos por sus propiedades. Desarrolla un tumor de páncreas.

La señora X ha perdido a cuatro de sus allegados; el último, su tío, le había prometido legarle en el testamento una pequeña, pero hermosa, casa. Sin embargo, cuando se realizó la **lectura del testamento**, fue su hermana quien la heredó. **¡Ella ni fue nombrada!** Esto «la pilló totalmente de sorpresa», ¡no se lo esperaba para nada! Había contado realmente con esa herencia y se estaba preparando para ocupar el lugar de honor en esa casa. Siente ignominia, carencia y una contrariedad indigesta; desarrolla un tumor en el páncreas.

Metáforas pancreáticas: ¡por una confusión de direcciones!

La confusión viene, en primer lugar, por tener la misma dirección. Louis, psicoterapeuta, tiene la consulta en el segundo piso, mientras que Armand, abogado, que escucha para pleitear, la tiene en el primer piso. Los dos tienen una secretaria y una sala de espera y las personas que llegan a sus consultas, a menudo, se sienten agredidas por la vida y sin defensa.

La mañana en la que Jean Dupont y Robert Dupond cambiaron de papel, todo el mundo vivió una farsa. Jean estaba ansioso por su primera visita al abogado. Robert se sentía nervioso, la boca seca, en la sala de espera del psicoterapeuta, del cual, le habían alabado sus éxitos. Louis, el psicoterapeuta, abre la puerta y da la bienvenida, con una amplia sonrisa, a su nuevo paciente; este paciente creer visitar a un abogado.

—Entre, por favor, le escucho.

—Es a propósito de mi vecino, que siempre me busca las cosquillas.

—¿Está seguro?

—Su valla invade mi terreno.

—¿Y cuál es el problema?

—Bueno, ¡no tiene derecho!

—Para usted, él no tiene derecho, pero ¿por qué es un problema para usted?

—Bueno, no lo sé.

—¿Entonces, es un problema?

—Bueno, es sobre todo mi mujer, que no para de refunfuñar por su culpa.

—¿Y usted, viene por ella?

—Sí, porque si mi vecino deja de hacerlo, mi mujer ya no me refunfuñará más.

—¿No refunfuñaba antes de este incidente?

—¡Sí! Ella refunfuña siempre.

Y él se hunde en un mar de lágrimas, sacudido por sollozos que recorren todo su cuerpo. No se esperaba que un abogado le hablase de esta manera. Sufrimiento evaporado, él se siente realmente mejor.

—¿Y ahora, pensando en el vecino, qué está pasando?

Robert (sonriendo y creyendo estar hablando con un abogado):

—De hecho, finalmente, si lo entiendo bien ¿sería preciso que usted me defendiera contra mi mujer?

—Puede ser.

—¿Qué puedo contarle de mi mujer que pueda ser objetivo?

—Su fecha de nacimiento.

—Es fácil, es la misma que la de mi padre, aunque no el mismo año, claro.

—¿Tienen otros puntos en común?

—Sí, se aprecian mucho y yo me siento excluido.

En ese mismo instante, los puños de Robert se cierran y el psicoterapeuta le invita a ampliar ese gesto, a apretar más.

—¿Qué le pasa?

—Tengo ganas de matar...

—¿Qué edad tienes la impresión de tener ahora?

—Diez años.

—¿Dónde estás?

—¿No va a denunciarme, verdad, señor?

—No, estoy aquí para ayudarte, para defenderte.

—Papá es malo, acaba de discutir con nuestro vecino, al que yo quería mucho, me hubiera gustado ser su hijo; además, mamá también le quería mucho.

Y los ojos de Robert se ausentan, ensimismados, como en trance. El terapeuta le anima a recibir todo lo que viene, a sentir todo lo que siente y a ser quien es.

—Papá me reprocha estar en casa del vecino a menudo; sin embargo, no hay nada de malo, no soy culpable de nada. No quiero ir a la cárcel, tengo miedo. Tengo que aprender a defenderme de papá; tengo tanto miedo.

—Sabe, las personas que se sienten en prisión ignoran una cosa, la llave está en el interior; aunque se quejen de estar donde están, son ellas las que, inconscientemente, entraron un día.

—Pero, ¿por qué?

—Para protegerse del mundo, y lo más difícil para nosotros es procurar que el preso acepte abrirnos la puerta.

—¡Increíble! ¡Hay que ver! Ignoraba todo esto.

—No podemos obligar a las aves de corral a volar.

—No lo entiendo.

—¿Qué quiere aprender?

—Necesito aprender a defenderme de papá.

La misma frase es repetida como un eco, un piso más arriba. Jean (creyendo que estaba hablando con un psicoterapeuta):

—Necesito aprender a defenderme de papá...

—¿Cuáles son los hechos?

—Me reprocha haber nacido.

—¿Cuál es su profesión?

—Desempleado.

—¿Tiene un abogado?

—Sí.

Y Jean piensa en su tía.

—Mi tía es una mujer mala, codiciosa, picapleitos.

—Sin duda, sin duda. Volvamos a los hechos, ¿qué ha pasado? Necesito todos los elementos para poder defenderle y saber lo que usted quiere reclamar.

—¿Reclamar?

—Sí, dinero, bienes.

—¿Puedo conseguir dinero? Es fantástico, nunca hubiera pensado eso. Me hace bien esta idea de ir a pedirle dinero. Pero, ¿cómo evaluar la cantidad?

—¿A cuánto se evalúa usted?

—Caro.

Jean se reacomoda en su asiento.

El abogado prosigue:

—Volvamos a los hechos, ¿qué ha pasado?

—Nada en concreto, es el ambiente. Siento como reproches.

—¿Ha dicho o hecho algo concreto, punible por la ley?

—De hecho, no, yo nunca había pensado en eso. Pero usted tiene razón, no todo está en mi imaginación. Esto produce un *shock*, como una vuelta a la realidad. Obviamente, hay un testamento.

—¿El testamento?

—¡Oh! Nada importante. Me deshereda en beneficio de su nueva mujer, que tiene tres hijos. A mí no me quedará nada.

—Y bien, esto es un hecho concreto. ¿Les lega mucho?

—Tierras.

—A partir de ahora, me encargo yo de todo, usted no se ocupa de nada más. Sólo tiene que transmitirme todas las piezas que tenga y dormir tranquilamente. La herencia es un derecho sagrado.

—¿Por qué?

—Porque es de esta manera como se construye y evoluciona la sociedad: la transmisión de lo bueno queda dada. Las riquezas, fruto del trabajo de los padres, deben ser absorbidas, acumuladas, utilizadas por la carne de su propia carne.

Jean se siente empujado interiormente, una ventana se abre, un peso cae, las alas le crecen, pero, ¿qué van a pensar los otros? Él prosigue:

—No está bien hablar mal de tu propio padre.

—Usted es víctima y, en ningún caso, culpable.

—Me siento como saliendo de la cárcel. Me ha iluminado. Nunca me han hablado así. Tengo ganas de llamarle «Maestro».

—¡Hágalo!

El páncreas

Dos calles más lejos, un médico tiene una consulta. Una mujer de tez amarilla está frente a él. Ella padece un tumor en el páncreas.

—Doctor, me gustaría entender de dónde viene mi enfermedad.

—¿Quién lo sabe?

—Explíqueme para qué sirve el páncreas.

—El páncreas produce sustancias que sirven para digerir, es decir, para fragmentar lo que comemos, para hacerlo asi-

milable. Cuando comemos arroz integral o pollo, las secreciones del páncreas cortan el arroz y el pollo en minúsculos elementos, materiales, moléculas. Es en el intestino donde se encuentran las puertas que hacen entrar los alimentos en nosotros. Esas puertas son minúsculas. Sólo las moléculas pueden entrar. En resumen, podemos decir que se trata de que la transmisión de lo bueno sea dada. El fruto del trabajo del páncreas, de esta manera, puede ser absorbido por el intestino, acumulado por el hígado y utilizado por el cuerpo.

La mujer está aturdida, los ojos mirando al vacío, ve el testamento de su suegro, que deshereda a su hijo, en beneficio de su nueva mujer. «Lo siente como algo ignominioso; es como privar de nombre a su hijo. No es justo. El papel del padre, como el del páncreas, es de volver digerible lo que viene del mundo exterior, para permitir a su intestino delgado, o a sus hijos, asimilarlo. Los pájaros hacen eso, los padres regurgitan los peces digeridos para sus retoños. Es curioso, como si su cuerpo fuera una metáfora de su vida. ¿Cómo puede ser?».

Durante ese tiempo, el médico escribe una receta de medicamentos que tiende a esa mujer. La mujer vuelve a su casa. Su deseo es hablar de su descubrimiento con su esposo que, por primera vez, se anticipa:

—Está decidido, ataco a papá. El psicoterapeuta me ha convencido, tengo derecho a esa herencia.

Su mujer llora de alegría, saltándole al cuello, liberada de todas las ataduras.

En la otra punta de la ciudad, un hombre invita a su vecino a tomar café:

«Y tú! ¿Qué tienes ganas de cambiar en tu vida?».

La caja de zapatos que piensa

Mira lo que te propongo: coge una caja, puede ser una caja de zapatos, mejor que sea blanca, o amarilla, o rosa, o negra. En la parte de arriba, dibuja ojos, orejas, boca; pega pelos, cabellos. En el interior, pon un diccionario. Después, pega con celo, de manera sólida, la tapa. Pon esa caja que se vea bien en tu casa.

Cada vez que te sientas juzgado, mirarás esa caja. En el cerebro de las demás personas se encuentra lo que te hace sufrir o te da placer, en todos los casos alguna cosa de la que tú dependes y, de esta forma, te conviertes en esclavo, el esclavo de los pensamientos de los demás, de lo que ellos tienen en su cabeza, ya sean halagos o insultos.

Juzgados por el viento, he aquí nuestra miserable condición humana. Coge la caja entre tus manos y sacúdela; todas las palabras se encuentran allí: «guapo y feo, bajo y alto, miserable y magnífico, Dios, deseable, indefinible, secreto». Sujeta bien la caja y sacúdela hasta ese día en el que, liberado, podrás cogerla con todas tus fuerzas y sacudirla para comprender no sólo las palabras del diccionario, sino el viento y su música, su ritmo y su silencio. Ese día, bosteza, tose, eructa hasta alcanzar una libertad más grande todavía. A partir de ese momento, habrás heredado, en lo más profundo de ti, el poder de amar y de sentirte amado en todos los lugares y en todos los momentos.



LAS VÍAS BILIARES Y PANCREÁTICAS

Órganos afectados

Todas las vías biliares intra y extrapancreáticas, vesícula biliar, así como las vías pancreáticas.

La vivencia biológica del conflicto

Conflicto de *serpiente venenosa*.

La tonalidad central es *social*.

Rencor, cólera, injusticia, rabia.

Rencor intenso, fuerte resentimiento mezclado con los celos y la envidia, muy a menudo, relacionado con un allegado, tras una injusticia.

Es una forma de conflicto biológico de territorio: las fronteras con el territorio, que no pueden ser marcadas. El jefe del territorio puede vivir contrariedades territoriales, a menudo, por temas de dinero, rencor, celos.

Se trata de un **conflicto masculino de identidad**. Es el equivalente al recto en la mujer.

«Está prohibido ser el que soy, me obligan a ser otro y eso me enfurece».

«Estoy carcomido por el deseo de vengarme de una jugarrera, de una injusticia».

Ignominia (vías pancreáticas).

«Es demasiado asqueroso para digerir».

Jugarreta indigesta, innoble, en un marco de carencia e injusticia.

Las sustancias que estimulan la evacuación de la bilis se llaman **coleréticos** (¡cola herética! o ¡cólera ética!).

Vías biliares intrahepáticas: cólera + carencia.

Vías biliares extrahepáticas: sólo cólera.

Conductos pancreáticos: conflicto de carencia + injusticia. El dinero va donde no debería ir, conflicto de rencor + ignominia.



Hepatitis A

Conflicto de rencor en relación con una carencia alimenticia vital real o trasladada a lo virtual.

Rencor en una tonalidad alimenticia.

Carencia vivida de manera digestiva: «Estoy en un estado de supervivencia».

«Me obligan a comer».

Se desarrolla sobre todo cuando aparece una nueva experiencia de pobreza.

Hepatitis B

Problema de inyección, de eyección.

«Me siento rechazado, expulsado».

Carencia en relación con una penetración.

«Me fuerzan a introducir algo en mí».

Carencia e injusticia en el contexto familiar, problema de pertenencia.

Conflicto en relación con nuestra pertenencia a la familia y al grupo de allegados.

«Me siento extranjero, incomprendido y rechazado por mis allegados».

Hepatitis C

Rencor relacionado con lo desconocido, lo indefinible.

«No sé contra quién estoy resentido; estoy resentido contra el mundo entero».

«Tengo miedo del desconocido».

Más allá de las condiciones materiales, cuando la familia o el dinero ya no bastan para satisfacernos, necesitamos poder encontrar nuestra identidad y esto pasa por el enfrentamiento con *el desconocido*. Me hace falta aprender a definir quién soy; el desconocido, en el fondo, soy yo.

Las técnicas médicas que exploran nuestro cuerpo pueden ponernos frente al desconocido, es decir, frente a lo que está en nosotros, a nuestra biología, a una parte de nosotros mismos.

Se trata de un **conflicto masculino de identidad**.

Ictericia del recién nacido:

En ocasiones, se trata de la solución a un conflicto de rencor vivido por la madre durante el embarazo (la ictericia hemorrágica no siempre es debida sólo a la hemólisis. También puede añadirse un conflicto de rencor).

Crisis de hígado:

«Intento sobrepasar la contrariedad».

Ausencia de vesícula:

La rabia está sin reprimir.

Ejemplo: después de una intervención quirúrgica con ablación de su vesícula biliar, el señor X cuenta: «Ya no logro contener mi rabia, no logro calmarla. Debe salir inmediatamente» (como las personas que son «borderline» o en un estado límite).

Patología de la vesícula:

«Conservo el recuerdo y el rencor para no olvidarlos».

Enfermedad de Gilbert:

«Quiero guardar las huellas del ambiente familiar».

«Quiero guardar hasta los deshechos de la relación».

«No he tenido mucho contacto con uno de mis parientes, o sea, que lo poco que tengo, lo guardo en mi interior».

El esfínter de Oddi: (en latín odi significa «odio»).

«No puedo asimilar, aceptar esta situación porque tengo demasiado rencor».

«Me siento impotente para sacar algo o es peligroso sacar algo».

Conjunción entre el conflicto del páncreas y el del duodeno.

Insulinoma:

Tumor de los islotes del páncreas, es lo contrario a la diabetes.

«No es preciso que resista, si no, voy a destruir a mis congéneres, a destruir al otro».

Cálculos biliares, litiasis:

Durante la eliminación de los cálculos biliares que se encuentran en la vesícula, los dolores llamados **cólicos hepáticos** pueden aparecer. Por supuesto, y sin que haga falta decirlo, es esencial consultar a un médico y cuidarse. Además, y como complemento, el terapeuta en descodificación puede trabajar el conflicto siguiente:

«No quiero que el otro sienta rabia hacia mí».

«Tengo miedo de que el otro sienta rencor hacia mí; me siento separado de su indulgencia».

Pistas para explorar prudentemente:

«Soy calculador».

«Tengo una dificultad constante para gestionar correctamente el territorio».

«Me enfado mismo por no estar bien centrado y por no tener unos parámetros claros que me permitan gestionar mi vida».

«No soporto que el otro tenga una opinión diferente a la mía, porque estoy sin identidad».

«Tengo que arrastrar a alguien como una bola de preso, como una obligación».

«Hay algo duro que arrastro detrás de mí y eso me irrita».

«Soy duro como una piedra, intransigente con los demás».

«Rechazo ser amado porque el amor siempre es malo para mí».

Medicina tradicional china

Las vías biliares están relacionadas con las leyes, son como el indicador de la balanza de la justicia.

En la medicina tradicional china, la terapia requiere la acción y la palabra.

Síntomas

Las patologías de las vías biliares intra y extrahepáticas, así como las de la vesícula biliar, son bastantes **dolorosas**, teniendo estos órganos una inervación sensible cortical.

Cólicos hepáticos e intrahepáticos.

Hepatitis: obstrucción (ictericia colestática) con retención de bilis.

A veces, hepatitis anictérica cuando sólo está afectada una parte del hígado.

Ejemplos

Una mujer es golpeada. No lo puede aceptar, siente demasiado rencor, se siente impotente para sacar su rencor porque **tiene miedo a las represalias**. Patología de las vías biliares.

El señor X tiene un **tumor en las vías intrapancreáticas**; su hijo le roba la tarjeta de crédito y saca mucho dinero para comprar droga. Para el señor X, era fundamental tener confianza en su hijo.

La vivencia es de doble confluencia porque las vías afectadas se encuentran en el páncreas. La vivencia es arcaica (carencias indigestas) y social (rabia, dinero, familia).



EL INTESTINO DELGADO: YEYUNO, ÍLEON

El uno prueba²² a uno

El uno —el cuerpo— testa, prueba la calidad del uno, la alimentación, el mundo exterior: plantas, animales; ¿esto es comestible?

La elección y el discernimiento

En medicina china, la función del intestino delgado es la de diferenciar lo puro de lo impuro, lo claro de lo turbio. A través del intestino delgado se produce la elección de nuestros alimentos. El intestino delgado habla de dificultad para afirmar nuestras elecciones, de indecisiones, de problemas de integración. Gestiona el discernimiento dado que es aquí donde mi biología escoge lo que tomo y lo que devuelto al mundo exterior.

22. Véase nota 5.

La vivencia biológica conflictiva

Conflicto del *rumiante*.

La tonalidad central es *arcaica*.

Mucosa del intestino delgado:

Mientras que no lo he introducido en mis células, el pedazo no está humanizado, no soy yo; los leones pueden quitarse los pedazos de la boca, los gorriones se mangan los granos, las gaviotas se roban los peces. Sólo es mío cuando está **en mí, en mi sangre; se ha convertido en mí cuando se encuentra en mis células.**

Una vez en el intestino, el pedazo sigue sin pertenecerme porque, como si se tratara de una bola de cristal, mi mucosa digestiva no lo puede transformar; el pedazo sólo me pertenece si entra en mi biología. La mucosa digestiva es el tamiz mágico de la asimilación. He aquí una función vital.



Conflicto de no poder asimilar el pedazo.

Carencia + indigestión.

Conflicto de no poder digerir el pedazo.

«He sufrido una contrariedad indigesta derivada del miedo a morir de hambre en el sentido más amplio de carecer de lo fundamental (alimento, dinero, afecto...)».

Conflicto de no poder digerir un pedazo demasiado grande, como una contrariedad indigesta, un insulto, una impertinencia, una injusticia, etc.

«Tengo miedo a carecer, a morir de hambre».

«Echo a faltar **amabilidad, afecto**».

Pistas para explorar prudentemente:

«Vivo de manera totalmente impotente un problema de asimilación, de elección entre lo puro y lo impuro».

«Debo asimilar y disimular».

Algo o alguien está disimulando.



Íleon:

Vertiente suplementaria para el íleon:

«No sé sacar fruto de las lecciones del pasado».

«¿Saco provecho de las cultivos de las lechugas que he comido, cocinado, etc.? Estoy en el momento. No asimilo».

Esto, a veces, provoca una delgadez extrema.

Yeyuno:

Problema de elección, de indecisión.

Enfermedad de Crohn:

Conflicto de guarrada, de maldad indigesta.

El miedo a carecer provoca trastornos digestivos que vuelven toda alimentación difícil, es decir, imposible; de ahí estrés... y aparece el conflicto del círculo vicioso.

Intestino delgado más corto, por operación o amputación:

«Voy a acortar el tiempo para integrar rápido».

Oclusión:

Puede deberse ya sea a un tumor, ya sea a un edema, ya sea a la parálisis del tránsito.

En el caso de parálisis, puede hacerse un vínculo con esta vivencia: «No quiero hacer avanzar el pedazo en mí; me siento impotente para hacer que las cosas se muevan».

Invaginación intestinal aguda:

A veces, la vida quiere pararse y lo manifiesta bajo la forma de una oclusión intestinal, la vida haciendo avanzar el intestino en un sentido y la muerte en otro.

Invaginación del intestino delgado en el colon:

Esto puede venir de una memoria de una madre que da de comer cosas malas a su hijo.



Trastornos de la permeabilidad intestinal:

En situaciones de estrés, particularmente cuando **nos cuesta saber lo que queremos**, nuestra pared intestinal puede sufrir, perder su impermeabilidad y vemos aparecer los «trastornos de la permeabilidad intestinal».

Intolerancias alimentarias:

La más conocida es la **enfermedad celíaca o intolerancia al gluten** (gliadina).

Es una enfermedad del fin de la primera infancia que se caracteriza por heces anormales, un aumento del volumen del abdomen y una hipotrofia. Se trata de una falta de absorción a la altura de la mucosa intestinal.

Causa: intolerancia a la gliadina, molécula proteídica contenida en el trigo. La degradación de la gliadina se acaba normalmente en el interior de las células intestinales bajo el efecto de una enzima cuya ausencia es la responsable de esta enfermedad. El tratamiento propuesto es evitar el aporte de gluten.

El intestino delgado está relacionado con el padre, la ley, la del grupo y la mfa. «Elijo, luego existo».

«No quiero agruparme con mi familia».

Destete demasiado brutal, por ejemplo, del tabaco. La madre, durante el embarazo, deja de fumar de golpe.

Intolerancia a lo que se parece al gluten: esperma, etc.



Parásitos intestinales:

Tienen pánico a la luz.

«Alguien se impone en mi mesa».

«No soporto el hecho de comer en el bar, en la mesa de otro».

«Me imponen un sistema de creencias». Es por esta razón por la que estas enfermedades están más presentes en lugares como África. Es una creencia impuesta que, por ejemplo, el ancestro se reencarna en el cocodrilo y vendrá a aparecer como un fantasma. Puede tratarse de creencias sobre los muertos, sobre las almas, o una cosa completamente distinta.

«¿Qué elemento, a qué cuerpo extraño **hago** un sitio en **mi** interior?».

«Me borro dentro de mí, luego me dejo invadir».

Parasitosis hepática: parásito (fasciola) del hígado.

Conflicto relacionado con la carencia.

Tenia:

Gusano solitario. Siendo solitario, se reproduce por autofecundación, se repliega sobre él mismo para poner en comunicación los anillos machos con los anillos hembras. Megalomanía.

Solitario y deseoso de seguir así.

El bastón de la soledad.

«Me siento parasitado por una idea extraña».

Punto pedagógico: conflicto y presión

El conflicto se crea en la confrontación del exterior y del interior.

Por ejemplo, estoy en el trabajo y mi jefe me manda un trabajo desagradable, más o menos me presiona y yo, más o menos, me resisto. Se derivan varias posibilidades:

- La presión exterior es importante y la resistencia interior también. Él ejerce mucha presión y es insistente y yo resisto, no doy mi brazo a torcer; en consecuencia, el pedazo se detiene rápidamente. Otro ejemplo: el señor X quiere un niño, la señora X no. Él insiste, ella se mantiene en sus trece y desarrolla problemas en la boca, saliva mucho; el pedazo se ha detenido arriba.
- La presión exterior siempre es importante, pero no la resisto, la sufro sin reaccionar. En consecuencia, el pe-

dazo de disgusto va mucho más allá en mí. El jefe me da una cantidad enorme de trabajo «jorobado», y estoy solo en la oficina, por la noche, para hacer a duras penas todo eso, diciéndome: «Pero, ¿por qué he aceptado?». No he sabido decir *para* en alto, desde el principio, entonces me entra diarrea²³ abajo. **No sé decir no».**

- La presión exterior es débil y resisto; no pasa nada, no hay síntoma.
- La presión es débil, pero no resisto para nada, al contrario, me siento como si le debiera algo, obligado a... Por ejemplo, un hombre, cuando bajo del avión, aunque estoy cansado, me pide que le acompañe a su casa porque su coche está estropeado, los autobuses están en huelga y nadie puede venir a buscarlo. Si le digo que no, me siento culpable de su mala suerte, entonces cedo y acepto. Después, agotado, perdiendo mi tiempo, me digo: «Pero, realmente, no tenía ganas de hacer esto, quería irme a descansar». Y éste es el principio de problemas intestinales.

Por esta razón, encontramos frecuentemente un vínculo con las patologías digestivas: el amor tóxico. Nos engañan, te dicen: «Te quiero locamente..., ¿puedes hacerme la comida, cortar el césped, ir a buscar a mi madre al aeropuerto, darme dinero...?», y a fin de cuentas, sólo nos quedan las obligaciones, los esfuerzos, los disgustos, los malos rollos. Entonces, «No quiero volver a caer en la trampa, no asimilo más lo que se me da y que tomo por signos de amor».

23. El autor juega con la fonética de *diarrhée* (diarrea) y *dis arrêt* (di para). (N. de la T.)

Sentido biológico

«Si no digiero esto, me moriré de hambre».

En el intestino, un pedazo de alimento es demasiado grande para poder pasar: es el bio-shock. Entonces, el cuerpo fabrica un tumor, justo al lado, para que segregue más jugo digestivo con el fin de poder digerir el pedazo. Son células específicas las que producen jugo digestivo, en mayor cantidad y más rápido que las células primitivas. En la naturaleza, el animal tiene prisa por digerir, entonces, el cuerpo produce células que digieren dos veces más rápido. En último lugar, llegan los gérmenes que se desarrollan y provocan una infección.

Ejemplos

«Me falta **dinero y amabilidad** por parte de mi marido».

«Tengo miedo a **morir de hambre**».

Un hijo se **casa con una divorciada**; la madre, que sufre un malestar en la digestión intestinal, dice: «¡Mi hijo me deja de mala manera!».

Un **hombre echa a la calle a su mujer**. Doble *shock* para la mujer: perrería y miedo a no poder comer porque no tiene nada.

La señorita X, veinte años, explica: «Ya no puedo seguir asimilando toda esa información, todos esas clases en la facultad».

de biología». El **vientre** empieza a inflarse. La memoria, **relacionada con la asimilación, mengua.**

El señor X, veinte años, explica: «No me siento **aceptado, asimilado**, integrado en mi familia».

«**No acepto mi cuerpo**, su delgadez», lo cual crea un círculo vicioso; por lo tanto, la persona no asimila nada más, ningún alimento.

«Mi marido critica todo y a todo el mundo **durante las comidas**; sus palabras son como veneno que no quiero asimilar, recibir». Problemas intestinales.

✱

EL APÉNDICE

La vivencia biológica conflictiva

Conflicto de la *hucha*.

La tonalidad central es *arcaica*.

En ese gran «*tubo*» que es el aparato digestivo, que va desde la boca al ano, hay un pequeño callejón sin salida: el apéndice. Su descodificación corresponde a los conflictos de jugarreta, una pequeña «marranada» vivida en **un callejón sin salida** del que no podemos salir.

Conflicto a propósito de un asunto sucio, indigesto, que no podemos vaciar.

Callejón sin salida, jugarreta.

«Me siento dejado(a) de lado».

El apéndice tiene como equivalente, en el caballo, el primer estómago, donde pone el **grano bueno** para pasar la noche.

Ejemplo de origen de conflictos en los niños: caramelos, azúcar, **dinero de bolsillo**.

Problema relacionado con el dinero de bolsillo, el grano bueno, el trigo: «Me privan, injustamente, de las cosas buenas».

Ejemplo: cuando nos vemos sometidos a las jugarretas surge «la venganza es un plato que se toma frío».

Ejemplo

Una niña tenía una crisis de apendicitis y estaba a punto de ser hospitalizada. Se confiesa a su mamá, que la interrogaba sobre el drama vivido en la escuela.

Estaba en la primera fila, le gustaba estar al tanto de lo que pasaba en la pizarra. Al fondo de la clase, había un niño alborotador. Para poderlo vigilar, la maestra lo pone en la fila de delante, en el lugar de la **niña, que se irá al fondo de la clase**. Ella vivencia este cambio como un castigo y un rechazo ante el cual se encuentra impotente. Al cabo de algunos minutos, después de haber contado su historia, su vientre empieza a

ablandarse; una hora después, la niña se levanta y empieza a caminar. Finalmente, no tuvo necesidad de ser hospitalizada.



EL COLON / EL CIEGO

Órganos afectados

Mucosa y musculosa del ciego y del colon ascendente, transversal, descendente, sigmoide y la parte superior del recto.

Punto pedagógico: la puerta de entrada en biología

Cuando estamos en contacto con el mundo exterior, evidentemente, lo estamos con nuestros órganos de los cinco sentidos: vemos o escuchamos o tocamos o probamos u olemos. Estamos en **contacto orgánico con el mundo exterior**: lo comemos, lo digerimos, lo eliminamos, lo almacenamos, nos hace movernos, acelera nuestro ritmo, nos hace tomar elecciones, límites... Y, además, también estamos en **contacto interno** con el mundo reconstituido en permanencia en el interior de nosotros, en nuestros pensamientos, nuestros recuerdos, nuestro *imaginario -imagen inerte- magia de los nervios*. Y este contacto se hace bajo la forma de imágenes, de sonidos, de olores y de sensaciones orgánicas: respiratorias, digestivas, cardíacas...

En resumen, estamos en contacto con el mundo exterior o interior de manera *orgánica, biológica*. Y ese contacto es preciso: el alimento está en la boca o el esófago, el picor está en el flanco derecho o en el puño izquierdo.

Entonces, ¿qué quieren decir nuestras palabras: «*Puerta de entrada en biología*»?

Cuando un acontecimiento conflictivo entra en nosotros, lo hace como acabamos de presentarlo, de manera orgánica y precisa y la reacción de adaptación, que nosotros llamamos enfermedad, es orgánica y precisa. Padecemos un problema en el colon. ¿Se trata de un ataque de la mucosa, de la musculosa, del colon ascendente, transversal, descendente, o de una enfermedad del intestino: infección, tumor, parálisis? Pues **cada parte de cada órgano** tiene su sentido biológico, su función y sólo reaccionará (es decir, desencadenará un síntoma) cuando esta función sea útil, necesaria, vital.

De esta forma, un ataque vascular de colon (hemorragia), una parálisis (estreñimiento), una inflamación (colitis), tendrán en común un sentimiento de suciedad, de porque-ría. Tendrán como diferencia el tejido afectado (en nuestros ejemplos: vasos sanguíneos, músculos, mucosas) y la subtonalidad conflictiva (siempre en nuestros ejemplos):

— sangre: vínculos familiares,

— músculos: impotencia,

— mucosa: contacto.

Es como si el suceso, para entrar en nosotros, en nuestra biología, pasase por un portal constituido por diversas ascensiones, de las cuales, las dos principales son:

— el órgano (colon),

— el tejido de ese órgano (músculos para el estreñimiento y la diarrea).

El mayor interés de este concepto, es constituir muy rápidamente la **frase conflictiva biologizante**.

Un hombre desarrolla una **colitis**: en el portal, se trata del colon y de la mucosa inflamada, es decir, guarrada, rabia y contacto. Planteo la hipótesis de que él ha estado *separado con rabia de manera podrida (descompuesta) de...* Ignoro de quién, claro, la frase no informa sobre el contenido, sino sobre la estructura biológica de la experiencia, es decir, la vivencia. Él me dice: «Mi hijo ha traicionado mi confianza, se droga, ¡es asqueroso!».

Así, en primer lugar, frente a una enfermedad, la cuestión que podemos plantearnos es: ¿qué órgano está afectado? Y ¿qué parte de ese órgano? Después: ¿cuál es la descodificación general del órgano?, ¿cuál es la descodificación de la parte?

¿Cuál es el síntoma de la llamada?

Respiratorio, *aire*: eructos, gases, aerocolia.

Ejemplo: «Tengo que eliminar las tareas cotidianas para ser libre».

Vascular

Ejemplos:

- **Varices esofagianas**: «Hay un vínculo con mi familia, algo inaceptable que se me ha atragantado».
- **Hemorroides**: «Hay un vínculo con mi familia, guarradas que me impiden ser yo». «Es asqueroso que, en mi familia, no tenga sitio».
- **Infarto mesentérico, trombosis**: «He perdido ese territorio de evacuación de las guarradas».
- **Hemorragias digestivas**: «Quiero que alguien salga de esta familia, yo u otra persona».

Neuromuscular: estreñimiento, parálisis intestinal; **impotencia**.

Músculo: diverticulosis, leiomicosarcoma. «Me siento desvalorizado e **impotente** para eliminar esta guarrada».

Tiroides: diarrea; es **urgente** eliminar las guarradas.

Suprarrenal: falsa ruta aerodigestiva.

Sensorial

— **Visual:** *ciego*; guarrada que no debe verse.

— **Contacto:** *mucosa*. «Necesito contacto». Pólipo: «Aumento el contacto».

— **Auditivo:** atonía.

Sexual: invaginación intestinal aguda. «Tengo el proyecto de no hacer avanzar el pedazo de marranada». La señorita X ha sido violada.

Protección: peritoneo.

Identidad: recto.

Moral, la bolsa del tálamo: los conductos. «No tengo derecho a...».

Límite: esfínter.

La vivencia biológica conflictiva

Conflicto del *cerdo, del colon y del turista.*

La tonalidad central es *arcaica*.

Para descubrir el contenido conflictivo biológico de un órgano, basta con remitirse a su función biológica.

El colon (que utiliza miles de millones de gérmenes) elimina lo que el cuerpo juzga inútil, superfluo, sucio.

El colon hace avanzar las «materias» hacia el exterior. Encontramos aquí una noción de **progresión, de camino que se debe recorrer para evacuar lo inútil, lo sucio.**

Los músculos del colon son los que permitirán esa acción.

El colon **recupera el agua** contenida en las materias: «Quiero conservar a mamá, el líquido, las referencias, por eso reabsorbo el agua».

Maldad, mala jugada, traición, suciedad:

Conflicto provocado por una acción vil, baja, ofensiva, infame, desagradable, una jugarreta, una marranada.

Conflictos de «marranada».

Cuanto más avanzamos hacia el colon, los conflictos son más importantes. En la primera parte del colon, son pequeñas porquerías. Cuanto más avanzamos hacia el sigmoide, más nos enfrentamos a «jugarretas», «golpes bajos», «bribonadas», cada vez más «asquerosas» y «podridas» (descompuestas), para llegar al sigmoide y al recto, donde los conflictos son tan feos que no hay nada más

que hacer que **evacuarlos**. Hay en el recto esa vertiente suplementaria de querer evacuar.

Pistas para explorar prudentemente:

Conflicto del amor «**limpio**», ya que en el colon existe la noción de asqueroso.

Luchas intestinas.

Pelea entre nosotros y nuestros prejuicios.



Colon ascendente:

Marranada ligada al individuo en la línea de su familia que está por encima de uno mismo, tales como los padres, los abuelos, tío, padrino, patrón (etimológicamente, del latín *patronus*: protector; derivado de *pater*: padre), etc.

Las materias suben hacia...

Colon transversal:

Marranada en relación con los colaterales y asimilados: hermanos, hermanas, primos, esposos, etc.

Colon descendente:

Marranada en relación con los niños y asimilados: nietos, sobrinos, ahijados, alumnos, etc.

Las materias descienden hacia...

Megacolon:

Se traduce por treinta centímetros de colon de más. Los pacientes hacen de vientre menos a menudo.

«Quiero aumentar la superficie o el tiempo de contacto». «Necesito más tiempo para absorber, para digerir las cosas y, después, para evacuarlas».

Ciego:

Gran contrariedad, a menudo relacionada con los ascendentes a propósito de una «jugarreta», de una «marranada» imposible de dirigir, de aceptar.

Conflicto surgido a causa de algo demasiado «asqueroso», por no poder «digerirlo» nunca.

Asunto «feo», que no se puede «evacuar».

«No soy reconocido, ¡es asqueroso!».

«¿Qué es lo que no quiero ver podrido?».

Ciego está etimológicamente relacionado con la ceguera (del latín *caecum intestinum* «intestino ciego», esta parte del intestino es calificado de ciego porque constituye un callejón sin salida).

Colitis:

Se trata de una inflamación del colon.

«Es asqueroso y eso me irrita».

«Soporto repetidamente cosas indigestas».

Es una recidiva intermitente del mismo conflicto. Se soluciona y vuelve a empezar, por lo que no hay tiempo para producir un tumor.

Punto pedagógico: la inflamación

Desde que estamos en presencia de una inflamación crónica, a menudo manifestada por la sílaba **-itis** (como en los términos: colitis, sinusitis, orquitis...), buscamos la vivencia suplementaria de:

«Cólera, rabia»;

«Estoy furioso por esta situación».

Colitis espasmódica:

«Me dan afecto intermitentemente».

El afecto, a veces está y, a veces, no está; cuando no está llegan los dolores, los espasmos.

Rectocolitis hemorrágica, enfermedad de Crohn:

El intestino es inflamatorio. Puede sangrar. La enfermedad de Crohn, la mayoría de las veces, concierne al intestino delgado, la rectocolitis hemorrágica, al colon.

Es un conflicto de contrariedad indigesta y de jugarreta en relación con la familia cercana.

En caso de **hemorragias** abundantes, que no cesan, podría ser necesario explorar esa vivencia relativa a la línea de **sangre**: «Quiero dejar esta familia o quiero que alguien se vaya de mi familia, que la sangre salga del cuerpo familiar».

Para algunos descodificadores, el conflicto está relacionado con **el dinero**: fonéticamente, Crohn es una moneda escandinava llamada «corona».

«Me ha timado y, además, me echan la culpa». Es una forma de injusticia.

«Me echan la culpa, no es justo, es indigesto».

«Me ha timado, me falta dinero».

«Me han quitado un valor, algo».

Divertículos:

Salen como consecuencia de la presión interna, desencadenando pequeñas hernias. Debilidad de los músculos del colon sigmoide, necrosis o pérdida de los músculos y de la mucosa. Esto provoca como una bolsa exterior que se llena de excrementos.

Es como una hernia en un neumático de bicicleta.

Doble entrada biológica: muscular y digestiva.

«Me siento impotente para evacuar una marranada».

«Me siento impotente para eliminar las marranadas».

Estos pacientes, a menudo, niegan la mierda (heces) de los problemas: «¡Todo va bien! ¡*Pani problèmè!*».²⁴

«Me siento bajo presión a causa de una educación que me asfixia».

La turista o la necesidad de adaptarse:

Cuando salimos de viaje, la adaptación comienza por la adaptación a una nueva alimentación, el primer acceso a la vida y, a veces, la adaptación es difícil. Nuevos hábitos, nuevas costumbres vividas, en ocasiones, como repugnantes (vivir en un cuchitril, comer insectos, no lavarse, escenas de la vida).

24. En lengua creole en el original, significa: ¡No hay problema! (N. de la T.)

El cólera: esto puede estar correlacionado con una necesidad de depuración mucho más profunda en el ámbito de nuestra vida o de nuestra civilización.



Pistas para explorar prudentemente:

Para algunos investigadores, el colon representa nuestros prejuicios.

La diarrea es un rechazo, una huida o una depuración obligatoria para ir adelante. El estreñimiento es nuestra preocupación por quedar atados a nuestros principios. La colitis es la pelea entre nosotros y nuestros prejuicios.

Los divertículos, una presión educativa a la cual intentamos escapar. Es más apremiante que pegajosa.

En los pólipos, sentimos el deseo de eliminar nuestros prejuicios, pero no somos tan claros como parece. Participamos en nuestra dependencia.

**Punto pedagógico, un ejemplo de sentido biológico:
los pólipos - poliposis**

Aumentar la superficie de intercambio, ése es el sentido de la poliposis, ya sea en la nariz, en el colon o en la vejiga. La vivencia central es diferente según el órgano: peste, guarrada, territorio a delimitar. Pero, generalmente, se encuentra la necesidad de aumentar la superficie de intercambio, de contacto.

Senos: «No quiero perder el contacto de intercambio con el peligro y, sin embargo, ¡no soporto sentirlo!». Estoy al acecho. Los senos, la nariz, muy a menudo, tienen relación con el futuro; hay un peligro futuro.

Colon: «Quiero aumentar la superficie de intercambio para aumentar la absorción de agua contenida en las heces».

Ejemplos

Tumor de colon ascendente

Un jefe de cocina permite a un trabajador que coja un pastel, acto seguido le acusa y el trabajador se encuentra con una sanción. Este último desarrolla un tumor de colon ascendente, tiene un sentimiento de marranada en relación con ese patrón que está por encima de él.

«*Pani problème!*»²⁵

Un hombre está en reanimación en el hospital, entre la vida y la muerte porque ha desarrollado **divertículos del sigmoide**, que se perforan y provocan una peritonitis, etc. La psicología de este hombre es el equivalente de la ceguera, sólo que ésta no es visual sino colónica. Rechaza las mierdas, eso no existe. Algunos de los que viven el conflicto del avestruz son ciegos; él es: «No hay problema; todo va bien».

25. Ídem nota anterior.

El amante

La señora X escucha a su amante insultar e injuriar a su propia madre delante de ella. «Es malsano, dice ella, me dice porqué». Rectocolitis hemorrágica.

¡Nada que señalar!

El señor X padece rectocolitis hemorrágica desde hace siete años. Le pregunto:

—¿Qué pasó en esa fecha y después de esa fecha?

—Nada que señalar —es la respuesta.

—¿Se acuerda de la primera crisis de rectocolitis?

—Sí, me sobrevino en casa de... una muy buena amiga..., una mujer cultivada, brillante. Voy a su casa y, por primera vez, me la encuentro borracha. Es inaceptable, eso me llena de rabia. ¡Es un asco lo que dice, lo que hace!

—¿Esa amiga es importante para usted?

—Sí, por cierto, le llamo por teléfono todos los días después de esa fecha.

—...

La señora X tiene un tumor en el colon

Trabaja en el ayuntamiento que se traslada «a un barrio putrefacto», me dice. «Y eso me mata», añade. «Estaba bien donde trabajaba, es una marranada lo que me han hecho. No quiero ir allí». Desde ese momento, tiene la energía a cero. Quiere dimitir pero acaba de comprarse una casa, le da miedo que le falte dinero. Desarrolla entonces un tumor de hígado. Sus padres, al conocer su enfermedad, se pelean por la herencia. Ella está furiosa: «¡Pero todavía no estoy muerta!», patología biliar.

Enfermedad de Crohn en el colon

La señora X encuentra un hombre con el que todo va bien, se acuestan juntos, es magnífico. El tiempo pasa y ellos continúan su relación. Un día, en casa de amigos, él hace como si no la conociera. «Es un imbécil acabado; tengo ganas de irme pero no puedo, hemos cogido su coche, estoy furiosa, ¡pero furiosa! Es un perfecto gilipollas, me hace una jugarreta, un golpe bajo, feo, asqueroso».

Tumor en el colon

La señora X pierda a su madre y decide, generosamente, acoger a su padre en su casa. Ordena los papeles familiares y descubre que sus padres favorecían a su hermana, le daban sumas fabulosas desde hacía tiempo. Ella se siente indignada, desmoralizada, es asqueroso. Después, progresivamente, acepta todo esto; su padre se vuelve senil, es el principio de las hemorragias de este tumor. Estaba débil en el momento que descubre ese secreto, esa suma de dinero, por la pérdida de su madre.

Sentido biológico

El cerdo come todo lo que encuentra. Es su colon el que, después, selecciona y rechaza lo podrido, lo elimina hacia el exterior.

Del mismo modo, el turista hambriento o el colono (como Cristóbal Colón), que se encuentra en una tierra que no es la de sus ancestros, lejos de su lengua materna, para sobrevivir, acepta comer lo que le proponen. El intestino grueso (o

colon) toma lo útil y rechaza lo inútil, lo dañino, lo tóxico, lo superficial y lo podrido.



EL RECTO SUPERIOR / SIGMOIDE

Etimología: recto viene de *rectus*, que significa «derecho».

Órganos afectados

La submucosa de los dos tercios superiores del recto.

La submucosa del sigmoide.

La vivencia biológica conflictiva

Conflicto de la *asistente doméstica*.

La tonalidad central es arcaica.

Contrariedad que no llegamos a evacuar, a expulsar.

Conflicto derivado de algo vil, innoble, bajo, abyecto, «asqueroso», infame.

No expulsión de los **residuos** de un pedazo.

«No puedo soltar el pedazo».

Conflicto provocado por una acción aún más vulgar y envilecedora que el colon.

Gran contrariedad, a menudo relacionada con los niños (descendientes), provocada por una «marranada», una «jugarreta» imposible de digerir, «¡Es demasiado asquerosa!».

Ejemplo: perdón imposible.

Síntomas

Hipersecreción de la mucosidad - Tumores proliferantes - En caso de un tumor grande, riesgo de oclusión intestinal - Pólipos - Hemorragias - Tumefacción que, a veces, produce hemorragias internas - Abscesos submucosos.

Ejemplos

El señor X tiene un **tumor en el recto**.

Con gran alegría, decide comprar un restaurante con una amiga. El día previsto para la firma ante el notario, ella le llama por teléfono para decirle: «Al final, no compro el restaurante contigo, ¡quédatelo solo!».

Su sentimiento es: *«Esto es injusto. Me ha hecho una marranada»*. No dice nada y va a firmar solo al notario. Según me contó, entró en el restaurante y frotó las paredes para quitar la energía negativa que las impregnaba. Por otra parte, él tiene un hijo minusválido que no habla. Llorando por primera vez, me dijo: «Lo que le pasa es muy **feo**, no tiene y nunca tendrá vida propia».

La señora X tiene un **tumor en la parte inferior del colon**. Confiesa: «No soporto tener emociones negativas, como la rabia; me siento embrutecida por mis emociones, las quiero expulsar».

Además, quiere **echar a su marido de casa** y no lo hace.

El señor X recibe por primera vez a la novia de su hijo en su casa; muy contento al principio, durante la comida observa cómo la novia ordena a su hijo, le insulta y le humilla, de manera muy natural. El señor X sólo tiene un deseo: **verla irse del lugar**.

Cinco meses después, su hijo le anuncia que acaba de dejar a esa mujer; poco después, aparición de **sangre en las heces** y diagnóstico de tumor en el recto.

✱

EL RECTO INFERIOR

Órgano afectado

El tercio inferior de la mucosa del recto.

La vivencia biológica conflictiva

El conflicto de la *perra*.

La tonalidad central es *social*.

«Me siento dejado de lado, al margen».

Conflicto femenino **de identidad**.

«No tengo un lugar en mi propio territorio».

«En mi familia, no se me **reconoce**».

«Quiero estar en el centro, monopolizar toda la atención».

Conflicto de **situación** en el territorio mal vivido.

«No sé dónde está mi lugar, cómo situarme».

«No consigo situarme en mi territorio, en mi familia...».

«No puedo dar marcha atrás».

«Nado entre dos aguas».

Conflicto de no saber dónde se está.

«Tengo miedo a ser abandonado en el territorio».

Conflicto de abandono.

Miedo a no poder situarse en el territorio y, por ello, no poder encontrar la propia identidad.

Conflicto de no poder situarse solo, de ser abandonado en el interior del propio territorio.

La dificultad de situarse en el seno de la propia familia se vive como una separación, una pérdida en relación a su papel en el clan: «**Ya no sé qué pinto en esta familia**, en este nido, en esta casa, en este clan».

Conflicto de carácter semisexual.

Una manera de decir que tengo algo mío es diciendo la palabra *propio*.²⁶

26. El autor hace un juego de palabras con la palabra *propre*, que puede significar «propio» o «limpio». (N. de la T.)

Cuando el niño va a hacer de vientre, se le dice: «**es limpio**».²⁷

Algunas personas sólo van a hacer de vientre en su propia casa. Les resulta imposible hacerlo en casa de la familia política, de vacaciones, etc. De regreso «a casa», es la debacle, el colon se vacía, ¡**nos sentimos en casa!**

Las personas **sentadas en el borde de la silla**, a veces, se han sentido situadas al margen y estimulan su recto para sentir su sitio.

Ciertos animales, como el panda, tienen una glándula cerca del ano que evidencia su identidad. El animal, como por ejemplo el perro, busca el centro de su territorio para situarse y, allí, defeca.



Hemorroides

Las hemorroides, a veces, traducen una debilidad identitaria (*dilatación de las venas a la altura del ano*).

«Trato de asentar una personalidad que aún es débil, incompleta».

Problema de identidad relacionado con la filiación.

Las hemorroides internas = conflicto activo de marranada (arcaico, 1.^{er} estrato).

27. *Idem.*

Las hemorroides internas tienen una similitud con el **sigmoide y la parte superior del recto** (arcaica, 1.º estrato, véase el capítulo precedente).

Tiene una bola de preso, una cosa podrida que eliminar, vivida de modo digestivo y venoso.

Las hemorroides externas = conflicto de identidad (social, 4.º estrato).

Están relacionadas con el conflicto de la **parte inferior del recto** (4.º estrato, social, que acabamos de estudiar).

El conflicto es parecido al de la epidermis:

«Necesito marcar, **encontrar mi sitio**, tener raíces y no nadar entre dos aguas».

«Estoy separado de mi sitio, de aquel que en el fondo soy yo».

La mujer embarazada debe, durante un tiempo, perder su identidad para que su niño tenga una. *Ella se descentra, se desprende*. Por eso, a menudo, desarrolla hemorroides durante el embarazo.



Para los zurdos y las zurdas:

Conflicto de rencor en el interior del territorio (véase vías biliares).

«Tengo al otro pegado a mi espalda».



Predicados del recto

«Carezco de consideración, de respeto».

REC-to; *reconocido, reconocimiento, rectitud.*

El señor X, que tiene un tumor en el recto, me dice: «Me siento mejor ahora, tengo la impresión de **salir de la mierda**. Tengo ganas de eliminar el tumor que tengo en el vientre, de hacerlo resbalar, de parirlo».

Síntomas

Tumor ulcerativo en el recto, espasmos y dolores. Fuerte tumefacción de la mucosa y hemorragias de las úlceras. Sangre clara. Estreñimiento. Oclusión. Hemorroides externas (sobre todo en la zona cercana al ano).

Crisis épica: ausencia, hiperestesia puesto que el relevo cerebral está situado en el córtex somato sensorial.

Sentido biológico

Los perros se huelen el recto.

En cuanto se encuentran en su casa, van a hacer sus necesidades. Un hombre tiene tres perros que mueren con poco tiempo de intervalo. Los perros del barrio, en los días siguientes, vienen a hacer caca delante de su puerta. Él se ve obligado a cercar toda su propiedad para evitarlo. Es como si esa propiedad estuviera vacía, ya no perteneciera a nadie, y los *perros*

se la apropiaran marcando su identidad, su señal, su olor con sus excrementos.

El cuerpo utiliza una función arcaica (eliminar), la desvía de su sentido primero para darle un papel social, de comunicación, de información.

El niño, cuando su sistema nervioso madura, controla sus esfínteres y utiliza sus excrementos como **moneda de intercambio**.

«¿Tengo derecho a ser yo mismo?» parece ser la pregunta que se le hace al padre.

Ejemplos

Tumor en el recto

A un chico que está en acogida familiar le dicen en la escuela: «¡Ni siquiera sabes quién es tu padre!».

Una chiquilla de once años se siente desplazada, abandonada y vacía desde que su madre ha instalado un **ordenador en su habitación**. Porque ahora todas las amigas de su madre vienen a todas horas a utilizarlo. Entran en cualquier momento en su habitación y ya no se siente en su casa. Desde entonces, siente una sensación de vacío, sin poder expresarse. En cuanto toma conciencia, experimenta **espasmos rectales** durante la sesión.

Un hombre se va con su mujer de vacaciones. Llegan a un hotel, la habitación es muy pequeña y la cama inmensa. El marido está muy contento. Desarrolla hemorroides que pro-

vocarán hemorragias. **Tiene todo su espacio para su identidad sexual.** Eso colma sus vacaciones.



EL ANO

La vivencia biológica conflictiva

Situado al final del camino digestivo, ano quiere decir «anillo»,²⁸ el anillo de la alianza que se hace aquí con nuestra identidad.

Las «enfermedades del anillo anal», generalmente, son el índice de un problema de identidad. **Debilidad de carácter, influenciable**, sin personalidad. «No logro decir no, por miedo a dar pena, a ser rechazado, a no ser más amado...».

La manera en que el orificio rectal retiene las heces, a veces, está en relación con el **dinero** (Freud).

También puede tratarse de un **problema de pareja**, de anillo, de alianza.

Prolapso rectal:

«Estoy imposibilitado para encontrar mi sitio».

A menudo, se añade una impresión de impotencia.

«Me siento rechazado», a menudo, con una gran rabia de no poder afirmar su identidad.

28. *Anneau*, en francés. (N. de la T.)

«No me siento apoyado en mi territorio, en mi identidad».

Encopresis (incontinencia de las heces en niños, el «*caca braguita*»):

Miedo que paraliza, pudiendo conducir a la larga a graves trastornos de la personalidad.

«Mi identidad existe, pero no consigo estabilizarla».

«Me vacío, me pierdo», abatimiento.

¿Qué hace el padre? ¿Dónde está? ¿Se ocupa del hijo? ¿Le transmite una identidad, un nombre? - No.

Desbordamiento de las heces:

«Es vital desintoxicarse».

Vieja memoria de envenenamiento.

Supuraciones del ano:

«Tengo miedo de perder». (Dinero...).

«Aprieto las nalgas para guardar el máximo pero, de todas maneras, eso acaba pasando».

La inflamación añade una nota de rabia.

Fístula en el ano:

La **fisura** está un estado mucho más avanzado.

El rencor está al máximo. Los secretos son omnipresentes.

El orgullo reina como maestro para disimular la debilidad.

La identidad reprimida, a pesar de todo, intenta salir. Pero, como la vía natural está seriamente cortada y controlada, se traza una vía fuera del ano para acabar, igualmente, por manifestarse.

Fisuras anales:

«No, ya no eres mi hombre o mi hija, etc.».

«Para mí, ya no eres nada».

«Mi identidad está como borrada».

«La idea de oponerme, me desgarrar».

Dolores agudos:

Ruptura brutal.

Rechazo de contacto.

Prurito del ano:

«Me siento separado de mi caca, de mi identidad, de mi yo, de manera injusta».

Mariscos:²⁹

«*Marisco*»— problemática en relación al matrimonio y conflicto de identidad.

Observación: estado anal

Para el niño, el estado anal coincide con su primer dominio de su relación con el mundo. Él y el mundo son dos identidades distintas. Y para continuar existiendo, él toma consciencia de que no puede guardarse todo, debe renunciar a conservar todo. Renunciar permite afirmar su diferencia. Escoger es re-

29. Mariscos: patología, pequeñas masas alrededor del ano.

nunciar. Y para poder renunciar, es preciso haberse forjado una identidad suficientemente fuerte.

Ejemplos

Prurito anal de las 18 a las 6 h

La señora X da a luz y después la separan de su bebé durante las dos primeras noches en la maternidad... de las 18 a las 6 h.

La señora X padece **prurito anal**, se siente separada de su identidad. No lleva el nombre de su padre, a quien tanto quiere, y todo por culpa de la Iglesia, porque fue concebida antes del matrimonio.



EL PERITONEO

La vivencia biológica conflictiva

Conflicto de la *tortuga*.

La tonalidad central es *protección*.

Mesotelioma peritoneal:

«Tengo miedo de lo que ocurre en el interior de mi vientre».

Ataque contra la cavidad abdominal.

Pánico por lo que ocurre en el vientre, por ejemplo: «Tiene un importante cáncer de hígado». Esto puede ser vivido como un **atentado contra la integridad de la cavidad abdominal**.

Amenaza de un mal que «carcome por dentro».

Miedo a una enfermedad sexual (sobre todo en la mujer).

Conflicto en el que el vientre se siente gravemente atacado, ya sea directamente de manera física, o de manera psíquica.

La afectación no tiene por qué ser necesariamente física ni dolorosa, pero siempre existe el miedo.

Miedo por su riñón: se verán afectados la pleura o el peritoneo. No todos los enfermos son médicos o anatomistas.

Peritonitis:

Conflicto en el intestino + conflicto en el peritoneo.

El dolor, muy fuerte, puede inducir a un conflicto central de separación.

Adherencias:

Pueden deberse al regreso de los conflictos por miedo a ver lo que está allí dentro.

Se crean para atraer más cantidad de sangre.

«Tengo miedo por mi vientre, quiero protegerme del exterior».

Saco de Douglas:

«Tengo miedo hasta lo más recóndito de mí mismo».

Ataque a la integridad de lo más recóndito del organismo.

Ascitis:

La punción de ascitis, a veces, es vivida como un nuevo ataque contra el abdomen y crea, así, una recidiva. Quitamos albúmina, lo que fatiga porque el cuerpo debe rehacer líquido de ascitis rico en albúmina. En consecuencia, es esencial explicar bien al enfermo la función de esas punciones y ayudarle a vivirlas lo mejor posible.

Pistas para explorar prudentemente:

«Hago caso omiso de los consejos de mi familia».

«He saldado una deuda».

Síntomas

Tras el *shock* se desarrollan, o bien pequeños mesoteliomas, bien gruesas nudosidades compactas, según el paciente se sienta atacado «globalmente», desde todas las partes, o en un lugar determinado, preciso.

La localización del mesotelioma no tiene nada que ver con el emplazamiento de un tumor preexistente, sino que depende únicamente del lugar en el que el paciente se siente atacado. Si, en el momento del *shock*, se encuentra, por ejemplo, en presencia de una radiografía de su hígado y se ve un «tumor» a la izquierda, es en la izquierda donde va a desarrollar el mesotelioma y, más adelante, se extenderá, a pesar de que el tumor se encontraba en realidad a la derecha.

Ejemplos

Tumor en el peritoneo por encima del ombligo

La señora X se entera de que su hermana ha intentado suicidarse clavándose un puñal en el vientre. Desarrolla un miedo por su hermana, tiene la necesidad de proteger el vientre de su hermana. Es un conflicto por identificación.

Tumor en el peritoneo

La niña X tiene miedo de coger una enfermedad de transmisión sexual y, además, una impresión de suciedad. Trata de proteger sus órganos de esa suciedad, de ese peligro. Es un conflicto con vivencia de ataque contra el vientre. Para la niña, el sexo es el vientre.

Dos casos de ascitis

El señor X ha tenido un cáncer de próstata y tiene **miedo a una metástasis en el colon.**

Una mujer está embarazada y tiene **miedo por su bebé:** patología del peritoneo.

*

EL EPIPLÓN MAYOR

La vivencia biológica conflictiva

«Conflicto provocado por un asunto *feo*, indigesto, del que intento protegerme».

«Es moralmente asqueroso».

La vivencia es parecida a la del colon, pero más desde el punto de vista moral.

Marranada indigesta vivida en términos de desvalorización.

Este frecuente conflicto está en el origen de algunos **vientres voluminosos**. Aunque los vientres voluminosos tienen otras interpretaciones como: «Pongo mis emociones a distancia», o «Claudico, abandono un proyecto que, sin embargo, era importante para mí».

En la naturaleza, el epiplón recubre la rotura del intestino.

mplo

a joven es anestesiada por problemas ginecológicos. Desde que se despierta, tiene la sensación de que ha pasado algo malo y desvalorizante, que han abusado de ella durante su sueño artificial. Siente fuertes dolores abdominales inexplicables, pero duda a la hora de hacer que la examinen de nuevo.



LOS VÓMITOS

La vivencia biológica conflictiva

El encauzamiento (de alimentos) es imposible.

Los conflictos del duodeno, del estómago (4.º estrato), provocan espasmos y después vómitos (úlceras gastroduodenal).

Contrariedad familiar reciente.

Conflictos de rechazo de lo que se me propone (impone).

Los conflictos de **miedo**: los niños que tienen miedos, que se asustan, que sienten angustia, pueden vomitar.

Miedo a cáncer de estómago.

Ejemplos:

Casa imposible de vender.

Una casa comprada con un contrato no válido; eso se queda en el estómago y no puede salir.



EL ESTREÑIMIENTO

Órganos afectados

Nervios sensitivos, nervios motores.

Las vivencias biológicas conflictivas

Las posibles causas del estreñimiento son numerosas:

Conflicto n.º 1 - Un conflicto de identidad en el territorio

Esto puede provocar una anestesia del recto inferior (4.º estrato), que ya no siente que está lleno. Ya no hay información hacia el cerebro que, a su vez, no puede mandar la orden de defecar, por lo que se produce estreñimiento, seguido de heces blandas.

N.º 2 - Un conflicto de separación

Los conflictos de separación que rigen la parte inferior del cuerpo pueden provocar una anestesia del recto, por lo que se produce estreñimiento, seguido de heces blandas. Sensación de frío cuando el conflicto es menos intenso.

Ejemplo: La señora X se siente aislada en el trabajo, arrinconada. Tiene episodios de estreñimiento.

N.º 3 - Un conflicto relacionado con la motricidad de la parte inferior del cuerpo

Esto crea una parálisis del recto y, por tanto, estreñimiento debido a la interrupción del tránsito.

«Todo va demasiado deprisa, quiero disminuir el flujo de problemas que me caen encima».

«La vida va demasiado deprisa, hay demasiadas cosas que gestionar. Quiero ir más despacio para tener el tiempo de integrar, porque a pesar de todo quisiera integrar...».

«No sé qué hacer para solucionar esto, para hacer resbalar esta marranada. Esperando, me bloqueo, reflexiono, tomo mi tiempo».

Ejemplo: La señora X me dice:

«Hay dos partes en mí:

quiero acelerar los aprendizajes interiores,
frenar el movimiento exterior».

«Tengo que ir pero no quiero ir».

Ejemplo: estreñimiento que aparece en un viaje o ante la idea de ir al colegio o al hospital.

En fase de estrés = estreñimiento, heces duras, parálisis del colon.

En fase de reparación = cólicos, dolores.

N.º 4 - Un gran miedo

«**Rápidamente**, quiero desembarazarme de lo que me angustia».

«Me siento **impotente para reaccionar, para eliminar** este mal rollo».

En fase de estrés = estreñimiento, heces duras.

En fase de reparación = cólicos, dolores.

N.º 5 - El colon recupera el agua contenida en las materias

«Quiero conservar todo el amor de mi madre, por eso reabsorbo el agua».

«Quiero reabsorber el amor de mi madre», y el cuerpo va a conservar un tiempo más largo los alimentos.

«Siempre necesito más amor maternal».

«Quiero reencontrar el amor de mi madre, de lo femenino». El agua es la madre.

«Quiero retener el **dinero** que se me escapó».

N.º 6 - Estreñimiento átono

«Estoy consternado por la marranada (colon) o la cosa indigesta (intestino delgado) que escucho».

N.º 7 - Eliminar es renunciar

El **estreñimiento** traduce la dificultad de soltar las cosas antiguas, los miedos, los prejuicios, los viejos principios. De esta manera, manifiesto que tengo dificultades para aceptar la renuncia, para ir hacia adelante. De alguna manera, la vida se paraliza, se repliega en el pasado.

Inversamente, la **diarrea** crónica expresa el rechazo de los prejuicios y de los principios dictados por el entorno.

El colon juega un rol fundamental en las enfermedades crónicas. Éstas traducen, para ciertos investigadores, la dificultad de abandonar las viejas creencias.

El colon aparece como el lugar de lo preconcebido, del inconsciente parental, sobre todo maternal. Aquel del que el niño debe salir para acceder a la edad adulta. Dejar su

herencia para convertirse en él mismo. El miedo a dejar, a abandonar sus valores y, concretamente, a abandonar todo aquello que un día nos perteneció, de una manera u otra; esto es el **estreñimiento**. Se agrava en cuanto estamos de viaje, lejos de las costumbres, en váteres que no son los nuestros, con la excusa de la limpieza, la fobia a los microbios.

Algunos están en conflicto con los principios recibidos: crisis de colitis, luchas intestinas incesantes, tantas que no saben si van a aceptarlas y someterse, o a rechazarlas. Entonces, aparece la alternancia de episodios de diarreas y de estreñimientos.

Enfermedad de Hirschsprung

Es un estreñimiento congénito gravísimo.

«Es preciso, absolutamente, retener, guardar en mí, en mi vida, un pedazo muy indigesto y muy abyecto; y, además, me siento impotente y sumiso».

Ejemplo: un subalterno debe «prestar» su mujer a su superior.

Ejemplos

Estreñimiento

A los veinte años, la señora X está enamorada de un chico, que le corresponde; es maravilloso. Después, se pierden de vista a causa de malentendidos. Veinte años más tarde, aunque vivían en los Alpes, ella se traslada al norte y él también.

Sin saberlo, viven a dos kilómetros uno del otro! Un día, ella decide buscar a su gran amor de juventud, quiere recrear el vínculo entre ellos. Y cuando, finalmente, encuentra su pista, al lado de su casa, se entera de que acaba de tener un accidente en la carretera y que está en coma. Cuando sale del coma, ya no la reconoce. Se queda helada, se siente cortada, paralizada, no reconocida y empieza el estreñimiento (*véanse más arriba los conflictos n.º 1 y n.º 3*).

Desde que su amigo empieza a beber, ella tiene la impresión siguiente: «Ya no sé qué hacer frente a él, ya no sé qué hacer» (*conflicto n.º 1*).

La señora X, estreñida, me dice siempre al acabar la sesión: **Me hace falta tiempo para entender», el tiempo de tránsito.** De alguna manera, entiende el significado con su colon. Por otra parte, es empleada doméstica y grosera, dice continuamente «a cagar - asqueroso, etc.».

Observaciones

1. Es asombrosamente curioso, pero me he fijado que las personas con patologías de boca, de dientes... tienen una comprensión inmediata de lo que pasa en terapia o en la vida en general, mientras que los «colónicos», francamente, necesitan más tiempo para integrar la información, el trabajo.
2. En fase de reparación de la mayoría de los conflictos, todos los pacientes utilizan mejor los alimentos, se ab-

sorben el 80 por 100 en lugar del 40 por 100. Las personas comen igual, pero eliminan menos y engordan. Es un falso **estreñimiento**.



LAS DIARREAS

La vivencia biológica conflictiva

Las posibles causas de la diarrea son numerosas. En cuanto se soluciona el conflicto, la diarrea se acaba.

Conflicto de **pequeña jugarreta** que se encaja.

Falta de amabilidad.

Conflicto de **miedo visceral**.

Conflicto de **autoridad** injusta y padecida por un niño de carácter libre.

«Es preciso limpiar, depurar antes de ir hacia adelante».

«Quiero eliminar lo inútil, dejar lo que ya no me sirve y que me pudre la vida».

«Rechazo las creencias que me imponen».

Tan pronto dentro, tan pronto fuera: la diarrea

Cuando comemos algo que no nos conviene, tenemos dos soluciones: o vomitamos enseguida, si es claramente tóxico, o tenemos diarrea si, **a fin de cuentas**, esto no es bueno para nosotros.



Diarreas, colopatías funcionales:

«No puedo digerir el pedazo en un ambiente de impotencia».

Diarrea por falta de asimilación:

Si, cuando esto me sucede, no digo *stop* a la información, a la propuesta, a la orden, a la comida, etc., si no sé decir no, rechazar, reafirmarme, hacerme respetar, en una palabra, **decir basta, es decir, dar la orden de parar** abajo, *diarrea abajo*; el intestino se niega a digerir eso, de convertir en mí esto y aquello, y evacúo tal cual, sin digerir.

Ejemplo:

La señora X asume los problemas de los demás; no separa en su plato los guisantes de las piedras. Se lo come todo y, una vez en el vientre, rechaza con fuerza las piedras... y los guisantes. No quiere decepcionar a nadie y, por eso, se come las piedras. Quiere resolver los problemas de los demás, después limpiarse lo que tiene de sucio en ella misma, lavarse el intestino.

Diarrea por aceleración del peristaltismo:

Sujeto tirodiano y digestivo: «Tengo que acabar todo antes de empezar».

Conflicto de miedo a no poder encauzar el pedazo.

«Tengo miedo de que los alimentos se queden bloqueados».

«Tengo miedo a tener problemas».

«¡Esto no va a pasar nunca y quiero que pase!».

«El encauzamiento es imposible, sean los alimentos, la venta de una casa, etc.

«Deseo acelerar las cosas; ¡la gente, los coches no van lo bastante rápido!», me dice una paciente.

Ejemplo: un niño que tiene que hacer dos horas de violín quiere acelerar el tiempo para ir rápido a divertirse, siempre quiere que sea más tarde.

Heces frecuentes:

«Para digerir el pedazo, es preciso que siempre haga todo más deprisa», porque el pedazo es importante y la digestión debe ser más rápida.

Puede tratarse de pacientes que tienen en su memoria padres que tenían mucho trabajo; apenas habían acabado el último bocado y ya tenían rápidamente que volver al trabajo.

Cuando todavía no se ha sabido hacerse una idea de uno mismo, de los otros, de la muerte, de la vida, ¿cómo funcionamos? Con las ideas y los juicios de los otros, de sus padres, de su entorno, de la publicidad, de la televisión. Un juicio exterior, una evaluación, un punto de vista precede a nuestro «propio» juicio, es un prejuicio. **Es la herencia familiar y, en particular, maternal.** Ilustración: el bebé koala come las materias fecales de su madre para poder digerir los venenos contenidos en las hojas de eucaliptos.

En el niño, podemos ir a buscar los miedos.

Miedo al colegio, miedo a los padres, etc., angustias.

Naturalmente, el niño es más bien digestivo, por su relación con su madre.

«Quiero evacuar *esto* rápidamente» y tiene pequeñas diarreas, o espasmos, o colitis o vómitos. «Porque me imponen el mundo exterior, los contactos en el colegio, los compañeros, los amigos de la familia, etc., y tengo ganas de evacuar eso rápidamente - diarreas, colitis, o eso no pasa, vómitos». Todas estas vivencias van a provocar todas estas pequeñas patologías.

Presentación de un caso en el cual se pone de manifiesto el sentido biológico

«La semana del 8 al 12 de noviembre, tenía un horario muy cargado y sólo dos días de descanso (el 11 y el 12). El 12 por la mañana, hacia las 8.15 h, mi móvil suena, es la dirección del hospital, que me pide reemplazar a una colega que está enferma (tiene una *gastroenteritis*).

Estoy cansada; **cogida de improviso, acepto a pesar de todo**. Ese día, teníamos previsto aprovecharlo y pasarlo en familia. El tiempo de organizarme, pido a mi responsable, en compensación, que me reemplace el domingo que viene para descansar, pero la respuesta es negativa. Estoy decepcionada y con rabia, me voy al trabajo **contrariada** y paso la jornada con ese estado de ánimo. Mi sentimiento es, con la distancia: «Es injusto y asqueroso, soluciono los problemas de los demás y no obtengo nada a cambio (de parte de mis colegas)». El sábado por la mañana, empiezo a sentirme mal (dolor de cabeza, agujetas, náuseas) y se me declara, a mí también, una gastroenteritis el sábado por la noche (diarrea + vómitos)».

Sentido biológico: «He vivido esta contrariedad de manera indigesta. No puedo aceptar esta injusticia por parte de mis colegas de trabajo, rechazo todo lo que viene del exterior (los alimentos, los colegas) y elimino, al mismo tiempo, esta suciedad lo antes posible: diarrea».

✱

EL AIRE

Síntomas

Eructos, flatulencias, aerocolia, gases intestinales, pedos y pedos pestilentes.

La vivencia biológica conflictiva

Los eructos

«Me falta aire, ligereza, libertad, en el intercambio relacional».

«No acepto que la relación sea pesada, plomiza».

Los gases intestinales

1. Conflicto relacionado con la motricidad del peristaltismo:

Marranada que no se digiere y no se puede hacer bajar, evacuar.

Gases intestinales (inodoros) para empujar el pedazo y hacer avanzar las heces y el químo (para evitar la oclusión, por ejemplo).

Sentido biológico:

Es una reacción del organismo: si algo se tapona, se fabrican gases para que lo puedan destaponar. El cuerpo fabrica gases que empujarán las «mierdas» que simbolizan problemas (*entuerto*).³⁰ En cambio, el aire simboliza la libertad, la vida.

2. Conflicto en los conductos biliares o pancreáticos:

Los jugos pancreáticos y hepáticos dejan de pasar, se segregan menos. Como consecuencia, los alimentos fermentan y se produce la emisión de gases malolientes en el interior de los intestinos.

Rabia, injusticia, rencor, interiorizados.

3. Alguien ha muerto sin sepultura:

Problema con las tumbas, ha habido un muerto sin tumba. «Hay alguien que ha muerto, o un animal, y no sabemos dónde está el cuerpo, no hay sepultura».

4. «Necesito libertad, espacio, vida y me presionan».

«Quiero protegerme de lo que me imponen, poner aire entre mí mismo y los alimentos, el exterior, todo lo que me imponen».

30. Relaciona la materia fecal con la palabra francesa *emmerdements* (problemas). (*N. de la T.*)

«Me aburro, me muero de asco y quiero desechar todo lo que me fastidia para sentirme más libre y más vivo».

«Necesito más espacio».

La entrada biológica es digestiva y respiratoria: «Pongo espacio, libertad entre el exterior y yo».

Ejemplo:

Aerocolias inflamatorias del colon descendente

La señora X dice: «Estoy rabiosa (inflamación) por la manera en que mi hija (descendiente) usa la libertad (aerocolia) que le doy para hacer cosas asquerosas (colon)».

5. «Necesito llamar la atención, mostrar que existo y, al mismo tiempo, quiero alejar a ciertas personas que están a mi alrededor y que me fastidian».

6. «Me presionan y sufro, pero no reacciono».

Ejemplo

El señor X tiene muchos **gases intestinales**: sufre una acumulación de problemas. Cada vez que soluciona uno, enseguida le llega otro. Las preocupaciones le invaden, le privan de libertad.

CONCLUSIÓN

Los dos escollos

Existen dos escollos, dos extremos, cuando deseamos ayudar, hacer un favor, permitir el cambio, *agrandarlo*, conferir más consciencia o salud. Se trata de:

- **Hacer creer en Papá Noel**, ser víctima de una inconsciencia, ingenua e infantil.
- **Pensar que todo está perdido**, que no hay nada más que hacer; ser víctima del fatalismo.

En el primer caso, hacer creer en Papá Noel, el peligro está en prender una esperanza que, una vez apagada, enfriada, frustrada, convertirá al sujeto en alguien desamparado, desalentado. Una esperanza de curación que ningún terapeuta controla. En efecto, seamos honestos: ninguna corriente terapéutica puede decir: «¡He curado, curo y curaré a todo individuo de todas las enfermedades!». Peor que creerlo es hacerlo creer. Que practiques la descodificación biológica, la osteopatía, las flores de Bach, la alopática o el psicoanálisis, no cambia nada esta evidencia.

Desgraciadamente, forzoso es reconocer que un cierto número de pretendidos terapeutas dejan creer que todo es posible. «*Basta con..., ver a ese terapeuta, comprender que..., encontrar su emoción, volver a su antepasado..., etc.*». Pero esto no es tan simple, no siempre.

Es urgente deshacerse de la creencia en su *omnipotencia infantil*, creencia descrita por los psicólogos. ¡Creencia del niño que piensa que basta desearlo para que funcione! Un excesivo número de pacientes, de lectores, de terapeutas, se han quedado atascados en este *pensamiento mágico*. Volverse adulto es aceptar la realidad de nuestros límites.

Pero en el interior de esos límites, sabedlo: *«¡Hay sitio! Hay cosas que hacer, vivir, desplegarse, realizar y realizarse, amar y ser amado, infinitamente...»*.

En el segundo caso, en el otro extremo, encontramos el fatalismo: *«Ya no hay nada que hacer. Estás perdido. Está escrito en las estrellas o en un libro: estás perdido, no nos curamos de eso...»*.

Sin embargo, es frecuente enterarse, a través de una revista, un artículo, un testimonio, que un hombre, una mujer, acaba de curarse espontáneamente de una leucemia, acaba de desembarazarse de una infección, incluso que un bebé seropositivo se ha convertido en seronegativo, que el melanoma de tal persona se ha fundido como la nieve al sol. ¡Quizás se puede creer que, alguna vez, por lo menos una afección ha podido ser vencida! Sea por el rezo, por la autosugestión, la hipnosis, el psicoanálisis, la lectura, los antibióticos, Lourdes, la descodificación biológica, las visualizaciones hacia y contra todo, el amor, un régimen, una decisión, un viaje al mar contra viento y marea, entre otros. Y esto es, realmente, fascinante, comprobar estas curaciones y preguntarse: «¿Por qué, pero por qué tal persona se ha curado de esta patología y por qué aquella otra ha muerto de la misma patología?», esas

dos personas teniendo el mismo peso, el mismo diagnóstico, los mismos recursos, ¿por qué, *cuál es la diferencia que les hace diferentes?* Y una diferencia de peso: tener una remisión, mejorar, curar.

Los transversales de la curación

Investigadores estadistas se han hecho esta pregunta: «*¿Pero qué es lo que provoca la curación, sí, qué camino es el mejor?*»: la alopátia, la homeopatía, la kinesiología, la chocolaterapia, el psicoanálisis freudiano, lacaniano o junguiano, la terapia genealógica, transgeneracional o psicogenética?

Al final de un largo estudio, la sentencia se dejó caer: la mejor terapia, la más eficaz, la más duradera, la más profunda..., la primera de todas las categorías es: *la relación*. La calidad de la relación. Relación entre paciente y terapeuta, relación que permite otra relación, la que hay entre consciente e inconsciente, problema y recurso, entre pasado y futuro.

¿Y qué es una relación de calidad, según esos especialistas?

Es una relación intensa, emocional y de confianza con una persona que te ayuda; un intercambio claro en el que cada persona es ganadora. Un terapeuta que **explique** el método teórico que él utiliza y que permite al paciente **integrar** esas nuevas concepciones. Un terapeuta que despierte la esperanza haciendo **experimentar una mejoría**. Y sobre todo un terapeuta que **acompañe al paciente en su vivencia**, un terapeuta que permita a todo paciente domesticar su vivencia, domesticarse, de esta forma, a sí mismo con toda seguridad.

Así pues, se trata de domesticar esos monstruos interiores que, a veces, los llamamos Vulcano, Lucifer, Zeus, Amazona, Príapo, Thor, Procusto... y, a veces, todavía de manera más moderna, angustia, rabia, decaimiento, desvalorización, vacío, malestar..., nuevas divinidades para combatir en el panteón del inconsciente que se busca.

Entonces, ¿qué es la curación?

Sin ningún aporte exterior, la piel cicatriza sus heridas, el hueso se recalcifica tras las fracturas. ¿Por qué? Porque el cuerpo está constantemente regenerándose, renovándose, excepto, tal vez, las neuronas. Tan pronto como nuestro cuerpo sufre una agresión, aparece una inflamación para poner las cosas en orden. Enquistamiento, eliminación, hemorragia, infección, calcificación son algunos de los fenómenos observados para volver al funcionamiento habitual del cuerpo.

Pero la terapia también es un fenómeno artificial. ¿A tal hora, a tal sitio, vamos a ver a un profesional para curarnos! ¡Curación bajo demanda!

El terapeuta es un **jardinero**, pone en su sitio las condiciones óptimas para permitir la germinación, floración, fructificación; las tareas son riego, poda, trabajo de la tierra. Pero en ningún caso, ¡se cree ni el sol ni la lluvia! Tampoco se toma por responsable del viento, de la polinización, del crecimiento. Él excava y, si es el momento, eso crece, eso da lo que puede dar: frutos, flores, granos, sombra, perfumes...

Esta humildad nos aleja del orgullo y de esa tensión de deber curar todo, curar todo lo que se mueve. En efecto, creer.

y hacer creer en la curación siempre, por tus medios, es un delito reprehensible y reprimido por la ley de los hombres y no concuerda con las leyes biológicas. Porque es tomarte por el cuerpo del otro, sus plaquetas, sus anticuerpos, sus capacidades de reparación. Sólo el cuerpo del enfermo cura al enfermo de su enfermedad. Y en el momento preciso: *«No abrimos una flor con los dedos»*, escribió el poeta. Su tiempo no es tu tiempo.

¿Y qué tiene que ver la descodificación en todo esto?

¡Pues bien! Tal vez, somos simplemente jardineros biológicos. Jardineros a los que les gusta, antes de nada, observar las leyes de la naturaleza e interrogarse: «¿Cómo funciona cuando funciona? ¿Qué debe ser curado? ¿El efecto o la causa? ¿El espíritu o la forma?».

La causa, clama la descodificación. ¿Y dónde encontrarla? A partir del sentido del síntoma. Sentido biológico.

Y después, ¿cuál es la intención positiva de la enfermedad? Otros terapeutas se han dado cuenta, desde luego, de que detrás de cada problema aparente se esconden una causa, una intención, un sentido. La descodificación se apoya simplemente en la vivencia específica de cada órgano. Cuando su función ya no es satisfactoria, la laringe tiembla de miedo, la vejiga se tensa, los ojos temen lo que se sitúa detrás de ellos, la piel se siente sola, el esqueleto se cree un inútil, los senos tienen un mal presentimiento, la vesícula biliar grita su cólera, los pulmones se asfixian, un bronquio reclama más espacio y libertad, y los dos pechos desconfían uno del otro.

El terapeuta es un guía de montaña

Sólo puede acompañar a una persona voluntaria allí donde ella misma ya ha estado... y de donde ha vuelto. Es un **vulcanólogo de terreno, un espeleólogo de las profundidades, un aventurero, un explorador.**

Pero no, no es un guardián de museo, un librero de viejo.

Mujer y hombre, curiosos por encima de todo, tienen una vida privada, saben aprovechar sus jornadas, tienen una exigencia de consciencia y aceptan sus carencias y el *feed-back* de la vida.

Quizás puedan, a veces, oír el cuerpo enfermo murmurar a quien quiera escucharlo:

*«Tengo ganas de alegría y de fiesta,
de respeto y de compartir,
de escucha y de ternura,
de simplicidad
y de saberme efectivamente vivo en el camino milagroso
que nos ofrecen los muertos que nos han precedido».*

El terapeuta está al servicio de aquel que osa concederle su confianza, el espacio de un instante de fragilidad entre dos momentos de potencia.



La conclusión de la conclusión...

Para aquel que sepa descodificar, cada órgano enfermo habla de forma muy precisa de aquél a quien pertenece.

Cuando el paciente tiene una patología se convierte, sin saberlo, en psico-bio-terapeuta, pues he aquí lo que nos enseña el diccionario:

La palabra *patología* quiere decir «estudio de las pasiones». La patología es «el estudio de las afecciones mórbidas»; la palabra *pathos* significa «emoción», «lo que sufrimos», es decir, lo que viene a alterar el estado normal de un ser.

«La desventura, la iniciación o bien la pasión (placer, pena, cólera, amor...) concebida como una situación que nos somete es patética, lo que crea la emoción. Este término, a veces, es el opuesto a *ergon*: el acto».



La enfermedad, ese divorcio de uno mismo, es un mensaje para ti. En primer lugar, la enfermedad te dice:

- ¡Tu cuerpo te pertenece!
- ¡Eres único!
- ¡Tienes emociones inconscientes!
- ¡Tu enfermedad te está hablando! ¡Quiere hacerte crecer en tu propia consciencia! Entonces...

*... Escucha a tu enfermedad,
¡te escucharás a ti mismo!
Acoge a tu enfermedad,
¡te acogerás a ti mismo!*

*Dé esta manera, cuando te escuches,
cuando te acojas,
¡cambiarás!
Y convirtiéndote en ti mismo,
la enfermedad desaparecerá.*

AGRADECIMIENTOS

A Pierre-Olivier Gély
Patrick Chevalier

✱

PUNTOS PEDAGÓGICOS

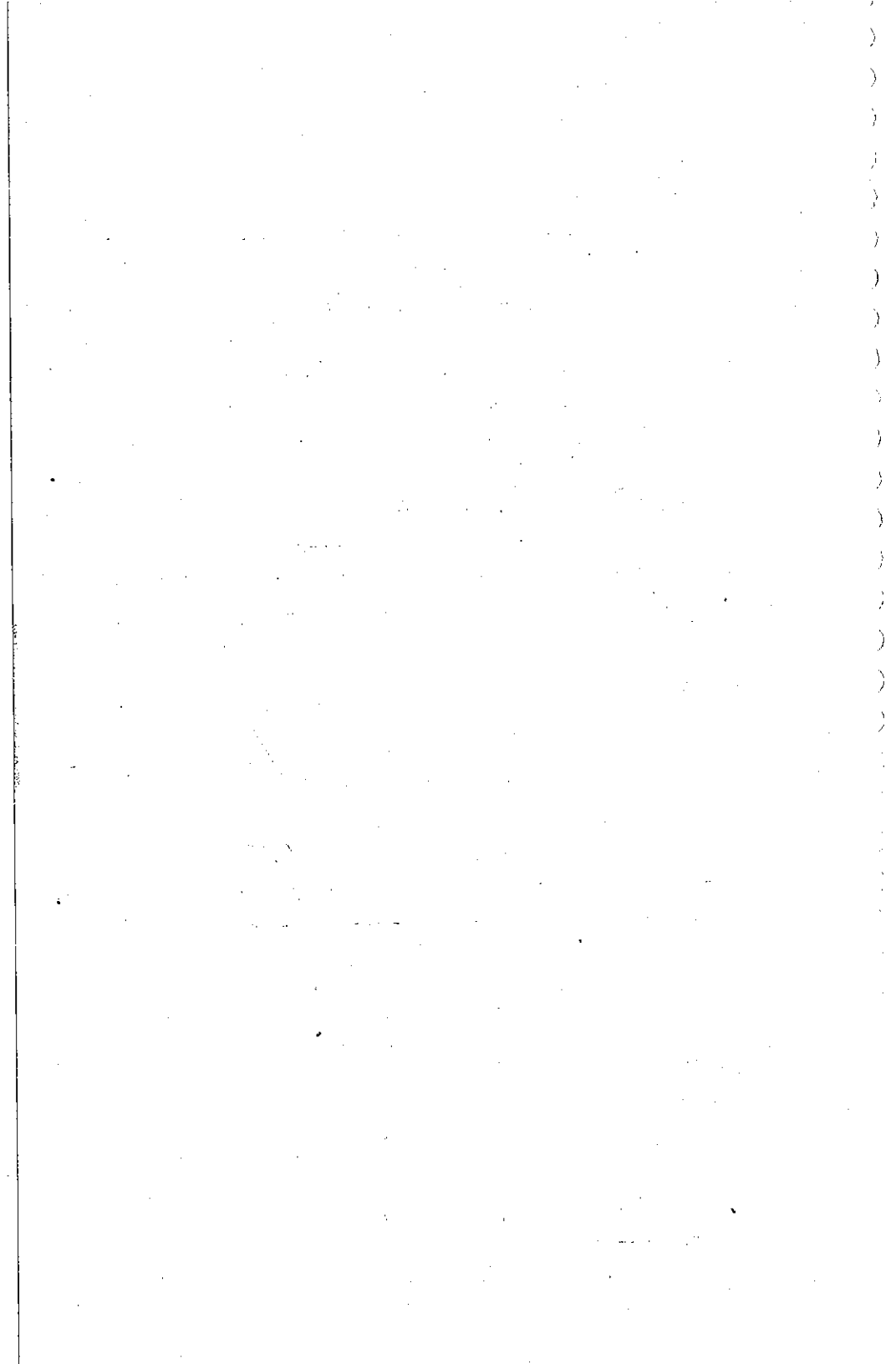
«No digas..., sino di lo siguiente»	35
Las fases de enfermedad.	84
«Cuando no puedo actuar sobre el cuerpo de los demás, actúo sobre el mío».	
Es el conflicto de identificación	89
Los órganos simples y los órganos complejos, es decir, constituidos por dos tejidos.	90
La goma y el tintero	96
En cada ser humano, el lenguaje le compromete - los predicados.	101
Hay tres maneras de vivir y de sentir un conflicto biológico.	107
Los cuatro estratos de la biología.	110
La biología hace lo que ella quiere para salir del problema	119
Todos estamos fascinados por nuestros conflictos, inconscientemente, los buscamos	128
El conflicto por identificación	130
Conflicto y presión	152
La puerta de entrada en biología	157
La inflamación	164
Un ejemplo de sentido biológico: los pólipos - poliposis	166

ÍNDICE ANALÍTICO

- ácido gástrico, 113
 aerocolia, 159, 196, 198
 aire, 13, 14, 50, 60, 98, 99,
 112, 159, 196, 197
 alergias, 97
 amígdalas, 83, 124
 angina, 84
 anictérica, 146
 ano, 37, 43, 44, 48, 49, 155,
 174, 176, 178, 179, 180
 apéndice, 36, 155, 156
 apendicitis, 156
 arterias, 13
 ascitis, 38, 128, 183, 184
 bacterias, 37
 bilis, 34, 38, 40, 41, 42, 44, 50,
 80, 142, 146
 boca, 29, 43, 44, 48, 49, 51, 52,
 57, 58, 60, 61, 62, 81, 82,
 83, 86, 87, 101, 104, 119,
 121, 134, 140, 148, 152,
 155, 157, 191
 canales, 39, 44, 90, 91, 92, 111
 cavum, 82
 ciego, 36, 44, 157, 160, 163
 colestática, 146
 cólicos, 43, 146
 colon, 26, 32, 36, 37, 44, 45,
 48, 103, 110, 128, 150,
 157, 158, 159, 161, 162,
 163, 164, 165, 166, 167,
 168, 169, 170, 172, 174,
 184, 185, 188, 189, 191,
 198
 coma, 191
 Crohn, 49, 149, 164, 169
 deglución, 30, 42, 76, 77
 dentina, 66, 67, 69, 71, 91
 diabetes, 144
 diarrea, 43, 193
 dientes, 27, 29, 56, 57, 59, 62,
 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69,
 70, 71, 72, 73, 74, 75, 91,
 191
 duodeno, 34, 44, 47, 48, 80,
 118, 122, 123, 144, 186
 edema, 150
 embriología, 43
 encía, 59
 enfermedad de Crohn, 49, 164
 epiglotis, 30, 75
 epiplón, 38, 43, 185
 esfínter, 144, 160
 esmalte, 66, 67, 68, 71, 91
 esófago, 26, 29, 30, 31, 32, 44,
 47, 94, 95, 96, 100, 101,
 104, 105, 106, 109, 157
 estenosis, 118

- estómago, 13, 14, 15, 26, 27, 31, 32, 33, 41, 42, 44, 45, 48, 55, 80, 89, 91, 96, 102, 105, 106, 108, 109, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 122, 156, 186
 estreñimiento, 43, 176, 189, 190
 faringe, 26, 29, 30, 31, 77, 83
 fiebre, 42, 93, 120
 gingivitis, 73
 glándula salival, 88, 89, 92, 93, 94
 glotis, 30, 75, 212
 Gougerot-Sjögren, 86
 hemorragia, 129, 158, 202
 hemorragias, 121, 127, 164, 169, 171, 176, 178
 hemorroides, 11, 103, 174, 175, 177
 hepáticos, 145, 146, 197
 hepatitis, 142, 143, 146
 hernia de hiato, 108
 hierro, 28, 40, 127, 129, 130
 hígado, 26, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 48, 64, 89, 98, 110, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 139, 143, 146, 152, 168, 182, 183
 hiperglucemia, 42
 hormona, 33
 hueso, 14, 15, 29, 56, 59, 66, 71, 91, 202
 ictericia, 143
 íleon, 34, 48, 147, 149
 infección, 154, 158, 200, 202
 inflamación, 43, 77, 158, 163, 164, 179, 198, 202, 208
 intestino, 26, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 124, 125, 129, 139, 147, 148, 150, 151, 154, 158, 163, 164, 169, 182, 185, 189, 193
 labios, 18, 29, 52, 62
 Langerhans, 41
 lengua, 29, 30, 45, 47, 79, 81, 165, 169
 litiasis, 145
 mandíbula, 29, 54, 55, 56, 57, 58, 59
 mesotelioma, 181
 migrañas, 107
 motricidad, 34, 42, 187, 196
 mucosa, 15, 29, 32, 34, 37, 49, 68, 94, 111, 112, 119, 148, 150, 158, 159, 160, 165, 172, 176
 músculo, 77, 79, 91
 náuseas, 108
 oclusión, 43, 150, 176
 páncreas, 26, 38, 41, 43, 44, 48, 102, 132, 133, 138, 139, 144, 147
 parálisis, 11, 49, 150, 158, 160, 187, 188
 parótida, 86, 87, 88, 92
 perforación, 119
 peritoneo, 32, 33, 38, 43, 44, 160, 181, 182, 184
 peritonitis, 167
 píloro, 32, 116, 118, 119, 212

predicado, 101, 102	saliva, 30, 39, 50, 77, 89, 152
puerta, 6, 83, 96, 103, 109,	sigmoide, 36, 44, 51, 64, 157,
113, 118, 134, 136, 157,	161, 165, 167, 170, 175
176, 208	úlceras, 15, 176
quiste, 56	úvula, 75, 76, 77
recto, 26, 32, 37, 44, 64, 117,	varices, 159
141, 157, 160, 161, 162,	vómitos, 108, 186, 195
170, 171, 172, 174, 175,	yeyuno, 34, 48, 147
176, 177, 187	

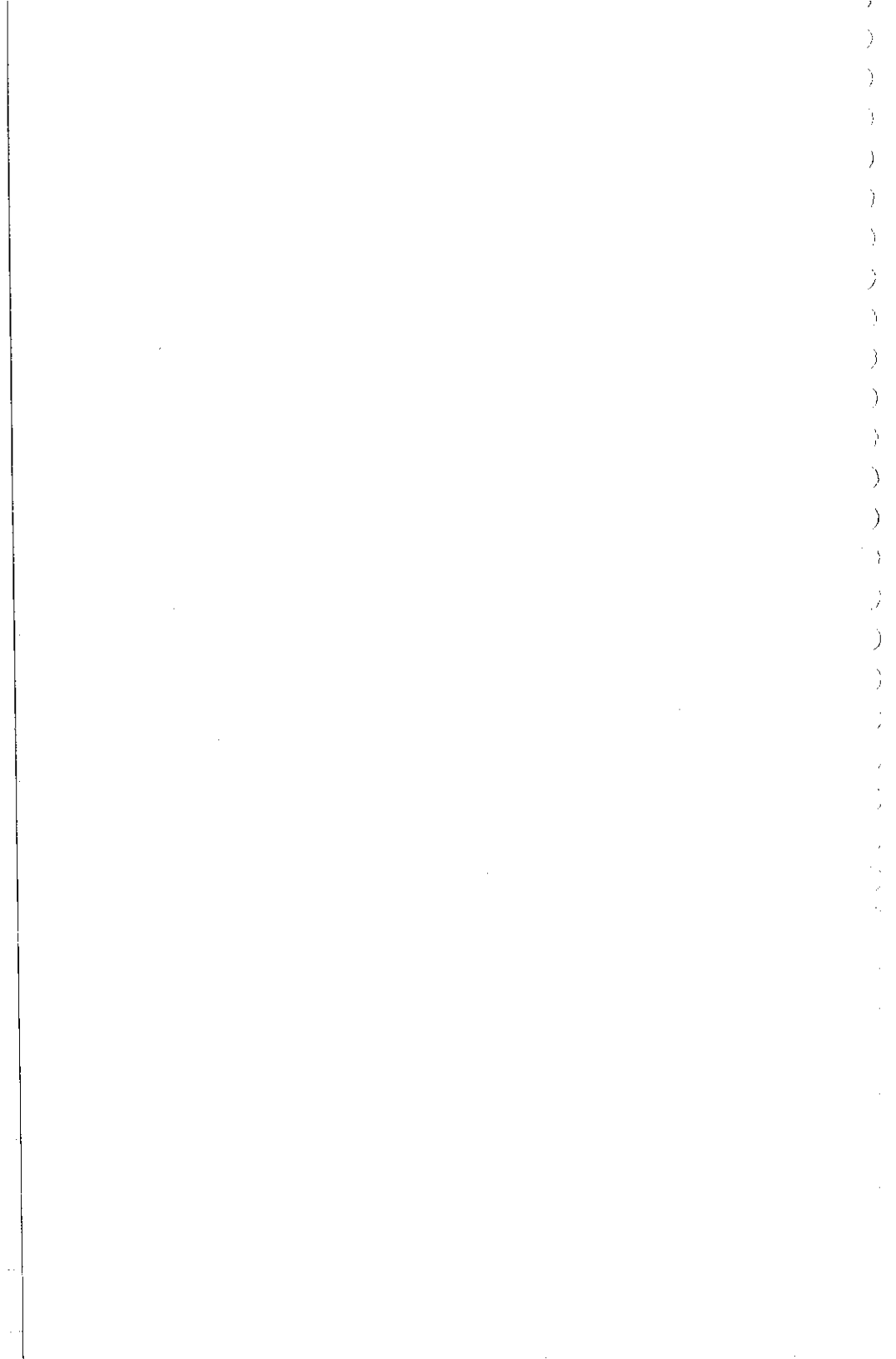


ÍNDICE

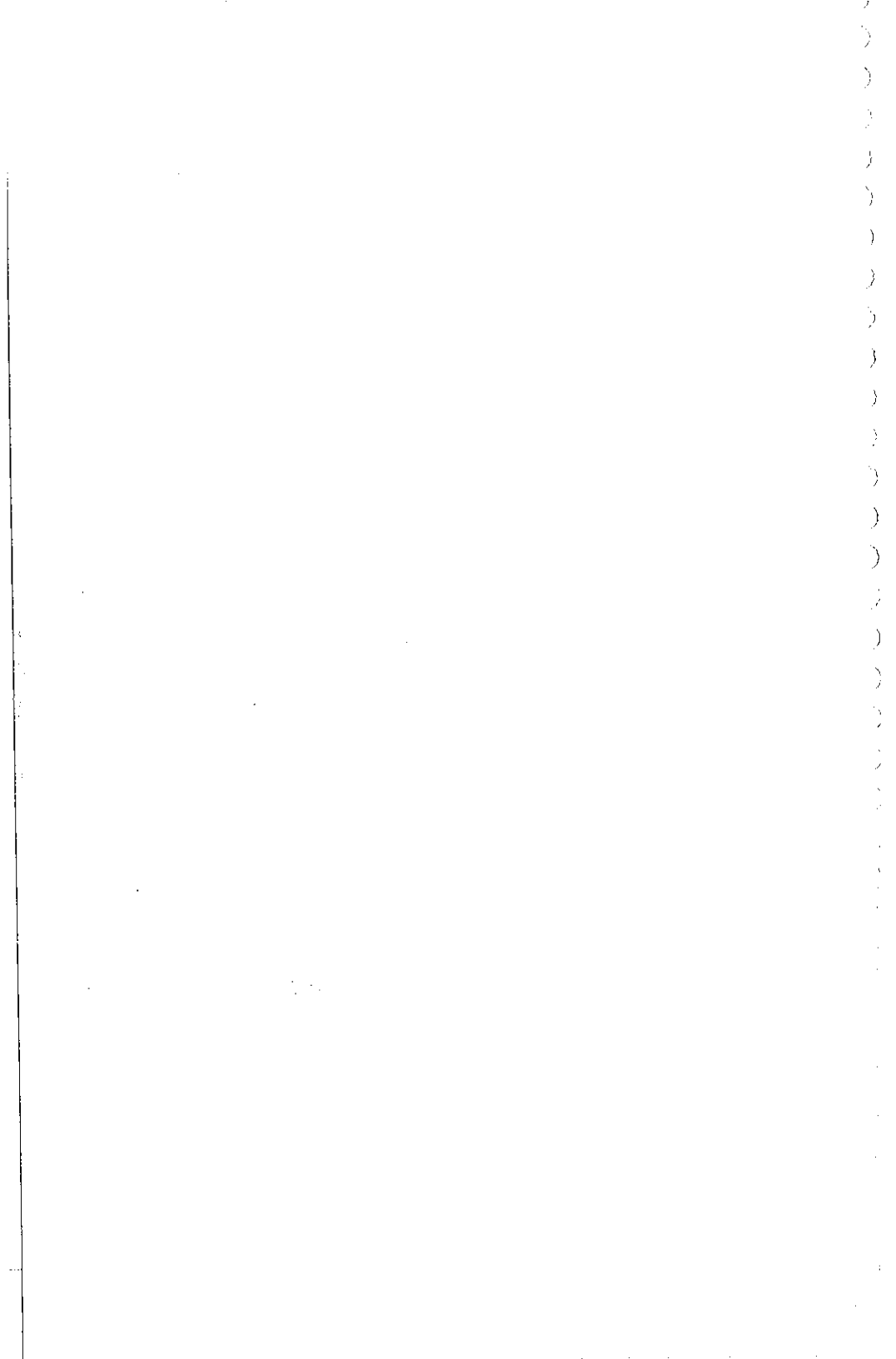
Introducción	9
Generalidades	25
Anatomía	25
Fisiología	26
Las vías digestivas superiores.	29
La boca	29
Los dientes	29
Las glándulas salivales	30
La lengua.	30
La faringe	31
El esófago	31
Las vías digestivas inferiores	32
El estómago	32
El intestino delgado	33
El intestino grueso o colon	36
El recto	37
El peritoneo.	38
Las glándulas anexas.	38
Las glándulas salivales	39
El hígado	39
La bilis.	40
El páncreas	41
El sistema nervioso digestivo	42
Embriología.	43
Las patologías	43
Resumen	44
Conflictología	45
La submucosa de la boca	51

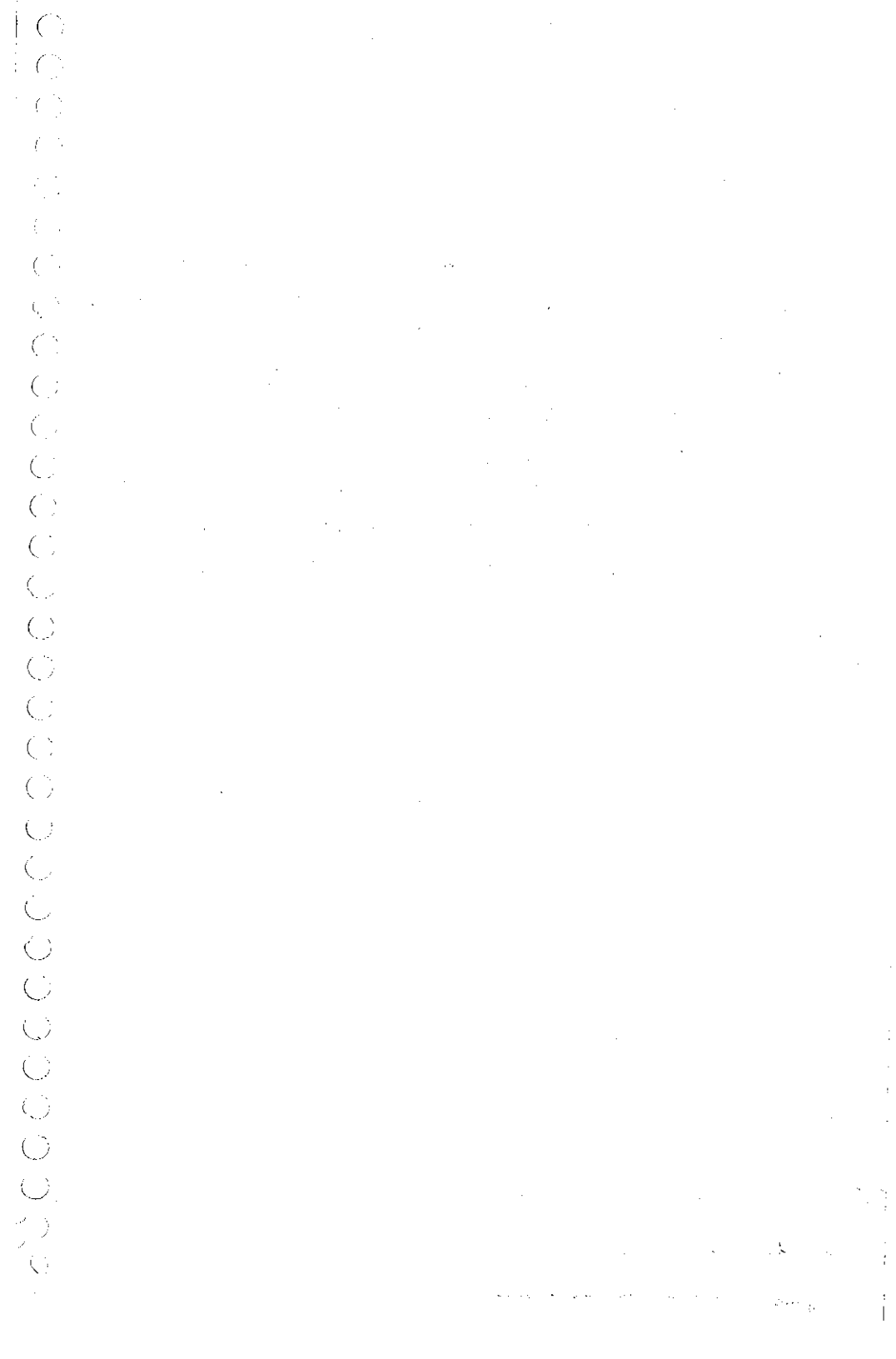
Los huesos de la mandíbula	54
El paladar	60
Los dientes	62
La dentina	66
El esmalte de los dientes	68
Las encías	72
La glotis, la epiglotis, la úvula (campanilla)	75
La lengua	79
La boca y su diversidad	81
La faringe, las amígdalas	83
Las glándulas salivales: la glándula	85
Las glándulas salivales: los canales	90
El esófago: parte superior	94
El esófago: parte inferior	96
El estómago: curvatura mayor	106
El estómago (curvatura menor), el bulbo duodenal, el píloro	116
El duodeno (exceptuando el bulbo)	122
El hígado: parénquima	124
El páncreas	132
Las vías biliares y pancreáticas	141
El intestino delgado: yeyuno, íleon	147
El apéndice	155
El colon/el ciego	157
El recto superior/sigmoide	170
El recto inferior	172
El ano	178
El peritoneo	181
El epiplón mayor	185
Los vómitos	186
El estreñimiento	187
Las diarreas	192
El aire	196

Conclusión.....	199
Agradecimientos	207
Puntos pedagógicos.....	208
Índice analítico	209



**DESCODIFICACIÓN BIOLÓGICA
DE LOS PROBLEMAS DIGESTIVOS**





**¿Y si el estreñimiento, la diarrea, los cólicos,
o incluso los vómitos, revelaran ciertos conflictos
emocionales enterrados?**

**Christian Flèche nos ofrece una guía práctica de los problemas
digestivos analizados desde la perspectiva de la descodificación
biológica. Según este enfoque de la salud, cada síntoma corres-
ponde a un sentimiento, a una emoción bloqueada.**

**La obra describe detalladamente los diferentes órganos
y sus funciones, para dibujar después el panorama de las re-
laciones entre emociones y síntomas. En ella encontrarás la
descripción de las diferentes sensaciones biológicas, así como
numerosos ejemplos y claves para resolver los conflictos emo-
cionales con los que uno se enfrenta.**

**¡Descubre el significado oculto de tus dolencias
y retoma el camino de la salud!**

EDICIONES OBELISCO

978-84-16192-65-6



9 788416 119265

PVP 11 €